

PRESCRIÇÃO PEDIÁTRICA SEGURA

Manual integral de configuração clínica, farmacêutica, funcional e técnica

Versão consolidada · 15 de agosto de 2026

Dr. Iago Vildete Almeida · CRM-MG 87901

Escopo documentado: 315 diagnósticos e síndromes · 265 medicamentos · 577 linhas farmacológicas · 391 indicações catalogadas

Documento técnico para reconstrução, auditoria e evolução do projeto. Não substitui avaliação clínica individual, bula vigente, protocolo institucional, checagem de alergias, função renal/hepática, interações ou julgamento médico.

1. Finalidade e princípios

- Ferramenta profissional em português brasileiro para cálculo por peso, seleção múltipla de tratamentos e emissão de orientação domiciliar em linguagem simples.
- A seleção ampla não autoriza polifarmácia: cada opção deve ser classificada como primeira linha, alternativa, adjuvante, condicionada, hospitalar ou off-label.
- Toda concentração, equivalência em gotas, idade mínima, máximo e apresentação deve permanecer bloqueada quando não validada.

2. Hierarquia de fontes

- Prioridade: protocolos de Belo Horizonte/RMBH; SES-MG; Sociedade Brasileira de Pediatria; Ministério da Saúde; Anvisa e bulas oficiais; sociedades brasileiras; diretrizes internacionais e literatura primária quando necessário.
- Fontes históricas servem para localização e comparação, nunca como confirmação isolada de mercado, dose ou segurança.
- Revisão externa verificada em 15/08/2026. Referências principais: protocolo SUS-BH de OMA; SBP; Anvisa; documentos clínicos incorporados ao projeto.

3. Correção clínica sobre corticoides

- Otite média aguda: corticoide sistêmico não é tratamento rotineiro. Corticoide intranasal somente pode aparecer como opção condicionada quando houver rinite alérgica, obstrução nasal ou outra comorbidade nasal com indicação própria; não trata a OMA.
- Rinossinusite bacteriana aguda: corticoide intranasal pode ser adjuvante em pacientes selecionados, sobretudo com rinite/obstrução; benefício é modesto e não substitui antibiótico quando indicado. Corticoide sistêmico não é rotina.
- O sistema deve explicar por que a opção é condicionada e impedir seleção automática.

4. Motor de elegibilidade contextual

- Entradas mínimas: diagnóstico, peso, idade, indicação clínica e apresentação disponível.
- Excluir opções incompatíveis com idade/peso, explicitamente desaconselhadas no protocolo, sem cálculo pediátrico validado ou sem correspondência clínica.
- Sintomas e comorbidades não informados não podem ser presumidos. Opções dependentes devem aparecer como condicionais e permanecer desmarcadas.

5. Apresentações múltiplas

- A escolha de apresentação pertence ao mesmo princípio ativo e deve recalcular volume, gotas ou unidades sem modificar a dose clínica original.
- Dipirona: gotas 500 mg/mL; soluções orais 100 e 50 mg/mL; supositório pediátrico 300 mg apenas em faixa compatível e sem fracionamento.
- Paracetamol: 200, 140, 100 e 32 mg/mL conforme produto validado. Ibuprofeno: 100, 50 e 20 mg/mL. Ondansetrona: solução oral 4 mg/5 mL e comprimidos/ODT 4 ou 8 mg em casos selecionados. Não inferir gotas/mL sem bula específica.

6. Tripla checagem e checagem reversa

- Matemática: dose ponderal $\times$ peso, aplicação de máximos e arredondamento auditável.
- Farmacêutica: apresentação, concentração e conversão independente.
- Clínica: indicação, idade, intervalo, duração, máximos, contraindicações, interações e ajustes.
- Reversa: volume $\times$ concentração = dose; dose $\div$ peso = mg/kg/dose; multiplicar pela frequência para mg/kg/dia.

7. Prévia consolidada

- Campos: diagnóstico, peso, idade, data em America/Sao_Paulo, vias aplicáveis, medicamentos numerados, apresentação escolhida, quantidade, intervalo, horários, duração, indicação, orientação, evolução, sinais de alarme e retorno.
- Todas as seleções devem aparecer. Estratégias não farmacológicas ficam em seção própria; itens hospitalares ficam separados da receita domiciliar.

8. Segurança e governança

- Nunca preencher alergias, comorbidades ou achados ausentes. Alta vigilância exige dupla checagem humana.
- Toda alteração clínica relevante deve registrar data, fonte, justificativa, escopo e validação.
- Protocolos genéricos do catálogo ampliado não recebem medicação automática até revisão individual documentada.

9. Regras operacionais detalhadas

1. Seleção múltipla sem duplicidade terapêutica automática.
2. Troca de peso, idade ou apresentação recalcula a prévia.
3. Itens condicionais exibem a condição clínica necessária.
4. Off-label exige rótulo explícito, justificativa, evidência e registro.
5. Não usar antibiótico, corticoide, broncodilatador, mucolítico, antitussígeno, antiemético ou probiótico por rotina.
6. Via retal deve ser separada de via oral.
7. Supositórios não devem ser fracionados.
8. Em líquidos, usar seringa dosadora; gotas somente com equivalência validada.
9. Evitar apresentações adultas quando houver formulação pediátrica adequada.
10. Emergências separam ABCDE e terapias hospitalares da alta domiciliar.
11. Exibir máximos absolutos somente quando sustentados.
12. Função renal/hepática e interações devem ser verificadas antes da finalização.
13. A lista ampla representa possibilidades avaliáveis, não uma receita automática.

10. Catálogo de diagnósticos e síndromes

Os itens abaixo compõem o catálogo solicitado. Inclusão no catálogo não equivale a protocolo farmacológico individualmente validado. Entradas genéricas permanecem sob bloqueio clínico até revisão específica.

001. Otite média aguda
002. Sinusite bacteriana aguda
003. Faringoamigdalite estreptocócica
004. Crupe / laringotraqueíte
005. Pneumonia adquirida na comunidade
006. Nasofaringite viral aguda
007. Bronquiolite viral aguda
008. Infecção urinária na criança
009. Gastroenterite aguda
010. Constipação intestinal funcional
011. Escabiose
012. Pediculose do couro cabeludo
013. Exacerbação aguda de asma
014. Anafilaxia
015. Rinite alérgica
016. Urticária aguda
017. Dermatite atópica
018. Impetigo
019. Celulite não purulenta
020. Candidíase oral
021. Enterobíase
022. Otite externa aguda
023. Conjuntivite aguda
024. Celulite pré-septal
025. Epistaxe
026. Síndrome gripal / influenza
027. Coqueluche
028. Lactente febril <90 dias
029. Seps e choque séptico
030. Meningite bacteriana
031. Convulsão febril
032. Estado de mal epiléptico
033. Enxaqueca / cefaleia primária
034. Traumatismo cranioencefálico
035. Hipoglicemia sintomática
036. Cetoacidose diabética
037. Apendicite aguda

- 038. Invaginação intestinal
- 039. Estenose hipertrófica do piloro
- 040. Dengue
- 041. Doença de Kawasaki
- 042. Crise vaso-oclusiva falciforme
- 043. Neutropenia febril
- 044. Queimadura térmica
- 045. Intoxicação por paracetamol
- 046. Ingestão de cáustico
- 047. Corpo estranho em via aérea
- 048. Torção testicular
- 049. Abscesso cutâneo
- 050. Mordedura de cão/gato/humana
- 051. Emergência hipertensiva
- 052. Lesão renal aguda
- 053. Parada cardiorrespiratória
- 054. Desidratação
- 055. Náuseas e vômitos
- 056. Hemorragia digestiva
- 057. Taquicardia supraventricular
- 058. Miocardite / pericardite
- 059. Síncope
- 060. Síndrome nefrótica
- 061. Glomerulonefrite aguda
- 062. Rabdomiólise / miosite viral
- 063. Parafimose
- 064. Afogamento
- 065. Acidente elétrico
- 066. Escorpionismo
- 067. Acidente ofídico
- 068. Adenite cervical aguda
- 069. Artrite séptica
- 070. Balanite e balanopostite
- 071. Celulite orbitária
- 072. Doença mão-pé-boca
- 073. Estomatite herpética primária
- 074. Febre sem foco em criança
- 075. Herpangina
- 076. Mastoidite aguda
- 077. Mononucleose infecciosa
- 078. Osteomielite aguda

- 079. Púrpura por IgA
- 080. Síndrome hemolítico-urêmica
- 081. Infecção de Vias Aéreas Superiores (IVAS)
- 082. Resfriado Comum
- 083. Faringite Aguda
- 084. Amigdalite Aguda
- 085. Faringoamigdalite Bacteriana
- 086. Faringoamigdalite Viral
- 087. Otite Média Aguda (OMA)
- 088. Otite Média Efusiva
- 089. Sinusite Aguda (Rinosinusite Bacteriana Aguda)
- 090. Laringotraqueobronquite Aguda (Crupe Viral)
- 091. Laringite Estridulosa (Crupe Espasmódico)
- 092. Epiglotite Aguda
- 093. Traqueíte Bacteriana
- 094. Crise de Asma Leve
- 095. Crise de Asma Moderada
- 096. Broncoespasmo Agudo
- 097. Hiperreatividade Brônquica
- 098. Bronquiolite Viral Aguda (BVA)
- 099. Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC)
- 100. Pneumonia Viral
- 101. Pneumonia Bacteriana Não Complicada
- 102. Bronquite Aguda
- 103. Infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR)
- 104. Influenza (Gripe)
- 105. Coqueluche (Síndrome Coqueluchoide)
- 106. Abscesso Periamigdaliano
- 107. Abscesso Retrofaringeo
- 108. Insuficiência Respiratória Aguda (IRpA)
- 109. Insuficiência Respiratória Tipo 1 (Hipoxêmica)
- 110. Insuficiência Respiratória Tipo 2 (Hipercápnica)
- 111. Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA)
- 112. Bronquiolite Viral Aguda Grave
- 113. Estado de Mal Asmático (Asma Aguda Grave Refratária)
- 114. Pneumonia Grave com Derrame Pleural
- 115. Empiema Pleural
- 116. Abscesso Pulmonar
- 117. Atelectasia Pulmonar Massiva
- 118. Pneumotórax Espontâneo
- 119. Pneumotórax Hipertensivo

- 120. Hemotórax
- 121. Quilotórax
- 122. Quase-Sufocamento / Aspiração de Corpo Estranho em Via Aérea Inferior
- 123. Edema Agudo de Pulmão
- 124. Síndrome de Aspiração Meconial
- 125. Hemorragia Alveolar Difusa
- 126. Displasia Broncopulmonar Agudizada
- 127. Apneia da Prematuridade / Apneia Obstrutiva Grave
- 128. Choque Séptico
- 129. Sepses Grave
- 130. Disfunção Orgânica Múltipla Associada à Sepses
- 131. Choque Hipovolêmico por Desidratação
- 132. Choque Hipovolêmico Hemorrágico
- 133. Choque Anafilático
- 134. Choque Cardiogênico
- 135. Choque Obstrutivo
- 136. Miocardite Aguda
- 137. Pericardite Aguda
- 138. Tamponamento Cardíaco
- 139. Endocardite Infecciosa Aguda
- 140. Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) Descompensada
- 141. Taquicardia Supraventricular Instável (TSV)
- 142. Taquicardia Ventricular (TV)
- 143. Fibrilação Ventricular (FV)
- 144. Bloqueio Atrioventricular Total (BAVT)
- 145. Bradicardia Sintomática Grave
- 146. Crise Hipertensiva na Infância (Urgência e Emergência)
- 147. Cardiopatia Congênita Cianótica em Crise de Hipóxia (Crise de Hipercianose)
- 148. Cardiopatia Congênita Acianótica Descompensada
- 149. Cor Pulmonale Agudo
- 150. Tromboembolismo Pulmonar (TEP)
- 151. Parada Cardiorrespiratória (PCR) Reanimada
- 152. Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica Pós-PCR
- 153. Gastroenterite Aguda (GECA) Viral
- 154. Gastroenterite Aguda Bacteriana
- 155. Desidratação Leve (Grau I)
- 156. Desidratação Moderada (Grau II)
- 157. Constipação Intestinal Crônica Agudizada
- 158. Fecaloma
- 159. Dor Abdominal Aguda a Esclarecer
- 160. Gastrite Aguda

161. Refluxo Gastroesofágico Descompensado
162. Cólica do Lactente Aguda
163. Apendicite Aguda Inicial
164. Adenite Mesentérica
165. Estomatite Aftosa Recorrente / Gengivostomatite Herpética Aguda
166. Parasitose Intestinal Agudizada
167. Intolerância Alimentar Aguda
168. Apendicite Aguda Complicada / Peritonite Difusa
169. Intussuscepção Intestinal (Invaginação Intestinal)
170. Volvo de Intestino
171. Hérnia Incarcerada / Hérnia Estrangulada
172. Divertículo de Meckel Complicado
173. Obstrução Intestinal por Brida
174. Megacólon Tóxico
175. Pancreatite Aguda Pediátrica
176. Insuficiência Hepática Aguda Grave (IHAG)
177. Encefalopatia Hepática
178. Hemorragia Digestiva Alta (HDA) — Varizes Esofágicas ou Úlcera
179. Hemorragia Digestiva Baixa (HDB) Grave
180. Perfuração de Viscera Oca
181. Colecistite Aguda
182. Síndrome Compartimental Abdominal
183. Síndrome Febril
184. Febre Sem Sinal Localizatório (FSSL)
185. Bacteremia Oculta
186. Infecção do Trato Urinário Inferior (Cistite)
187. Pielonefrite Aguda Não Complicada
188. Pielonefrite Aguda Grave com Seps
189. Glomerulonefrite Difusa Aguda (GNDA) Pós-Estreptocócica
190. Insuficiência Renal Aguda (IRA) / Lesão Renal Aguda (LRA)
191. Síndrome Hemolítico-Urêmica (SHU)
192. Necrose Tubular Aguda (NTA)
193. Retenção Urinária Aguda
194. Litíase Renal / Cólica Nefrética
195. Arbovirose — Dengue Clássica
196. Arbovirose — Dengue com Sinais de Alarme
197. Dengue Grave (Choque por Dengue)
198. Zika Vírus Agudo
199. Chikungunya — Fase Aguda
200. Febre Amarela
201. Malária Pediátrica

- 202. Varicela (Catapora) Não Complicada
- 203. Varicela Hemorrágica ou Complicada com Infecção Secundária
- 204. Escarlatina
- 205. Síndrome Mão-Pé-Boca
- 206. Erisipela
- 207. Celulite Infecciosa Periorbitária (Pré-Septal)
- 208. Celulite Orbitária (Pós-Septal)
- 209. Fascíte Necrosante
- 210. Abscesso Cutâneo / Furunculose
- 211. Síndrome do Choque Tóxico Estafilocócico / Estreptocócico
- 212. Crise Convulsiva Febril Simples
- 213. Crise Convulsiva Febril Complexa
- 214. Crise Convulsiva Afebril Inicial
- 215. Estado de Mal Epiléptico Convulsivo
- 216. Estado de Mal Epiléptico Não Convulsivo
- 217. Meningite Bacteriana Aguda
- 218. Meningite Viral / Asséptica
- 219. Meningococemia sem Meningite
- 220. Encefalite Viral Aguda
- 221. Hipertensão Intracraniana (HIC) Aguda
- 222. Herniação Cerebral Aguda
- 223. Coma de Causa a Esclarecer
- 224. Cefaleia Tensional Aguda
- 225. Crise de Enxaqueca / Migrânea com ou sem Aura
- 226. Acidente Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico Pediátrico
- 227. Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico / Hemorragia Intracraniana Espontânea
- 228. Trombose Venosa Cerebral
- 229. Síndrome de Guillain-Barré com Insuficiência Respiratória
- 230. Miastenia Gravis Juvenil em Crise Miastênica
- 231. Ataxia Cerebelar Aguda
- 232. Abscesso Cerebral
- 233. Mielite Transversa Aguda
- 234. Cetoacidose Diabética (CAD) Leve a Moderada
- 235. Cetoacidose Diabética (CAD) Grave com Edema Cerebral
- 236. Hipoglicemia Aguda Sintomática
- 237. Hipernatremia Grave
- 238. Hiponatremia Grave com Sintomas Neurológicos
- 239. Hipercalcemia Grave com Repercussão Eletrocardiográfica
- 240. Hipocalcemia Grave
- 241. Hipercalcemia Crítica
- 242. Hipocalcemia Aguda (Tetania)

- 243. Acidose Metabólica Grave Refratária
- 244. Alcalose Metabólica / Respiratória Grave
- 245. Insuficiência Adrenal Aguda (Crise Addisoniana / Síndrome de Waterhouse-Friderichsen)
- 246. Crise Tireotóxica (Tempestade Tireoidiana)
- 247. Hipotireoidismo Congênito Descompensado / Coma Mixedematoso
- 248. Erro Inato do Metabolismo em Crise de Descompensação Aguda (Hiperamonemia, Acidemia Orgânica)
- 249. Intoxicação Exógena Aguda Acidental
- 250. Intoxicação Exógena Aguda por Tentativa de Autoextermínio
- 251. Intoxicação por Medicamentos (Paracetamol, Anticonvulsivantes, Antidepressivos, Opiáceos)
- 252. Intoxicação por Domissanitários (Saneantes, Cáusticos, Ácidos/Álcalis)
- 253. Envenenamento por Organofosforados / Carbamatos (Chumbinho)
- 254. Intoxicação por Monóxido de Carbono ou Inalação de Fumaça
- 255. Acidente por Escorpião (Escorpionismo) Leve
- 256. Acidente por Escorpião Moderado a Grave
- 257. Acidente Ofídico Botrópico (Jararaca)
- 258. Acidente Ofídico Crotálico (Cascavel)
- 259. Acidente Ofídico Elapídico (Coral)
- 260. Acidente por Loxosceles (Aranha-Marrom)
- 261. Acidente por Phoneutria (Aranha-Armadeira)
- 262. Politraumatismo Grave
- 263. Traumatismo Cranioencefálico (TCE) Leve com Sintomas
- 264. Traumatismo Cranioencefálico (TCE) Moderado
- 265. Traumatismo Cranioencefálico (TCE) Grave com PIC Elevada
- 266. Trauma Torácico Fechado / Contusão Pulmonar
- 267. Trauma Abdominal Fechado com Lesão de Víscera Maciça (Fígado, Baço)
- 268. Afogamento Grau 1 a 6
- 269. Quase-Afogamento com Parada Respiratória
- 270. Queimadura Térmica de 1º Grau
- 271. Queimadura Térmica de 2º Grau — Pequena Extensão
- 272. Queimadura de 3º Grau / Grande Queimado
- 273. Queimadura Química
- 274. Queimadura Elétrica / Eletrocussão de Alta Voltagem
- 275. Intermação / Hipertermia Maligna
- 276. Hipotermia Acidental Grave
- 277. Violência Física Doméstica contra a Criança / Síndrome do Bebê Sacudido
- 278. Abuso Sexual Agudo
- 279. Corpo Estranho em Conduto Auditivo Externo
- 280. Corpo Estranho em Fossa Nasal
- 281. Corpo Estranho em Orofaringe / Esôfago
- 282. Ferimento Cortocontuso Necessitando de Sutura
- 283. Contusão Musculoesquelética / Entorse

- 284. Fratura de Ossos Longos Fechada
- 285. Fratura Exposta
- 286. Subluxação da Cabeça do Rádio (Prono Doloroso)
- 287. Anemia Aguda Grave por Sangramento
- 288. Anemia Falciforme em Crise Álgica (Crise Vaso-Oclusiva)
- 289. Anemia Falciforme com Síndrome Torácica Aguda
- 290. Anemia Falciforme em Crise de Sequestro Esplênico Agudo
- 291. Anemia Falciforme com Crise Aplásica
- 292. Crise Hemolítica Aguda (G6PD)
- 293. Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI) com Sangramento Ativo
- 294. Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculite por IgA) com Complicação Abdominal ou Renal
- 295. Doença de Kawasaki em Fase Aguda
- 296. Neutropenia Febril em Paciente Oncológico
- 297. Síndrome de Lise Tumoral Aguda (SLT)
- 298. Síndrome da Veia Cava Superior / Compressão de Via Aérea por Massa Mediastinal
- 299. Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD)
- 300. Hemofilia A ou B com Hemartrose ou Sangramento de SNC
- 301. Reação Transfusional Aguda (Hemolítica, Anafilática ou TRALI)
- 302. Imunodeficiência Primária Manifestada por Infecção Grave
- 303. Angioedema sem Insuficiência Respiratória
- 304. Angioedema com Obstrução de Via Aérea
- 305. Farmacodermia Grave — Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ)
- 306. Necrólise Epidérmica Tóxica (NET)
- 307. Síndrome da Pele Escaldada Estafilocócica
- 308. Eczema Atópico Sobreinfectado (Eczema Herpético)
- 309. Dermatite de Contato Agudizada
- 310. Pós-Operatório de Neurocirurgia (Ressecção de Tumor, Derivação Ventricular)
- 311. Pós-Operatório de Cirurgia Cardíaca com Circulação Extracorpórea
- 312. Pós-Operatório de Transplante Hepático / Renal Pediátrico
- 313. Pós-Operatório de Cirurgia Torácica de Grande Porte
- 314. Pós-Operatório de Escoliose / Cirurgia de Coluna Espinal Complexa
- 315. Choque Pós-Operatório Refratário

11. Inventário farmacológico integral

Reprodução estruturada das linhas farmacológicas cadastradas. Cada linha deve ser confrontada com bula vigente e protocolo aplicável antes de habilitar cálculo ou prescrição.

001. Acebrofilina

Indicação	Broncoespasmo — terapia adjuvante selecionada, não de primeira linha
Via	VO ou EV conforme fármaco/produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Janela terapêutica estreita para xantinas; revisar interações, arritmia, convulsão e níveis quando aplicável
Situação	Referência documental; benefício-risco e papel atual devem ser confirmados
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

002. Acetilcisteína

Indicação	Intoxicação por paracetamol — antídoto
Via	EV ou VO
Apresentação	Apresentação EV/VO variável; confirmar concentração do produto
Dose	Regime de ataque e manutenção específico; usar nomograma/protocolo toxicológico
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Esquema contínuo por etapas; duração guiada por paracetamol, AST/ALT, INR e evolução
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Risco de reação anafilactoide EV; não atrasar quando indicação definida; consultar CIATox
Situação	Esquema depende de protocolo, tempo e via; selecionar o regime antes de calcular
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

003. Acetilcisteína

Indicação	Secreção respiratória espessa — uso mucolítico apenas quando individualmente indicado
Via	VO ou inalatória conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Pode aumentar volume de secreções/broncoespasmo; contraindicações e idade mínima variam por produto
Situação	Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; resposta depende da idade e apresentação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

004. Aciclovir

Indicação	Encefalite por HSV — tratamento hospitalar
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola; concentração reconstituída varia por produto
Dose	Selecionar faixa neonatal versus criança/adolescente e protocolo de SNC
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Ajustar função renal; hidratação e infusão adequada reduzem risco de nefrotoxicidade
Situação	Dose varia por idade e pode usar mg/kg ou mg/m ² ; selecionar a faixa etária
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

005. Aciclovir

Indicação	Infecção disseminada por HSV — tratamento hospitalar
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola; concentração reconstituída varia por produto
Dose	Selecionar faixa neonatal versus criança/adolescente e protocolo de SNC
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Ajustar função renal; hidratação e infusão adequada reduzem risco de nefrotoxicidade
Situação	Dose varia por idade e pode usar mg/kg ou mg/m ² ; selecionar a faixa etária
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

006. Aciclovir

Indicação	Infecção por HSV — tratamento conforme idade, gravidade e imunidade
Via	VO ou EV conforme cenário
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Ajustar função renal; hidratação e monitorização renal na via EV
Situação	Dose e unidade podem ser mg/kg ou mg/m ² ; selecionar síndrome e faixa etária antes de calcular
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

007. Aciclovir

Indicação	Varicela — tratamento conforme idade, gravidade e imunidade
Via	VO ou EV conforme cenário
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Ajustar função renal; hidratação e monitorização renal na via EV
Situação	Dose e unidade podem ser mg/kg ou mg/m ² ; selecionar síndrome e faixa etária antes de calcular
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

008. Ácido acetilsalicílico (Aspirina)

Indicação	Antiagregação após fase aguda da doença de Kawasaki
Via	VO
Apresentação	Apresentação brasileira variável; confirmar produto e concentração com registro vigente na Anvisa
Dose	Dose antiagregante depende do protocolo; não automatizada nesta linha
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Risco de sangramento e síndrome de Reye; suspender/ajustar conforme infecção viral e orientação especializada
Situação	Uso pediátrico específico sob protocolo/cardiopediatria
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

009. Ácido acetilsalicílico (Aspirina)

Indicação	Doença de Kawasaki — antiagregação plaquetária
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Risco de sangramento e síndrome de Reye; dose varia entre fase inflamatória e antiagregante
Situação	Uso pediátrico específico; não usar como antitérmico em virose
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

010. Ácido acetilsalicílico (Aspirina)

Indicação	Doença de Kawasaki — fase inflamatória aguda
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Risco de sangramento e síndrome de Reye; dose varia entre fase inflamatória e antiagregante
Situação	Uso pediátrico específico; não usar como antitérmico em virose
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

011. Ácido fusídico

Indicação	Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

012. Ácido fusídico

Indicação	Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

013. Ácido mefenâmico

Indicação	Dor/inflamação ou indicação especializada — uso condicionado à idade e ao diagnóstico
Via	VO, retal ou tópica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Evitar em desidratação, doença renal, sangramento GI e dengue; AAS não usar em virose salvo indicação específica
Situação	Resposta condicionada às restrições etárias e à indicação específica
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

014. Ácido nalidíxico

Indicação	Uso anti-infeccioso histórico — avaliar alternativa contemporânea
Via	Conforme produto histórico
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não utilizar com base apenas em manual antigo; confirmar registro, disponibilidade e protocolo especializado
Situação	Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por obsolescência ou ausência de papel atual rotineiro
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

015. Adenosina

Indicação	Taquicardia supraventricular regular com pulso — 1ª dose
Via	EV/IO, push ultrarrápido seguido de flush
Apresentação	3 mg/mL
Dose	0,1 mg/kg
Máximo	máximo 6 mg
Intervalo	dose inicial; repetir com 0,2 mg/kg se necessário
Preparo/administração	Usar acesso o mais proximal possível; administrar em push imediato e flush
Monitorização	ECG contínuo, PA, perfusão; registrar ritmo antes/durante/depois
Cautelas	Alta vigilância; sincronizar equipe e flush; considerar QRS e diagnóstico diferencial
Situação	Diretriz PALS 2025
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

016. Adenosina

Indicação	Taquicardia supraventricular regular com pulso — 2ª dose
Via	EV/IO, push ultrarrápido seguido de flush
Apresentação	3 mg/mL
Dose	0,2 mg/kg
Máximo	máximo 12 mg
Intervalo	após falha da 1ª dose
Preparo/administração	Usar acesso o mais proximal possível; administrar em push imediato e flush
Monitorização	ECG contínuo, PA, perfusão; registrar ritmo antes/durante/depois
Cautelas	Alta vigilância; confirmar dose escalonada e diagnóstico de TSV regular
Situação	Diretriz PALS 2025
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

017. Adrenalina (epinefrina)

Indicação	Anafilaxia
Via	IM, coxa ântero-lateral
Apresentação	1 mg/mL
Dose	0,01 mg/kg
Máximo	0,5 mg/dose; alguns protocolos limitam criança a 0,3 mg
Intervalo	repetir após 5 min se necessário
Preparo/administração	Pura; seringa de 1 mL
Monitorização	ABCDE, PA, FC, SpO ₂ ; observar resposta
Cautelas	Sem contraindicação absoluta na anafilaxia; confirmar limite institucional 0,3 vs 0,5 mg
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

018. Adrenalina (epinefrina)

Indicação	Anafilaxia refratária após 2 doses IM
Via	EV em BIC
Apresentação	Padrões de infusão: 10 ou 20 mcg/mL
Dose	iniciar 0,05 mcg/kg/min; titular em ambiente monitorizado
Máximo	confirmar protocolo institucional
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	10 mcg/mL: 0,5 mg (0,5 mL de 1 mg/mL) e completar para 50 mL. 20 mcg/mL: 1 mg e completar para 50 mL. Bomba com biblioteca e dupla checagem.
Monitorização	PA contínua se possível, ECG, perfusão
Cautelas	Manter adrenalina IM enquanto prepara infusão; considerar UTI
Situação	Off-label: infusão em anafilaxia refratária
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

019. Adrenalina (epinefrina)

Indicação	Choque com disfunção miocárdica/baixo débito
Via	EV/IO em BIC
Apresentação	Padrões de infusão: 10 ou 20 mcg/mL
Dose	iniciar 0,05 mcg/kg/min; usual 0,05–0,3 mcg/kg/min
Máximo	máx. de referência 1 mcg/kg/min; titular ao efeito
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	10 mcg/mL: 0,5 mg em volume final de 50 mL. 20 mcg/mL: 1 mg em volume final de 50 mL. Bomba/biblioteca; central preferível.
Monitorização	PA, perfusão, lactato, diurese, ECG, sítio periférico
Cautelas	Alta vigilância; dupla checagem de mcg versus mg
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

020. Adrenalina (epinefrina)

Indicação	Crupe moderado/grave com estridor em repouso
Via	Nebulização
Apresentação	1 mg/mL
Dose	0,5 mL/kg = 0,5 mg/kg
Máximo	5 mL = 5 mg
Intervalo	dose; repetir conforme resposta e suporte disponível
Preparo/administração	Nebulizar volume calculado; completar volume apenas se o nebulizador exigir
Monitorização	FC, SpO ₂ , estridor; observar ≥3 h após última dose
Cautelas	Associar dexametasona; preparar via aérea se resposta inadequada
Situação	Diretriz pediátrica; uso por nebulização
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

021. Adrenalina (epinefrina)

Indicação	PCR
Via	EV/IO
Apresentação	1 mg/10 mL = 0,1 mg/mL
Dose	0,01 mg/kg = 10 mcg/kg
Máximo	1 mg/dose
Intervalo	a cada 3–5 min
Preparo/administração	Solução 0,1 mg/mL; flush após dose
Monitorização	ECG, ETCO ₂ , qualidade da RCP
Cautelas	Não usar solução 1 mg/mL por engano na via EV/IO
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

022. Albendazol

Indicação	Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária
Via	VO ou tópica conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Situação	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

023. Alizaprida

Indicação	Náuseas/vômitos — uso selecionado após tratar a causa e avaliar risco de QT
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar QT, distonia/efeitos extrapiramidais, interações e distúrbios eletrolíticos
Situação	Não usar rotineiramente; dose/idade dependem do produto e da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

024. Amantadina

Indicação	Indicação neurológica/sedativa especializada
Via	VO ou via hospitalar conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar depressão do SNC, QT, efeitos extrapiramidais e necessidade de monitorização cardiorrespiratória
Situação	Uso restrito/off-label conforme cenário; selecionar protocolo especializado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: sim

025. Amicacina

Indicação	Bacteremia ou sepse por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL
Dose	5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h
Máximo	máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal
Intervalo	8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg
Preparo/administração	Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular
Cautelas	Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

026. Amicacina

Indicação	Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL
Dose	5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h
Máximo	máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal
Intervalo	8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg
Preparo/administração	Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular
Cautelas	Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

027. Amicacina

Indicação	Infecção de queimadura por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL
Dose	5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h
Máximo	máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal
Intervalo	8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg
Preparo/administração	Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular
Cautelas	Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

028. Amicacina

Indicação	Infecção grave por Gram-negativo
Via	EV
Apresentação	250 mg/mL
Dose	15–20 mg/kg/dose
Máximo	1,5 g/dose
Intervalo	a cada 24 h
Preparo/administração	Diluir em SF 0,9% ou SG 5%; infundir em 30–60 min
Monitorização	Creatinina, diurese; níveis quando indicado
Cautelas	Ajustar intervalo na disfunção renal; antibiograma/protocolo local
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

029. Amicacina

Indicação	Infecção intra-abdominal ou peritonite por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL
Dose	5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h
Máximo	máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal
Intervalo	8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg
Preparo/administração	Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular
Cautelas	Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

030. Amicacina

Indicação	Infecção osteoarticular por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL
Dose	5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h
Máximo	máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal
Intervalo	8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg
Preparo/administração	Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular
Cautelas	Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

031. Amicacina

Indicação	Infecção pós-operatória por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL
Dose	5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h
Máximo	máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal
Intervalo	8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg
Preparo/administração	Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular
Cautelas	Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

032. Amicacina

Indicação	Infecção respiratória grave por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL
Dose	5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h
Máximo	máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal
Intervalo	8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg
Preparo/administração	Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular
Cautelas	Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

033. Amicacina

Indicação	Infecção urinária recorrente, complicada ou grave por bactéria sensível — opção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL
Dose	5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h
Máximo	máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal
Intervalo	8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg
Preparo/administração	Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular
Cautelas	Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

034. Amicacina

Indicação	Sepse neonatal por bactéria Gram-negativa sensível — ataque IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola brasileira 100 mg/2 mL = 50 mg/mL
Dose	10 mg/kg, dose de ataque
Máximo	prosseguir com a linha de manutenção neonatal e ajustar por função renal/níveis
Intervalo	dose inicial única
Preparo/administração	Aspirar diretamente da ampola de 50 mg/mL; não diluir para uso IM.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular
Cautelas	Prematuros podem iniciar diretamente com 7,5 mg/kg 12/12 h; validar idade gestacional e protocolo neonatal.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; dose de ataque neonatal da bula brasileira
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

035. Amicacina

Indicação	Sepse neonatal por bactéria Gram-negativa sensível — manutenção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola brasileira 100 mg/2 mL = 50 mg/mL
Dose	7,5 mg/kg/dose
Máximo	ajustar por função renal, idade gestacional e níveis séricos
Intervalo	12/12 h
Preparo/administração	Aspirar diretamente da ampola de 50 mg/mL; não diluir para uso IM.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular
Cautelas	Validar idade gestacional e protocolo neonatal; evitar associação com outros nefro/ototóxicos quando possível.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; manutenção neonatal da bula brasileira
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

036. Amilorida

Indicação	Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg
Situação	Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

037. Aminofilina

Indicação	Broncoespasmo — terapia adjuvante selecionada, não de primeira linha
Via	VO ou EV conforme fármaco/produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Janela terapêutica estreita para xantinas; revisar interações, arritmia, convulsão e níveis quando aplicável
Situação	Referência documental; benefício-risco e papel atual devem ser confirmados
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

038. Amoxicilina

Indicação	Otite média aguda — dose alta quando antibiótico indicado
Via	VO
Apresentação	Suspensão 400 mg/5 mL = 80 mg/mL
Dose	80–90 mg/kg/dia divididos 12/12 h = 40–45 mg/kg/dose
Máximo	máximo diário conforme protocolo/indicação; arquivo-base usa 4 g/dia
Intervalo	12/12 h; duração conforme foco e evolução
Preparo/administração	Agitar; medir com seringa oral; confirmar concentração 400 mg/5 mL
Monitorização	Resposta em 48–72 h, tolerância GI, reação alérgica
Cautelas	Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia a betalactâmicos
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

039. Amoxicilina

Indicação	Pneumonia adquirida na comunidade — tratamento oral de pneumococo suspeito
Via	VO
Apresentação	Suspensão 400 mg/5 mL = 80 mg/mL
Dose	80–90 mg/kg/dia divididos 12/12 h = 40–45 mg/kg/dose
Máximo	máximo diário conforme protocolo/indicação; arquivo-base usa 4 g/dia
Intervalo	12/12 h; duração conforme foco e evolução
Preparo/administração	Agitar; medir com seringa oral; confirmar concentração 400 mg/5 mL
Monitorização	Resposta em 48–72 h, tolerância GI, reação alérgica
Cautelas	Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia a betalactâmicos
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

040. Amoxicilina

Indicação	Rinossinusite bacteriana aguda — dose alta quando indicada
Via	VO
Apresentação	Suspensão 400 mg/5 mL = 80 mg/mL
Dose	80–90 mg/kg/dia divididos 12/12 h = 40–45 mg/kg/dose
Máximo	máximo diário conforme protocolo/indicação; arquivo-base usa 4 g/dia
Intervalo	12/12 h; duração conforme foco e evolução
Preparo/administração	Agitar; medir com seringa oral; confirmar concentração 400 mg/5 mL
Monitorização	Resposta em 48–72 h, tolerância GI, reação alérgica
Cautelas	Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia a betalactâmicos
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

041. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Aborto séptico por agente sensível — adolescente >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

042. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Amigdalite bacteriana por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

043. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Amigdalite bacteriana por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

044. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Amigdalite bacteriana por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

045. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Broncopneumonia por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

046. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Broncopneumonia por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

047. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Broncopneumonia por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

048. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Bronquite bacteriana aguda por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

049. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Bronquite bacteriana aguda por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

050. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Bronquite bacteriana aguda por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

051. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Bronquite bacteriana crônica exacerbada por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

052. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Bronquite bacteriana crônica exacerbada por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

053. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Bronquite bacteriana crônica exacerbada por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

054. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Celulite bacteriana por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

055. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Celulite bacteriana por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

056. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Celulite bacteriana por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

057. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Cistite por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

058. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Cistite por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

059. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Cistite por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

060. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Ferimento infectado por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

061. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Ferimento infectado por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

062. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Ferimento infectado por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

063. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Furúnculo ou abscesso por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

064. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Furúnculo ou abscesso por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

065. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Furúnculo ou abscesso por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

066. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Infecção genital feminina por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

067. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Infecção genital feminina por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

068. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Infecção genital feminina por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

069. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Infecção pós-cirúrgica por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

070. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Infecção pós-cirúrgica por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

071. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Infecção pós-cirúrgica por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

072. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Osteomielite por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

073. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Osteomielite por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

074. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Osteomielite por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

075. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Otite média aguda com risco de beta-lactamase ou falha à amoxicilina
Via	VO
Apresentação	Suspensão 400 mg + 57 mg/5 mL; 80 mg/mL de amoxicilina
Dose	80–90 mg/kg/dia de amoxicilina divididos 12/12 h
Máximo	máximo pela amoxicilina conforme foco; minimizar clavulanato excessivo
Intervalo	12/12 h; duração conforme foco
Preparo/administração	Calcular pela amoxicilina; agitar e refrigerar conforme bula do produto
Monitorização	Resposta clínica, diarreia, reação alérgica e hepatotoxicidade rara
Cautelas	Confirmar razão amoxicilina:clavulanato; ajustar função renal; alergia a betalactâmicos
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

076. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Otite média bacteriana por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

077. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Otite média bacteriana por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

078. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Otite média bacteriana por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

079. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Peritonite por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

080. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Peritonite por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

081. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Peritonite por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

082. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Pielonefrite por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

083. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Pielonefrite por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

084. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Pielonefrite por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

085. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Pneumonia lobar por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

086. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Pneumonia lobar por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

087. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Pneumonia lobar por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

088. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Rinossinusite bacteriana com risco de beta-lactamase ou falha à amoxicilina
Via	VO
Apresentação	Suspensão 400 mg + 57 mg/5 mL; 80 mg/mL de amoxicilina
Dose	80–90 mg/kg/dia de amoxicilina divididos 12/12 h
Máximo	máximo pela amoxicilina conforme foco; minimizar clavulanato excessivo
Intervalo	12/12 h; duração conforme foco
Preparo/administração	Calcular pela amoxicilina; agitar e refrigerar conforme bula do produto
Monitorização	Resposta clínica, diarreia, reação alérgica e hepatotoxicidade rara
Cautelas	Confirmar razão amoxicilina:clavulanato; ajustar função renal; alergia a betalactâmicos
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

089. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Sepse intra-abdominal por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

090. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Sepse intra-abdominal por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

091. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Sepse intra-abdominal por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

092. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Sepse por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

093. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Sepse por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

094. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Sepse por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

095. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Sepse puerperal por agente sensível — adolescente >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

096. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Sinusite bacteriana por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

097. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Sinusite bacteriana por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

098. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Sinusite bacteriana por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

099. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Uretrite por agente sensível — >12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato
Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

100. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Uretrite por agente sensível — 0 a <3 meses
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

101. Amoxicilina + clavulanato de potássio

Indicação	Uretrite por agente sensível — 3 meses a 12 anos
Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato
Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h
Preparo/administração	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade
Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Situação	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

102. Amoxicilina + Sulbactam

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

103. Ampicilina

Indicação	Infecção grave sem acometimento do SNC
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola 500 mg ou 1 g; padrão operacional 100 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose
Máximo	2 g/dose
Intervalo	a cada 6 h
Preparo/administração	Padrão operacional: 500 mg + 5 mL ou 1 g + 10 mL = 100 mg/mL. Confirmar volume de reconstituição na bula da marca; diluir depois se necessário.
Monitorização	Resposta clínica, culturas
Cautelas	Ajustar em insuficiência renal; alergia beta-lactâmico
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

104. Ampicilina

Indicação	Meningite/infecção do SNC
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola 500 mg ou 1 g; padrão operacional 100 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose a cada 4 h OU 75 mg/kg/dose a cada 6 h
Máximo	2 g/dose; 300 mg/kg/dia
Intervalo	a cada 4–6 h
Preparo/administração	Padrão operacional: 500 mg + 5 mL ou 1 g + 10 mL = 100 mg/mL. Confirmar bula da marca; usar o volume correspondente a 50 ou 75 mg/kg.
Monitorização	Culturas, LCR, função renal
Cautelas	RN: intervalo depende de IG e idade pós-natal
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

105. Ampicilina + sulbactam

Indicação	Epiglote bacteriana por agente sensível — opção IM após a primeira semana
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto 6/6 h ou 50 mg/kg/dose do produto 8/8 h = 25–33,33 mg/kg de ampicilina/dose
Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes
Intervalo	6/6 h no esquema de 37,5 mg/kg/dose ou 8/8 h no esquema de 50 mg/kg/dose
Preparo/administração	Reconstituir com água para injetáveis; lidocaína 0,5% pode reduzir dor somente quando não contraindicada. Usar a solução IM em até 1 hora e dividir volumes grandes entre sítios.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade
Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite, infecção intra-abdominal/pélvica grave ou necessidade de dose alta, preferir via EV.
Situação	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

106. Ampicilina + sulbactam

Indicação	Epiglote bacteriana por agente sensível — opção IM na primeira semana de vida
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de ampicilina + 12,5 mg/kg de sulbactam
Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes
Intervalo	12/12 h na primeira semana, especialmente em prematuros
Preparo/administração	Reconstituir com água para injetáveis; usar a solução IM em até 1 hora. A lidocaína 0,5% não deve ser usada no recém-nascido.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade
Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite ou infecção grave, preferir via EV e protocolo neonatal.
Situação	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

107. Ampicilina + sulbactam

Indicação	Infecção de pele ou tecidos moles por agente sensível — opção IM após a primeira semana
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto 6/6 h ou 50 mg/kg/dose do produto 8/8 h = 25–33,33 mg/kg de ampicilina/dose
Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes
Intervalo	6/6 h no esquema de 37,5 mg/kg/dose ou 8/8 h no esquema de 50 mg/kg/dose
Preparo/administração	Reconstituir com água para injetáveis; lidocaína 0,5% pode reduzir dor somente quando não contraindicada. Usar a solução IM em até 1 hora e dividir volumes grandes entre sítios.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade
Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite, infecção intra-abdominal/pélvica grave ou necessidade de dose alta, preferir via EV.
Situação	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

108. Ampicilina + sulbactam

Indicação	Infecção de pele ou tecidos moles por agente sensível — opção IM na primeira semana de vida
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de ampicilina + 12,5 mg/kg de sulbactam
Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes
Intervalo	12/12 h na primeira semana, especialmente em prematuros
Preparo/administração	Reconstituir com água para injetáveis; usar a solução IM em até 1 hora. A lidocaína 0,5% não deve ser usada no recém-nascido.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade
Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite ou infecção grave, preferir via EV e protocolo neonatal.
Situação	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

109. Ampicilina + sulbactam

Indicação	Otite média bacteriana por agente sensível — opção IM após a primeira semana
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto 6/6 h ou 50 mg/kg/dose do produto 8/8 h = 25–33,33 mg/kg de ampicilina/dose
Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes
Intervalo	6/6 h no esquema de 37,5 mg/kg/dose ou 8/8 h no esquema de 50 mg/kg/dose
Preparo/administração	Reconstituir com água para injetáveis; lidocaína 0,5% pode reduzir dor somente quando não contraindicada. Usar a solução IM em até 1 hora e dividir volumes grandes entre sítios.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade
Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite, infecção intra-abdominal/pélvica grave ou necessidade de dose alta, preferir via EV.
Situação	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

110. Ampicilina + sulbactam

Indicação	Otite média bacteriana por agente sensível — opção IM na primeira semana de vida
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de ampicilina + 12,5 mg/kg de sulbactam
Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes
Intervalo	12/12 h na primeira semana, especialmente em prematuros
Preparo/administração	Reconstituir com água para injetáveis; usar a solução IM em até 1 hora. A lidocaína 0,5% não deve ser usada no recém-nascido.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade
Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite ou infecção grave, preferir via EV e protocolo neonatal.
Situação	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

111. Ampicilina + sulbactam

Indicação	Pneumonia bacteriana por agente sensível — opção IM após a primeira semana
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto 6/6 h ou 50 mg/kg/dose do produto 8/8 h = 25–33,33 mg/kg de ampicilina/dose
Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes
Intervalo	6/6 h no esquema de 37,5 mg/kg/dose ou 8/8 h no esquema de 50 mg/kg/dose
Preparo/administração	Reconstituir com água para injetáveis; lidocaína 0,5% pode reduzir dor somente quando não contraindicada. Usar a solução IM em até 1 hora e dividir volumes grandes entre sítios.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade
Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite, infecção intra-abdominal/pélvica grave ou necessidade de dose alta, preferir via EV.
Situação	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

112. Ampicilina + sulbactam

Indicação	Pneumonia bacteriana por agente sensível — opção IM na primeira semana de vida
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de ampicilina + 12,5 mg/kg de sulbactam
Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes
Intervalo	12/12 h na primeira semana, especialmente em prematuros
Preparo/administração	Reconstituir com água para injetáveis; usar a solução IM em até 1 hora. A lidocaína 0,5% não deve ser usada no recém-nascido.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade
Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite ou infecção grave, preferir via EV e protocolo neonatal.
Situação	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

113. Ampicilina + sulbactam

Indicação	Sinusite bacteriana por agente sensível — opção IM após a primeira semana
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto 6/6 h ou 50 mg/kg/dose do produto 8/8 h = 25–33,33 mg/kg de ampicilina/dose
Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes
Intervalo	6/6 h no esquema de 37,5 mg/kg/dose ou 8/8 h no esquema de 50 mg/kg/dose
Preparo/administração	Reconstituir com água para injetáveis; lidocaína 0,5% pode reduzir dor somente quando não contraindicada. Usar a solução IM em até 1 hora e dividir volumes grandes entre sítios.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade
Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite, infecção intra-abdominal/pélvica grave ou necessidade de dose alta, preferir via EV.
Situação	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

114. Ampicilina + sulbactam

Indicação	Sinusite bacteriana por agente sensível — opção IM na primeira semana de vida
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de ampicilina + 12,5 mg/kg de sulbactam
Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes
Intervalo	12/12 h na primeira semana, especialmente em prematuros
Preparo/administração	Reconstituir com água para injetáveis; usar a solução IM em até 1 hora. A lidocaína 0,5% não deve ser usada no recém-nascido.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade
Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite ou infecção grave, preferir via EV e protocolo neonatal.
Situação	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

115. Ampicilina-sulbactam

Indicação	Infecção de pele e tecidos moles
Via	EV
Apresentação	1,5 g ou 3 g; 250 mg/mL de ampicilina após reconstituição
Dose	50 mg/kg/dose de ampicilina (= 75 mg/kg/dose do produto)
Máximo	2 g de ampicilina/dose
Intervalo	a cada 6 h
Preparo/administração	Reconstituir conforme bula para 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam; para EV, diluir até 30 mg/mL de ampicilina (faixa de bula: 2–30 mg/mL).
Monitorização	Resposta, culturas, função hepática/renal
Cautelas	Ajustar em insuficiência renal; sempre declarar base ampicilina
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

116. Ampicilina-sulbactam

Indicação	Infecção intra-abdominal bacteriana
Via	EV
Apresentação	1,5 g ou 3 g; 250 mg/mL de ampicilina após reconstituição
Dose	50 mg/kg/dose de ampicilina (= 75 mg/kg/dose do produto)
Máximo	2 g de ampicilina/dose
Intervalo	a cada 6 h
Preparo/administração	Reconstituir conforme bula para 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam; para EV, diluir até 30 mg/mL de ampicilina (faixa de bula: 2-30 mg/mL).
Monitorização	Resposta, culturas, função hepática/renal
Cautelas	Ajustar em insuficiência renal; sempre declarar base ampicilina
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

117. Ampicilina-sulbactam

Indicação	Infecção polimicrobiana grave
Via	EV
Apresentação	1,5 g ou 3 g; 250 mg/mL de ampicilina após reconstituição
Dose	50 mg/kg/dose de ampicilina
Máximo	2 g de ampicilina/dose
Intervalo	a cada 6 h
Preparo/administração	Reconstituir conforme bula para 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam; para EV, diluir até 30 mg/mL de ampicilina.
Monitorização	Ferida, culturas quando indicadas
Cautelas	Avaliar profilaxia antirrábica/antitetânica conforme exposição
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

118. Ampicilina-sulbactam

Indicação	Infecção respiratória bacteriana
Via	EV
Apresentação	1,5 g ou 3 g; 250 mg/mL de ampicilina após reconstituição
Dose	50 mg/kg/dose de ampicilina (= 75 mg/kg/dose do produto)
Máximo	2 g de ampicilina/dose
Intervalo	a cada 6 h
Preparo/administração	Reconstituir conforme bula para 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam; para EV, diluir até 30 mg/mL de ampicilina (faixa de bula: 2-30 mg/mL).
Monitorização	Resposta, culturas, função hepática/renal
Cautelas	Ajustar em insuficiência renal; sempre declarar base ampicilina
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

119. Ampicilina-sulbactam

Indicação	Mordedura animal
Via	EV
Apresentação	1,5 g ou 3 g; 250 mg/mL de ampicilina após reconstituição
Dose	50 mg/kg/dose de ampicilina
Máximo	2 g de ampicilina/dose
Intervalo	a cada 6 h
Preparo/administração	Reconstituir conforme bula para 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam; para EV, diluir até 30 mg/mL de ampicilina.
Monitorização	Ferida, culturas quando indicadas
Cautelas	Avaliar profilaxia antirrábica/antitetânica conforme exposição
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

120. Ampicilina-sulbactam

Indicação	Mordedura humana
Via	EV
Apresentação	1,5 g ou 3 g; 250 mg/mL de ampicilina após reconstituição
Dose	50 mg/kg/dose de ampicilina
Máximo	2 g de ampicilina/dose
Intervalo	a cada 6 h
Preparo/administração	Reconstituir conforme bula para 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam; para EV, diluir até 30 mg/mL de ampicilina.
Monitorização	Ferida, culturas quando indicadas
Cautelas	Avaliar profilaxia antirrábica/antitetânica conforme exposição
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

121. Anfotericina B

Indicação	Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente
Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Situação	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

122. Azelastina

Indicação	Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto
Via	Nasal ou oftálmica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Situação	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

123. Azelastina

Indicação	Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto
Via	Nasal ou oftálmica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Situação	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

124. Azitromicina

Indicação	Pneumonia atípica — continuidade VO
Via	VO
Apresentação	Suspensão oral 200 mg/5 mL = 40 mg/mL
Dose	10 mg/kg no dia 1; 5 mg/kg/dia nos dias 2-5
Máximo	500 mg no dia 1; 250 mg/dia depois
Intervalo	a cada 24 h
Preparo/administração	Reconstituir o frasco até o volume indicado pelo fabricante; concentração de referência 200 mg/5 mL. Agitar antes de cada retirada.
Monitorização	Resposta clínica
Cautelas	Uso deve seguir epidemiologia e protocolo antimicrobiano
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

125. Azitromicina

Indicação	Pneumonia atípica com necessidade de via EV
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola 500 mg; solução final 1–2 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose
Máximo	500 mg/dose
Intervalo	a cada 24 h
Preparo/administração	Reconstituir conforme bula e diluir a concentração final de 2 mg/mL (preferida para menor volume) ou 1 mg/mL; infundir por pelo menos 1 hora.
Monitorização	ECG se risco de QT, função hepática
Cautelas	Evitar associação com outros prolongadores de QT quando possível
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

126. Aztreonam

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

127. Bacitracina

Indicação	Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

128. Bacitracina

Indicação	Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

129. Bamifilina

Indicação	Broncoespasmo — terapia adjuvante selecionada, não de primeira linha
Via	VO ou EV conforme fármaco/produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Janela terapêutica estreita para xantinas; revisar interações, arritmia, convulsão e níveis quando aplicável
Situação	Referência documental; benefício-risco e papel atual devem ser confirmados
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

130. Beclometasona

Indicação	Controle de asma persistente
Via	Inalatória
Apresentação	Inalador 50 mcg/jato
Dose	100–400 mcg/dia, divididos
Máximo	definido pelo degrau terapêutico
Intervalo	1–2 vezes/dia
Preparo/administração	Usar o dispositivo e espaçador; a unidade operacional é jato, não mL.
Monitorização	Controle de sintomas, técnica, crescimento em uso prolongado
Cautelas	Não é medicação de resgate
Situação	Uso pediátrico em bula; dose depende da idade/dispositivo
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

131. Benzidamina

Indicação	Dor/inflamação local — uso tópico conforme produto e idade
Via	Tópica/oromucosa/retal conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Evitar ingestão, uso em mucosa lesada extensa e formulação inadequada para a idade
Situação	Posologia por aplicação depende da formulação; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

132. Benzilpenicilina

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar sal/formulação conforme síndrome
Via	VO, IM ou EV conforme sal
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, sal, concentração e via; penicilina benzatina nunca EV
Situação	Não intercambiar benzatina, procaína, cristalina ou penicilina V; linhas específicas originais foram preservadas
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

133. Benzoato de benzila

Indicação	Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária
Via	VO ou tópica conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Situação	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

134. Betametasona

Indicação	Doença inflamatória/alérgica específica — corticoide sistêmico ou tópico
Via	VO, IM, tópica ou intra-articular conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; avaliar duração, desmame e imunossupressão
Situação	Potência e equivalência variam; selecionar indicação e formulação antes de calcular
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

135. Brometo de N-butilescopolamina

Indicação	Dor abdominal espasmódica — uso sintomático selecionado após excluir causa cirúrgica
Via	VO, IM ou EV conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Efeitos anticolinérgicos; evitar em glaucoma, retenção urinária, íleo e suspeita de obstrução
Situação	Dose e idade mínima variam por sal/apresentação; não intercambiar sais
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

136. Bromexina

Indicação	Secreção respiratória espessa — uso mucolítico apenas quando individualmente indicado
Via	VO ou inalatória conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Pode aumentar volume de secreções/broncoespasmo; contraindicações e idade mínima variam por produto
Situação	Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; resposta depende da idade e apresentação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

137. Bromoprida

Indicação	Náuseas/vômitos — uso selecionado após tratar a causa e avaliar risco de QT
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar QT, distonia/efeitos extrapiramidais, interações e distúrbios eletrolíticos
Situação	Não usar rotineiramente; dose/idade dependem do produto e da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

138. Budesonida

Indicação	Controle de asma quando nebulização é necessária
Via	Nebulização
Apresentação	Suspensão 0,25 ou 0,5 mg/mL
Dose	0,25–0,5 mg/dose
Máximo	máximo depende da idade/degrau; usual até 1 mg/dia
Intervalo	1–2 vezes/dia
Preparo/administração	Pura ou completar volume conforme nebulizador
Monitorização	Controle, candidíase oral, crescimento
Cautelas	Não é broncodilatador de resgate; não usar rotineiramente na bronquiolite
Situação	Uso pediátrico em bula; ajustar por idade
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

139. Budesonida

Indicação	Crupe quando dexametasona não é viável
Via	Nebulização
Apresentação	Suspensão para nebulização
Dose	2 mg, dose única
Máximo	2 mg
Intervalo	dose única
Preparo/administração	Nebulizar; não misturar sem compatibilidade confirmada
Monitorização	Estridor, esforço respiratório
Cautelas	Dexametasona sistêmica continua preferida na maioria dos protocolos
Situação	Off-label/alternativa em protocolo
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: sim

140. Bumetanida

Indicação	Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg
Situação	Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

141. Buprenorfina

Indicação	Dor moderada/intensa — opção opioide selecionada por protocolo e idade
Via	VO, EV, IM ou transmucosa conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Monitorar ventilação/sedação; codeína e tramadol têm restrições importantes em menores de 12 anos e após adenoamigdalectomia
Situação	Uso restrito; resposta condicionada às contraindicações etárias e à variabilidade metabólica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

142. Cambendazol

Indicação	Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária
Via	VO ou tópica conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Situação	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

143. Captopril

Indicação	Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg
Situação	Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

144. Carbamazepina

Indicação	Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica
Situação	Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

145. Carbocisteína

Indicação	Secreção respiratória espessa — uso mucolítico apenas quando individualmente indicado
Via	VO ou inalatória conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Pode aumentar volume de secreções/broncoespasmo; contraindicações e idade mínima variam por produto
Situação	Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; resposta depende da idade e apresentação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

146. Cefaclor

Indicação	Otite média aguda por agente sensível — alternativa
Via	VO
Apresentação	Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL
Dose	40 mg/kg/dia divididos 8/8 h = 13,33 mg/kg/dose
Máximo	máximo 1 g/dia no arquivo-base
Intervalo	8/8 h
Preparo/administração	Reconstituir conforme bula; agitar antes de usar
Monitorização	Resposta clínica, alergia, diarreia
Cautelas	Ajustar função renal; confirmar alergia a cefalosporinas/betalactâmicos
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

147. Cefaclor

Indicação	Rinossinusite bacteriana por agente sensível — alternativa
Via	VO
Apresentação	Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL
Dose	40 mg/kg/dia divididos 8/8 h = 13,33 mg/kg/dose
Máximo	máximo 1 g/dia no arquivo-base
Intervalo	8/8 h
Preparo/administração	Reconstituir conforme bula; agitar antes de usar
Monitorização	Resposta clínica, alergia, diarreia
Cautelas	Ajustar função renal; confirmar alergia a cefalosporinas/betalactâmicos
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

148. Cefadroxila

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

149. Cefalexina

Indicação	Infecção de pele/partes moles por agente sensível
Via	VO
Apresentação	Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL
Dose	12,5 mg/kg/dose; o intervalo define 25 mg/kg/dia (12/12 h) ou 50 mg/kg/dia (6/6 h)
Máximo	máximo 4 g/dia no arquivo-base; confirmar indicação
Intervalo	dividir em 2–4 doses
Preparo/administração	Reconstituir conforme bula; agitar; medir com seringa oral
Monitorização	Resposta clínica, tolerância GI, alergia
Cautelas	Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia imediata grave a betalactâmicos
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

150. Cefalexina

Indicação	Infecção urinária afebril por agente sensível
Via	VO
Apresentação	Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL
Dose	12,5 mg/kg/dose; o intervalo define 25 mg/kg/dia (12/12 h) ou 50 mg/kg/dia (6/6 h)
Máximo	máximo 4 g/dia no arquivo-base; confirmar indicação
Intervalo	dividir em 2–4 doses
Preparo/administração	Reconstituir conforme bula; agitar; medir com seringa oral
Monitorização	Resposta clínica, tolerância GI, alergia
Cautelas	Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia imediata grave a betalactâmicos
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

151. Cefalotina

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

152. Cefazolina

Indicação	Infecção grave por MSSA
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola 1 g; solução de referência 100 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose
Máximo	2 g/dose
Intervalo	a cada 8 h
Preparo/administração	Reconstituir 1 g para concentração de 100 mg/mL; para infusão, diluir adicionalmente conforme bula/protocolo e compatibilidade.
Monitorização	Culturas, função renal
Cautelas	Ajustar em insuficiência renal
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

153. Cefazolina

Indicação	Infecção leve/moderada por MSSA/estreptococos
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola 1 g; solução de referência 100 mg/mL
Dose	25 mg/kg/dose
Máximo	1 g/dose
Intervalo	a cada 8 h
Preparo/administração	Reconstituir 1 g para concentração de 100 mg/mL; para infusão, diluir adicionalmente conforme bula/protocolo e compatibilidade.
Monitorização	Culturas, resposta
Cautelas	Ajustar em insuficiência renal
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

154. Cefazolina

Indicação	Profilaxia perioperatória
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola 1 g; solução de referência 100 mg/mL
Dose	30 mg/kg/dose
Máximo	2 g; 3 g se protocolo adulto/peso elevado
Intervalo	30-60 min antes da incisão; redose conforme duração/perda
Preparo/administração	Reconstituir 1 g para concentração de 100 mg/mL; para infusão, diluir adicionalmente conforme bula/protocolo e compatibilidade.
Monitorização	Tempo da dose
Cautelas	Ajustar ao protocolo e tipo de cirurgia
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

155. Cefepima

Indicação	Infecção de pele e estruturas cutâneas leve a moderada — opção IM — >2 meses e ≤40 kg
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 3 mL de água para injetáveis, SF 0,9% ou SG 5% → volume final aproximado 4,2 mL = 238 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose
Máximo	máximo 1 g/dose e 1 g por glúteo; acima de 40 kg usar dose fixa da linha correspondente
Intervalo	12/12 h por 10 dias; reavaliar foco, cultura e resposta
Preparo/administração	Reconstituir o frasco de 1 g com 3 mL; aspirar o volume calculado. Administrar profundamente em grande massa muscular; não exceder 1 g por glúteo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal, neurotoxicidade e reação local
Cautelas	Via EV é preferencial em infecção grave, risco de morte, choque, sepse, meningite ou neutropenia febril. Ajustar na disfunção renal.
Situação	Bula profissional brasileira; experiência pediátrica IM limitada; reservar a infecção leve/moderada selecionada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

156. Cefepima

Indicação	Infecção de pele e estruturas cutâneas leve a moderada — opção IM — >40 kg
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 3 mL de água para injetáveis, SF 0,9% ou SG 5% → volume final aproximado 4,2 mL = 238 mg/mL
Dose	1 g/dose
Máximo	máximo 1 g por glúteo nesta linha
Intervalo	12/12 h; duração conforme foco e evolução
Preparo/administração	Reconstituir o frasco de 1 g com 3 mL e administrar todo o volume final aproximado de 4,2 mL por IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal, neurotoxicidade e reação local
Cautelas	Via EV é preferencial em infecção grave, risco de morte, choque, sepse, meningite ou neutropenia febril. Ajustar na disfunção renal.
Situação	Bula profissional brasileira; experiência pediátrica IM limitada; reservar a infecção leve/moderada selecionada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

157. Cefepima

Indicação	Infecção do trato urinário leve a moderada — opção IM — >2 meses e ≤40 kg
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 3 mL de água para injetáveis, SF 0,9% ou SG 5% → volume final aproximado 4,2 mL = 238 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose
Máximo	máximo 1 g/dose e 1 g por glúteo; acima de 40 kg usar dose fixa da linha correspondente
Intervalo	12/12 h por 10 dias; reavaliar foco, cultura e resposta
Preparo/administração	Reconstituir o frasco de 1 g com 3 mL; aspirar o volume calculado. Administrar profundamente em grande massa muscular; não exceder 1 g por glúteo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal, neurotoxicidade e reação local
Cautelas	Via EV é preferencial em infecção grave, risco de morte, choque, sepse, meningite ou neutropenia febril. Ajustar na disfunção renal.
Situação	Bula profissional brasileira; experiência pediátrica IM limitada; reservar a infecção leve/moderada selecionada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

158. Cefepima

Indicação	Infecção do trato urinário leve a moderada — opção IM — >40 kg
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 3 mL de água para injetáveis, SF 0,9% ou SG 5% → volume final aproximado 4,2 mL = 238 mg/mL
Dose	1 g/dose
Máximo	máximo 1 g por glúteo nesta linha
Intervalo	12/12 h; duração conforme foco e evolução
Preparo/administração	Reconstituir o frasco de 1 g com 3 mL e administrar todo o volume final aproximado de 4,2 mL por IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal, neurotoxicidade e reação local
Cautelas	Via EV é preferencial em infecção grave, risco de morte, choque, sepse, meningite ou neutropenia febril. Ajustar na disfunção renal.
Situação	Bula profissional brasileira; experiência pediátrica IM limitada; reservar a infecção leve/moderada selecionada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

159. Cefepima

Indicação	Neutropenia febril
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola 1 g ou 2 g; 100 mg/mL reconstituído
Dose	50 mg/kg/dose
Máximo	2 g/dose
Intervalo	a cada 8 h
Preparo/administração	Reconstituir para 100 mg/mL; aspirar o volume calculado e diluir para concentração final de 40 mg/mL (dentro da faixa de compatibilidade de bula).
Monitorização	Culturas, função renal
Cautelas	Ajustar em insuficiência renal
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

160. Cefepima

Indicação	Pneumonia bacteriana leve a moderada — opção IM — >2 meses e ≤40 kg
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 3 mL de água para injetáveis, SF 0,9% ou SG 5% → volume final aproximado 4,2 mL = 238 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose
Máximo	máximo 1 g/dose e 1 g por glúteo; acima de 40 kg usar dose fixa da linha correspondente
Intervalo	12/12 h por 10 dias; reavaliar foco, cultura e resposta
Preparo/administração	Reconstituir o frasco de 1 g com 3 mL; aspirar o volume calculado. Administrar profundamente em grande massa muscular; não exceder 1 g por glúteo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal, neurotoxicidade e reação local
Cautelas	Via EV é preferencial em infecção grave, risco de morte, choque, sepse, meningite ou neutropenia febril. Ajustar na disfunção renal.
Situação	Bula profissional brasileira; experiência pediátrica IM limitada; reservar a infecção leve/moderada selecionada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

161. Cefepima

Indicação	Pneumonia bacteriana leve a moderada — opção IM — >40 kg
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 3 mL de água para injetáveis, SF 0,9% ou SG 5% → volume final aproximado 4,2 mL = 238 mg/mL
Dose	1 g/dose
Máximo	máximo 1 g por glúteo nesta linha
Intervalo	12/12 h; duração conforme foco e evolução
Preparo/administração	Reconstituir o frasco de 1 g com 3 mL e administrar todo o volume final aproximado de 4,2 mL por IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal, neurotoxicidade e reação local
Cautelas	Via EV é preferencial em infecção grave, risco de morte, choque, sepse, meningite ou neutropenia febril. Ajustar na disfunção renal.
Situação	Bula profissional brasileira; experiência pediátrica IM limitada; reservar a infecção leve/moderada selecionada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

162. Cefepima

Indicação	Sepse/infecção grave com risco de Gram-negativo resistente
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola 1 g ou 2 g; 100 mg/mL reconstituído
Dose	50 mg/kg/dose
Máximo	2 g/dose
Intervalo	a cada 8 h
Preparo/administração	Reconstituir para 100 mg/mL; aspirar o volume calculado e diluir para concentração final de 40 mg/mL (dentro da faixa de compatibilidade de bula).
Monitorização	Culturas, função renal, neurotoxicidade
Cautelas	Ajustar em insuficiência renal
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

163. Cefotaxima

Indicação	Infecção com risco de vida por agente sensível — esquema EV
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 500 mg ou 1 g; solução reconstituída aproximadamente 215–216 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose = 200 mg/kg/dia
Máximo	máximo operacional 3 g/dose (12 g/dia); confirmar protocolo e infectologia
Intervalo	6/6 h
Preparo/administração	Reconstituir conforme o frasco e administrar por infusão nas doses altas, conforme bula/protocolo institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e neurotoxicidade
Cautelas	Alta vigilância; ajustar na disfunção renal e reavaliar diariamente descalonamento/antibiograma.
Situação	Bula profissional brasileira; extremo superior de 200 mg/kg/dia reservado a risco de vida
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

164. Cefotaxima

Indicação	Infecção por agente sensível — esquema EV usual
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 500 mg ou 1 g; adicionar 2 mL ou 4 mL, respectivamente → aproximadamente 215–216 mg/mL
Dose	25 mg/kg/dose = 50 mg/kg/dia
Máximo	máximo operacional 1 g/dose nesta linha; aumentar somente conforme gravidade/protocolo
Intervalo	12/12 h
Preparo/administração	Reconstituir conforme o frasco; administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão conforme bula/protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e neurotoxicidade
Cautelas	Ajustar na disfunção renal. Não misturar com bicarbonato de sódio.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema usual selecionado dentro da faixa de 50–100 mg/kg/dia
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

165. Cefotaxima

Indicação	Infecção por agente sensível — esquema IM usual
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 500 mg ou 1 g; adicionar 2 mL ou 4 mL, respectivamente → aproximadamente 215–216 mg/mL
Dose	25 mg/kg/dose = 50 mg/kg/dia
Máximo	máximo 1 g/dose e 2 g/dia por IM; dividir volume >4 mL entre sítios
Intervalo	12/12 h
Preparo/administração	Reconstituir com água para injetáveis e aplicar profundamente. Lidocaína 1% pode ser usada apenas por IM, nunca EV, e é contraindicada abaixo de 30 meses ou nas demais contraindicações da lidocaína.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação local
Cautelas	Preferir EV em infecção grave, risco de vida ou dose diária >2 g. Não usar lidocaína em criança <30 meses.
Situação	Bula profissional brasileira; IM somente em paciente estável e quando a dose diária não exceder 2 g
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

166. Cefotaxima

Indicação	Infecção por agente sensível — EV no prematuro/RN com até 1 semana
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 500 mg ou 1 g; adicionar 2 mL ou 4 mL, respectivamente → aproximadamente 215–216 mg/mL
Dose	25–50 mg/kg/dose = 50–100 mg/kg/dia
Máximo	ajustar por idade gestacional, gravidade, função renal e protocolo neonatal
Intervalo	12/12 h
Preparo/administração	Reconstituir conforme o frasco; administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão conforme bula/protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e neurotoxicidade
Cautelas	Não usar IM no prematuro/RN desta faixa. Não usar lidocaína por via EV.
Situação	Bula profissional brasileira; somente EV nesta faixa neonatal
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

167. Cefotaxima

Indicação	Infecção por agente sensível — EV no prematuro/RN de >1 a 4 semanas
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 500 mg ou 1 g; adicionar 2 mL ou 4 mL, respectivamente → aproximadamente 215–216 mg/mL
Dose	25–50 mg/kg/dose = 75–150 mg/kg/dia
Máximo	ajustar por idade gestacional, gravidade, função renal e protocolo neonatal
Intervalo	8/8 h
Preparo/administração	Reconstituir conforme o frasco; administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão conforme bula/protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e neurotoxicidade
Cautelas	Não usar IM no prematuro/RN desta faixa. Não usar lidocaína por via EV.
Situação	Bula profissional brasileira; somente EV nesta faixa neonatal
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

168. Cefotaxima

Indicação	Infecção típica por agente sensível — adolescente >12 anos
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 4 mL → volume final aproximado 4,63 mL = 216 mg/mL
Dose	1 g/dose
Máximo	por IM, não exceder 2 g/dia e dividir volume >4 mL entre sítios; doses maiores devem ser EV
Intervalo	12/12 h
Preparo/administração	Reconstituir com 4 mL. Para IM, aplicar profundamente e dividir entre sítios; para EV, administrar em 3–5 min ou infundir conforme bula.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação local
Cautelas	Lidocaína somente IM e se não houver contraindicação. Doses diárias >2 g devem ser EV.
Situação	Bula profissional brasileira; posologia de adulto/adolescente >12 anos
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

169. Cefotaxima

Indicação	Infecção típica por agente sensível — criança ≤12 anos com ≥50 kg
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 4 mL → volume final aproximado 4,63 mL = 216 mg/mL
Dose	1 g/dose
Máximo	por IM, não exceder 2 g/dia e dividir volume >4 mL entre sítios; doses maiores devem ser EV
Intervalo	12/12 h
Preparo/administração	Reconstituir com 4 mL. Para IM, aplicar profundamente e dividir entre sítios; para EV, administrar em 3–5 min ou infundir conforme bula.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação local
Cautelas	Lidocaína somente IM e se não houver contraindicação. Doses diárias >2 g devem ser EV.
Situação	Bula profissional brasileira; posologia de adulto/adolescente >12 anos
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

170. Cefprozila

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

171. Ceftazidima

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

172. Ceftriaxona

Indicação	Meningite bacteriana
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola 1 g; 100 mg/mL reconstituído
Dose	50 mg/kg/dose
Máximo	2 g/dose; 4 g/dia
Intervalo	a cada 12 h
Preparo/administração	EV: reconstituir 1 g conforme bula para 100 mg/mL; diluir o volume aspirado até 40 mg/mL. Aplicar restrições neonatais e incompatibilidade com cálcio.
Monitorização	LCR/culturas, resposta, função hepática
Cautelas	Não coadministrar com cálcio em RN ≤ 28 d; evitar em RN hiperbilirrubinêmico/prematuro
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

173. Ceftriaxona

Indicação	Otite média aguda — resgate
Via	IM/EV
Apresentação	Frasco-ampola 1 g; IM 250 mg/mL ou EV final 40 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose
Máximo	1 g/dose
Intervalo	a cada 24 h por 1–3 dias conforme cenário
Preparo/administração	IM: reconstituir conforme bula para 250 mg/mL. EV: reconstituir e diluir até 40 mg/mL. Não usar diluente com lidocaína por via EV.
Monitorização	Resposta em 48–72 h
Cautelas	Indicação depende de falha/intolerância e diagnóstico
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

174. Ceftriaxona

Indicação	Sepse, pneumonia ou outra infecção grave sem meningite
Via	EV/IM
Apresentação	Frasco-ampola 1 g; 100 mg/mL reconstituído
Dose	50 mg/kg/dose
Máximo	2 g/dose
Intervalo	a cada 24 h
Preparo/administração	EV: reconstituir conforme bula para 100 mg/mL e diluir até 40 mg/mL; não misturar/coadministrar com cálcio quando contraindicado.
Monitorização	Culturas, função hepática/biliar
Cautelas	RN: contraindicações específicas para prematuridade, hiperbilirrubinemia e cálcio EV
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

175. Cefuroxima

Indicação	Infecção de pele e tecidos moles por agente sensível — opção EV
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro Keroxime® 750 mg; EV: adicionar 8 mL de água para injetáveis → volume final aproximado 8,6 mL = 87,21 mg/mL
Dose	20 mg/kg/dose = 60 mg/kg/dia divididos 8/8 h
Máximo	máximo 750 mg/dose nesta linha; doses maiores dependem da gravidade e protocolo
Intervalo	8/8 h; duração conforme foco, cultura e resposta
Preparo/administração	Adicionar 8 mL de água para injetáveis ao frasco de 750 mg; o volume final aproximado é 8,6 mL. Aspirar o volume calculado; administrar EV direta em 3–5 min ou diluir para infusão conforme bula/protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal e hipersensibilidade
Cautelas	Não usar esta linha para meningite. Ajustar na disfunção renal e confirmar alergia a betalactâmicos.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; regime usual de 60 mg/kg/dia para a maioria das infecções, fora de meningite
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

176. Cefuroxima

Indicação	Infecção de pele e tecidos moles por agente sensível — opção IM
Via	IM
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 750 mg; IM: adicionar 3 mL de água para injetáveis → volume final aproximado 3,5 mL = 214,29 mg/mL
Dose	20 mg/kg/dose = 60 mg/kg/dia divididos 8/8 h
Máximo	máximo 750 mg/dose nesta linha; doses maiores dependem da gravidade e protocolo
Intervalo	8/8 h; duração conforme foco, cultura e resposta
Preparo/administração	Adicionar 3 mL de água para injetáveis ao frasco de 750 mg e agitar delicadamente até formar suspensão opaca; o volume final aproximado é 3,5 mL. Aspirar o volume calculado.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal e hipersensibilidade
Cautelas	Não usar esta linha para meningite. Ajustar na disfunção renal e confirmar alergia a betalactâmicos.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; regime usual de 60 mg/kg/dia para a maioria das infecções, fora de meningite
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

177. Cefuroxima

Indicação	Infecção do trato urinário por agente sensível — opção EV
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro Keroxime® 750 mg; EV: adicionar 8 mL de água para injetáveis → volume final aproximado 8,6 mL = 87,21 mg/mL
Dose	20 mg/kg/dose = 60 mg/kg/dia divididos 8/8 h
Máximo	máximo 750 mg/dose nesta linha; doses maiores dependem da gravidade e protocolo
Intervalo	8/8 h; duração conforme foco, cultura e resposta
Preparo/administração	Adicionar 8 mL de água para injetáveis ao frasco de 750 mg; o volume final aproximado é 8,6 mL. Aspirar o volume calculado; administrar EV direta em 3–5 min ou diluir para infusão conforme bula/protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal e hipersensibilidade
Cautelas	Não usar esta linha para meningite. Ajustar na disfunção renal e confirmar alergia a betalactâmicos.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; regime usual de 60 mg/kg/dia para a maioria das infecções, fora de meningite
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

178. Cefuroxima

Indicação	Infecção do trato urinário por agente sensível — opção IM
Via	IM
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 750 mg; IM: adicionar 3 mL de água para injetáveis → volume final aproximado 3,5 mL = 214,29 mg/mL
Dose	20 mg/kg/dose = 60 mg/kg/dia divididos 8/8 h
Máximo	máximo 750 mg/dose nesta linha; doses maiores dependem da gravidade e protocolo
Intervalo	8/8 h; duração conforme foco, cultura e resposta
Preparo/administração	Adicionar 3 mL de água para injetáveis ao frasco de 750 mg e agitar delicadamente até formar suspensão opaca; o volume final aproximado é 3,5 mL. Aspirar o volume calculado.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal e hipersensibilidade
Cautelas	Não usar esta linha para meningite. Ajustar na disfunção renal e confirmar alergia a betalactâmicos.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; regime usual de 60 mg/kg/dia para a maioria das infecções, fora de meningite
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

179. Cefuroxima

Indicação	Otite média aguda por agente sensível — alternativa oral
Via	VO
Apresentação	Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL
Dose	30 mg/kg/dia divididos 12/12 h = 15 mg/kg/dose
Máximo	máximo 1 g/dia no arquivo-base para OMA/sinusite/piodermite
Intervalo	12/12 h
Preparo/administração	Reconstituir conforme bula; administrar após alimento quando indicado pelo produto
Monitorização	Resposta clínica, alergia e tolerância GI
Cautelas	Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia a betalactâmicos
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

180. Cefuroxima

Indicação	Pneumonia adquirida na comunidade por agente sensível — alternativa oral
Via	VO
Apresentação	Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL
Dose	30 mg/kg/dia divididos 12/12 h = 15 mg/kg/dose
Máximo	máximo 1 g/dia no arquivo-base para OMA/sinusite/piodermite
Intervalo	12/12 h
Preparo/administração	Reconstituir conforme bula; administrar após alimento quando indicado pelo produto
Monitorização	Resposta clínica, alergia e tolerância GI
Cautelas	Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia a betalactâmicos
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

181. Cefuroxima

Indicação	Pneumonia bacteriana por agente sensível — opção EV
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro Keroxime® 750 mg; EV: adicionar 8 mL de água para injetáveis → volume final aproximado 8,6 mL = 87,21 mg/mL
Dose	20 mg/kg/dose = 60 mg/kg/dia divididos 8/8 h
Máximo	máximo 750 mg/dose nesta linha; doses maiores dependem da gravidade e protocolo
Intervalo	8/8 h; duração conforme foco, cultura e resposta
Preparo/administração	Adicionar 8 mL de água para injetáveis ao frasco de 750 mg; o volume final aproximado é 8,6 mL. Aspirar o volume calculado; administrar EV direta em 3–5 min ou diluir para infusão conforme bula/protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal e hipersensibilidade
Cautelas	Não usar esta linha para meningite. Ajustar na disfunção renal e confirmar alergia a betalactâmicos.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; regime usual de 60 mg/kg/dia para a maioria das infecções, fora de meningite
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

182. Cefuroxima

Indicação	Pneumonia bacteriana por agente sensível — opção IM
Via	IM
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 750 mg; IM: adicionar 3 mL de água para injetáveis → volume final aproximado 3,5 mL = 214,29 mg/mL
Dose	20 mg/kg/dose = 60 mg/kg/dia divididos 8/8 h
Máximo	máximo 750 mg/dose nesta linha; doses maiores dependem da gravidade e protocolo
Intervalo	8/8 h; duração conforme foco, cultura e resposta
Preparo/administração	Adicionar 3 mL de água para injetáveis ao frasco de 750 mg e agitar delicadamente até formar suspensão opaca; o volume final aproximado é 3,5 mL. Aspirar o volume calculado.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal e hipersensibilidade
Cautelas	Não usar esta linha para meningite. Ajustar na disfunção renal e confirmar alergia a betalactâmicos.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; regime usual de 60 mg/kg/dia para a maioria das infecções, fora de meningite
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

183. Cefuroxima

Indicação	Rinossinusite bacteriana por agente sensível — alternativa oral
Via	VO
Apresentação	Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL
Dose	30 mg/kg/dia divididos 12/12 h = 15 mg/kg/dose
Máximo	máximo 1 g/dia no arquivo-base para OMA/sinusite/piodermite
Intervalo	12/12 h
Preparo/administração	Reconstituir conforme bula; administrar após alimento quando indicado pelo produto
Monitorização	Resposta clínica, alergia e tolerância GI
Cautelas	Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia a betalactâmicos
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

184. Celulose natural

Indicação	Constipação funcional — desimpactação
Via	VO ou retal conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias
Situação	Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

185. Celulose natural

Indicação	Constipação funcional — manutenção
Via	VO ou retal conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias
Situação	Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

186. Cetamina

Indicação	Analgesia subdissociativa/infusão de dor aguda
Via	EV em BIC
Apresentação	50 mg/mL; preferir diluição padronizada
Dose	0,1–0,2 mg/kg bolus; 0,1–0,4 mg/kg/h
Máximo	máximo do protocolo especializado
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	Ex.: 50 mg/50 mL = 1 mg/mL; calcular mL/h pela dose
Monitorização	Dor, sedação, PA, FC, efeitos psicomiméticos
Cautelas	Prescrição por dor/anestesia/UTI; dupla checagem
Situação	Off-label: analgesia subdissociativa
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: sim

187. Cetamina

Indicação	Indução em sequência rápida de intubação
Via	EV
Apresentação	50 mg/mL
Dose	1–2 mg/kg
Máximo	titular ao cenário; dose única
Intervalo	bolus lento
Preparo/administração	Pode usar pura; diluir para volumes muito pequenos conforme protocolo
Monitorização	PA, FC, SpO ₂ , ETCO ₂ ; prontidão para via aérea
Cautelas	Não garante reflexos protetores; pode causar apneia/laringoespasma
Situação	Uso anestésico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

188. Cetamina

Indicação	Sedação dissociativa para procedimento
Via	EV
Apresentação	50 mg/mL
Dose	1–1,5 mg/kg inicial; 0,25–0,5 mg/kg de reforço
Máximo	4,5 mg/kg total; >2,5 mg/kg aumenta eventos
Intervalo	reforços a cada 10 min
Preparo/administração	EV em 1–2 min; equipe e material de via aérea
Monitorização	Oximetria, ECG, observação contínua de via aérea
Cautelas	Considerar abortar se requerer >2,5 mg/kg
Situação	Uso consolidado; pode ser off-label conforme produto
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

189. Cetamina

Indicação	Sedação dissociativa sem acesso venoso
Via	IM
Apresentação	50 mg/mL
Dose	4 mg/kg inicial; reforço 2 mg/kg
Máximo	6 mg/kg total
Intervalo	reforço após 10 min
Preparo/administração	IM profunda
Monitorização	Oximetria, ECG, observação de via aérea
Cautelas	Recuperação mais longa; risco de vômito/laringoespasma
Situação	Uso consolidado; pode ser off-label conforme produto
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

190. Cetirizina

Indicação	Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Situação	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

191. Cetirizina

Indicação	Urticária — tratamento sintomático conforme idade
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Situação	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

192. Cetoconazol

Indicação	Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente
Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Situação	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

193. Cetoprofeno

Indicação	Dor inflamatória — uso selecionado conforme idade/bula
Via	VO
Apresentação	Solução oral 20 mg/mL
Dose	1 mg/kg/dose
Máximo	máximo diário conforme idade e bula; arquivo-base cita 300 mg/dia
Intervalo	8/8–12/12 h conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar concentração 20 mg/mL; medir com seringa
Monitorização	Dor, tolerância GI, hidratação e função renal quando pertinente
Cautelas	Evitar em desidratação, disfunção renal, sangramento GI, dengue e alergia a AINE
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

194. Ciclesonida

Indicação	Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade
Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Situação	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

195. Ciclesonida

Indicação	Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade
Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Situação	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

196. Ciclopiroxolamina

Indicação	Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente
Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Situação	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

197. Cimetidina

Indicação	Doença ácido-péptica — uso selecionado
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar interações e função renal; não usar ranitidina disponível de origem não autorizada
Situação	Ranitidina permanece suspensa/retirada por risco de NDMA; não gerar dose
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

198. Cimetidina

Indicação	Refluxo gastroesofágico — uso selecionado
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar interações e função renal; não usar ranitidina disponível de origem não autorizada
Situação	Ranitidina permanece suspensa/retirada por risco de NDMA; não gerar dose
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

199. Cinchocaína

Indicação	Dor/inflamação local — uso tópico conforme produto e idade
Via	Tópica/oromucosa/retal conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Evitar ingestão, uso em mucosa lesada extensa e formulação inadequada para a idade
Situação	Posologia por aplicação depende da formulação; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

200. Ciprofloxacina

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

201. Claritromicina

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

202. Clemastina

Indicação	Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Situação	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

203. Clemastina

Indicação	Urticária — tratamento sintomático conforme idade
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Situação	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

204. Clindamicina

Indicação	Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria sensível — gravidade moderada — opção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola brasileira 600 mg/4 mL = 150 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose = 30 mg/kg/dia
Máximo	máximo 600 mg (4 mL) por dose IM
Intervalo	8/8 h
Preparo/administração	Usar sem diluição para administração IM; aplicar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Resposta clínica, diarreia/colite por <i>C. difficile</i> , hemograma e função hepática em curso prolongado
Cautelas	Não usar para meningite. Em sepse, infecção necrosante, intra-abdominal/pélvica grave ou instabilidade, preferir EV e cobertura combinada apropriada.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; dose parenteral pediátrica dentro da faixa de bula
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

205. Clindamicina

Indicação	Infecção dentária por bactéria sensível — gravidade moderada — opção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola brasileira 600 mg/4 mL = 150 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose = 30 mg/kg/dia
Máximo	máximo 600 mg (4 mL) por dose IM
Intervalo	8/8 h
Preparo/administração	Usar sem diluição para administração IM; aplicar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Resposta clínica, diarreia/colite por <i>C. difficile</i> , hemograma e função hepática em curso prolongado
Cautelas	Não usar para meningite. Em sepse, infecção necrosante, intra-abdominal/pélvica grave ou instabilidade, preferir EV e cobertura combinada apropriada.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; dose parenteral pediátrica dentro da faixa de bula
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

206. Clindamicina

Indicação	Infecção osteoarticular ou toxina/necrosante
Via	EV
Apresentação	150 mg/mL
Dose	13 mg/kg/dose
Máximo	900 mg/dose
Intervalo	a cada 8 h
Preparo/administração	Diluir; associar ao antimicrobiano definitivo quando supressão de toxina
Monitorização	Culturas, CK conforme síndrome, colite
Cautelas	Não usar monoterapia em choque toxigênico sem cobertura adequada
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

207. Clindamicina

Indicação	Infecção respiratória por bactéria sensível — gravidade moderada — opção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola brasileira 600 mg/4 mL = 150 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose = 30 mg/kg/dia
Máximo	máximo 600 mg (4 mL) por dose IM
Intervalo	8/8 h
Preparo/administração	Usar sem diluição para administração IM; aplicar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Resposta clínica, diarreia/colite por <i>C. difficile</i> , hemograma e função hepática em curso prolongado
Cautelas	Não usar para meningite. Em sepse, infecção necrosante, intra-abdominal/pélvica grave ou instabilidade, preferir EV e cobertura combinada apropriada.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; dose parenteral pediátrica dentro da faixa de bula
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

208. Clindamicina

Indicação	Pele/tecidos moles, anaeróbios, infecção dentária
Via	EV
Apresentação	600 mg/4 mL = 150 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose
Máximo	600 mg/dose
Intervalo	a cada 8 h
Preparo/administração	Diluir e respeitar velocidade da bula
Monitorização	Diarreia/colite, função hepática
Cautelas	Sem ajuste renal rotineiro; ajustar contexto hepático
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

209. Clioquinol

Indicação	Uso anti-infeccioso intestinal/tópico histórico — confirmar papel atual
Via	VO ou tópica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar registro, formulação e alternativa com melhor evidência
Situação	Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por baixa padronização atual
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

210. Clobazam

Indicação	Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica
Situação	Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

211. Clonazepam

Indicação	Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica
Situação	Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

212. Clonidina

Indicação	Abstinência de opioide/sedativo — prevenção ou tratamento
Via	VO/enteral
Apresentação	Comprimido 0,1 mg = 100 mcg; solução oral 10 mcg/mL somente se padronizada pela farmácia
Dose	inicial 0,5–1 mcg/kg/dose a cada 6 h; usual 0,5–4 mcg/kg/dose a cada 4–6 h
Máximo	4 mcg/kg/dose a cada 4 h
Intervalo	a cada 4–6 h; usar a menor dose eficaz
Preparo/administração	Usar solução 10 mcg/mL preparada/validada pela farmácia. Não improvisar solução à beira-leito sem dados de homogeneidade e estabilidade
Monitorização	PA, FC, sedação e escore de abstinência
Cautelas	Reater/reduzir se bradicardia ou hipotensão; retirar gradualmente em 1–2 semanas para evitar hipertensão rebote
Situação	Off-label pediátrico
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: sim

213. Clonidina

Indicação	Transição/desmame de dexmedetomidina prolongada
Via	VO/enteral
Apresentação	Comprimido 0,1 mg = 100 mcg; solução oral 10 mcg/mL somente se padronizada pela farmácia
Dose	1 mcg/kg/dose a cada 6 h foi o regime inicial mais frequente em protocolo publicado; individualizar
Máximo	não há conversão universal dexmedetomidina→clonidina
Intervalo	a cada 6 h durante a transição; desmame posterior protocolizado
Preparo/administração	Usar solução 10 mcg/mL validada; reduzir a dexmedetomidina somente conforme protocolo e resposta hemodinâmica
Monitorização	PA, FC, WAT-1/sinais de abstinência de agonista α_2
Cautelas	Bradicardia/hipotensão; não suspender clonidina abruptamente; maior evidência observacional
Situação	Off-label; protocolo institucional
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: sim

214. Cloperastina

Indicação	Tosse seca intensa — uso excepcional após excluir causa tratável
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não usar em lactentes; revisar sedação, interação serotoninérgica e contraindicações específicas
Situação	Antitussígeno não rotineiro; resposta depende das restrições etárias e do benefício esperado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

215. Cloranfenicol

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

216. Cloreto de potássio (KCl)

Indicação	Aditivo em manutenção após diurese estabelecida
Via	EV em solução de manutenção
Apresentação	19,1% = 2,5 mEq/mL
Dose	20 mEq/L usual; individualizar 0–40 mEq/L
Máximo	não adicionar se oligúria/IR/hipercalcemia
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	Retirar 4 mL da bolsa de 500 mL e adicionar 4 mL de KCl 19,1%
Monitorização	K, creatinina, diurese
Cautelas	Homogeneizar e rotular; bomba; dupla checagem
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

217. Cloreto de potássio (KCl)

Indicação	Reposição EV de hipocalcemia
Via	EV em BIC
Apresentação	19,1% = 2,5 mEq/mL
Dose	0,5–1 mEq/kg conforme gravidade
Máximo	velocidade usual <0,25 mEq/kg/h; nunca >0,5 mEq/kg/h; máx. 30 mEq/h
Intervalo	contínuo; reavaliar por ciclos
Preparo/administração	SEMPRE diluir; usual 20–40 mEq/L periférico; concentrações maiores só em protocolo
Monitorização	ECG, K seriado, função renal, acesso
Cautelas	Nunca IV direto; dupla checagem independente
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

218. Cloreto de sódio 0,9%

Indicação	Choque/hipoperfusão — bolus
Via	EV/IO
Apresentação	Bolsa 100–500 mL
Dose	10–20 mL/kg
Máximo	reavaliar antes de repetir
Intervalo	bolus em 5–20 min conforme choque
Preparo/administração	Solução pronta, aquecer se grande volume
Monitorização	Perfusão, PA, crepitações, hepatomegalia, diurese
Cautelas	Em sepse, reavaliar a cada bolus e interromper se sobrecarga
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

219. Cloreto de sódio 0,9%

Indicação	Manutenção pediátrica isotônica
Via	EV
Apresentação	Bolsa; preferir com dextrose e K apropriados
Dose	100%: regra 4–2–1 mL/kg/h
Máximo	individualizar; frequentemente reduzir em risco de ADH
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	Combinar com dextrose e KCl apropriados; ver aba Soroterapia 100%
Monitorização	Na, glicemia, balanço, peso
Cautelas	Não usar fórmula automática em RN <28 d, DKA, IR, IC ou distúrbios do Na
Situação	Diretriz pediátrica ≥28 dias
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

220. Cloroquina

Indicação	Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária
Via	VO ou tópica conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Situação	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

221. Clorpromazina

Indicação	Indicação neurológica/sedativa especializada
Via	VO ou via hospitalar conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar depressão do SNC, QT, efeitos extrapiramidais e necessidade de monitorização cardiorrespiratória
Situação	Uso restrito/off-label conforme cenário; selecionar protocolo especializado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: sim

222. Clotrimazol

Indicação	Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente
Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Situação	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

223. Codeína

Indicação	Dor moderada/intensa — opção opioide selecionada por protocolo e idade
Via	VO, EV, IM ou transmucosa conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Monitorar ventilação/sedação; codeína e tramadol têm restrições importantes em menores de 12 anos e após adenoamigdalectomia
Situação	Uso restrito; resposta condicionada às contraindicações etárias e à variabilidade metabólica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

224. Colagenase

Indicação	Desbridamento enzimático de lesão selecionada
Via	Tópica
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Proteger pele íntegra; confirmar indicação e curativo/protocolo de feridas
Situação	Aplicação depende da concentração, área e tipo de lesão; não calcular por peso
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

225. Colagenase

Indicação	Hidratação cutânea de lesão selecionada
Via	Tópica
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Proteger pele íntegra; confirmar indicação e curativo/protocolo de feridas
Situação	Aplicação depende da concentração, área e tipo de lesão; não calcular por peso
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

226. Colchicina

Indicação	Doença inflamatória/metabólica específica — uso especializado
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Janela terapêutica/interações relevantes; monitorar hemograma, função renal/hepática conforme fármaco
Situação	Dose e titulação dependem da doença e idade; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

227. Cromoglicato dissódico

Indicação	Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto
Via	Nasal ou oftálmica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Situação	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

228. Cromoglicato dissódico

Indicação	Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto
Via	Nasal ou oftálmica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Situação	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

229. Deflazacorte

Indicação	Doença inflamatória/alérgica específica — corticoide sistêmico ou tópico
Via	VO, IM, tópica ou intra-articular conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; avaliar duração, desmame e imunossupressão
Situação	Potência e equivalência variam; selecionar indicação e formulação antes de calcular
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

230. Deltametrina

Indicação	Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária
Via	VO ou tópica conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Situação	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

231. Desloratadina

Indicação	Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Situação	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

232. Desloratadina

Indicação	Urticária — tratamento sintomático conforme idade
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Situação	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

233. Dexametasona

Indicação	Crupe
Via	VO/IM/EV
Apresentação	4 mg/mL
Dose	0,6 mg/kg, dose única
Máximo	12 mg no protocolo RCH; até 16 mg em outros protocolos
Intervalo	dose única
Preparo/administração	VO preferida se tolerada; EV/IM conforme gravidade
Monitorização	Estridor e esforço respiratório
Cautelas	Observar após adrenalina nebulizada; não atrasar manejo de via aérea
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

234. Dexametasona

Indicação	Exacerbação aguda de asma
Via	VO/EV/IM
Apresentação	4 mg/mL
Dose	0,6 mg/kg/dose
Máximo	16 mg/dose
Intervalo	a cada 24 h por 1–2 doses
Preparo/administração	VO se possível
Monitorização	Resposta clínica, glicemia em risco
Cautelas	Não substitui broncodilatador; esquema local pode usar prednisolona
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

235. Dexametasona

Indicação	Meningite bacteriana — adjuvante selecionado
Via	EV
Apresentação	4 mg/mL
Dose	0,15 mg/kg/dose
Máximo	10 mg/dose
Intervalo	a cada 6 h por 4 dias
Preparo/administração	Administrar antes ou com a primeira dose do antibiótico
Monitorização	Audição, evolução neurológica
Cautelas	Benefício depende de agente/epidemiologia; não iniciar tardiamente sem indicação
Situação	Uso por indicação específica; confirmar protocolo
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

236. Dexmedetomidina

Indicação	Sedação contínua em VM/pós-IOT
Via	EV em BIC
Apresentação	200 mcg/2 mL = 100 mcg/mL; solução final padrão 4 mcg/mL
Dose	0,2–1 mcg/kg/h; titular pela meta de sedação; evitar bolus em instabilidade
Máximo	até 2 mcg/kg/h apenas em protocolo especializado; usar a menor dose eficaz
Intervalo	contínuo; titular em incrementos conforme protocolo
Preparo/administração	Aspirar 2 mL (200 mcg) + 48 mL de SF 0,9% = 50 mL a 4 mcg/mL. mL/h = dose×peso÷4
Monitorização	ECG, PA, SpO ₂ , perfusão e escala COMFORT-B/SBS; avaliar delirium/abstinência
Cautelas	Reduzir/titular cautelosamente na disfunção hepática; bradicardia, bloqueio AV, disfunção ventricular e hipovolemia; desmame após uso prolongado
Situação	Off-label pediátrico no Brasil; diretriz/uso em CTI
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

237. Dexmedetomidina

Indicação	Sedação de procedimento não invasivo — 1 mês a <2 anos
Via	EV em bomba
Apresentação	200 mcg/2 mL = 100 mcg/mL; solução final 4 mcg/mL
Dose	carga 1,5 mcg/kg em 10 min; manutenção 0,5–1,5 mcg/kg/h (iniciar 1,5 e titular)
Máximo	1,5 mcg/kg/h; não administrar carga rápida
Intervalo	carga em 10 min, seguida de infusão
Preparo/administração	2 mL + 48 mL de SF 0,9% = 50 mL a 4 mcg/mL. Para a carga, programar mL/h = volume calculado×6 durante 10 min
Monitorização	ECG, PA, SpO ₂ e ventilação contínuas; capnografia conforme sedação; equipe de resgate de via aérea
Cautelas	Procedimento não doloroso; analgesia adicional se houver dor. Maior risco de bradicardia/hipotensão; reduzir na disfunção hepática
Situação	Aprovado nos EUA (bula 05/2026); off-label pediátrico no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

238. Dexmedetomidina

Indicação	Sedação de procedimento não invasivo — 2 a <18 anos
Via	EV em bomba
Apresentação	200 mcg/2 mL = 100 mcg/mL; solução final 4 mcg/mL
Dose	carga 2 mcg/kg em 10 min; manutenção 0,5–1,5 mcg/kg/h (iniciar 1,5 e titular)
Máximo	1,5 mcg/kg/h; não administrar carga rápida
Intervalo	carga em 10 min, seguida de infusão
Preparo/administração	2 mL + 48 mL de SF 0,9% = 50 mL a 4 mcg/mL. Para a carga, programar mL/h = volume calculado×6 durante 10 min
Monitorização	ECG, PA, SpO ₂ e ventilação contínuas; capnografia conforme sedação; equipe de resgate de via aérea
Cautelas	Procedimento não doloroso; analgesia adicional se houver dor. Maior risco de bradicardia/hipotensão; reduzir na disfunção hepática
Situação	Aprovado nos EUA (bula 05/2026); off-label pediátrico no Brasil
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

239. Dexmedetomidina

Indicação	Sedação para exame de imagem não doloroso (RM ou TC) sem acesso venoso — 1 mês a 10 anos
Via	IM profunda — off-label
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 200 mcg/2 mL = 100 mcg/mL; bula nacional aprova somente uso EV em adultos
Dose	1–4 mcg/kg por aplicação IM no estudo; foram usadas aplicações únicas ou repetidas e a dose total média foi 2,4 mcg/kg para TC e 2,9 mcg/kg para RM
Máximo	sem máximo absoluto pediátrico validado; não repetir automaticamente e não extrapolar fora de protocolo formal de sedação
Intervalo	aplicação inicial; reavaliar sedação e hemodinâmica após 10–15 min (início médio no estudo: 13 min); qualquer nova aplicação exige protocolo institucional
Preparo/administração	Solução 100 mcg/mL sem diluição: 0,01–0,04 mL/kg/dose. Administrar profundamente em massa muscular adequada; documentar dose cumulativa.
Monitorização	Sedação formal: ECG, PA seriada, SpO ₂ contínua e capnografia conforme profundidade; equipe e material de resgate de via aérea disponíveis
Cautelas	Não usar como analgesia exclusiva em procedimento doloroso. No estudo, 14% tiveram hipotensão transitória; cautela em hipovolemia, bradicardia, bloqueio AV e disfunção ventricular. Reduzir/titular com cautela na disfunção hepática.
Situação	Off-label pediátrico e off-label por via no Brasil; evidência observacional limitada (coorte retrospectiva de 65 crianças)
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

240. Dexmedetomidina

Indicação	Sedação/premedicação para procedimento não doloroso — via intranasal off-label, de 1 mês a <18 anos
Via	Intranasal com atomizador — off-label
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 200 mcg/2 mL = 100 mcg/mL; uso intranasal da solução injetável é off-label
Dose	2–3 mcg/kg/dose IN; administrar 30–45 min antes quando usado como premedicação
Máximo	sem máximo absoluto pediátrico universal; volume preferencial ≤0,3 mL por narina por aplicação; não repetir automaticamente
Intervalo	dose única; reavaliar após 30 min conforme protocolo de sedação
Preparo/administração	Solução 100 mcg/mL sem diluição: 0,02–0,03 mL/kg. Dividir o volume entre as narinas; se exceder 0,3 mL por narina, fracionar conforme protocolo/dispositivo.
Monitorização	Sedação formal: ECG, PA seriada, SpO ₂ contínua e capnografia conforme profundidade; equipe e material de resgate de via aérea disponíveis
Cautelas	Início mais lento e resposta variável; estímulo pode despertar o paciente. Bradicardia/hipotensão; cautela em hipovolemia, distúrbio de condução e disfunção ventricular/hepática. Analgesia adicional se o procedimento for doloroso.
Situação	Off-label pediátrico e off-label por via no Brasil; sustentado por revisão sistemática pediátrica e protocolos especializados
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

241. Dextroclorofeniramina

Indicação	Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Situação	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

242. Dextroclorofeniramina

Indicação	Urticária — tratamento sintomático conforme idade
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Situação	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

243. Dextrometorfano

Indicação	Tosse seca intensa — uso excepcional após excluir causa tratável
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não usar em lactentes; revisar sedação, interação serotoninérgica e contraindicações específicas
Situação	Antitussígeno não rotineiro; resposta depende das restrições etárias e do benefício esperado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

244. Diazepam

Indicação	Estado de mal epiléptico com acesso EV
Via	EV
Apresentação	5 mg/mL
Dose	0,15–0,2 mg/kg
Máximo	10 mg/dose
Intervalo	pode repetir uma vez conforme protocolo; máximo 2 benzodiazepínicos
Preparo/administração	EV lento; não misturar sem compatibilidade
Monitorização	FR, SpO ₂ , PA; ventilação disponível
Cautelas	Risco de depressão respiratória e hipotensão
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

245. Diazepam

Indicação	Estado de mal sem acesso venoso
Via	Retal
Apresentação	Solução retal padronizada 5 mg/mL ou aplicador comercial
Dose	0,5 mg/kg
Máximo	20 mg/dose
Intervalo	dose de resgate; respeitar total de benzodiazepínicos
Preparo/administração	Cálculo válido apenas para solução retal 5 mg/mL. Se gel/aplicador pré-cheio, selecionar a dose comercial mais próxima conforme protocolo; não extrapolar ampola EV para via retal sem validação.
Monitorização	FR, SpO ₂ , nível de consciência
Cautelas	Via intranasal com ampola não deve ser presumida; usar produto/protocolo específico
Situação	Diretriz pediátrica; formulação retal apropriada
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

246. Diccloverina

Indicação	Dor abdominal espasmódica — uso sintomático selecionado após excluir causa cirúrgica
Via	VO, IM ou EV conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Efeitos anticolinérgicos; evitar em glaucoma, retenção urinária, íleo e suspeita de obstrução
Situação	Dose e idade mínima variam por sal/apresentação; não intercambiar sais
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

247. Diclofenaco (dietilamônio, potássico, sódico)

Indicação	Dor/inflamação ou indicação especializada — uso condicionado à idade e ao diagnóstico
Via	VO, retal ou tópica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Evitar em desidratação, doença renal, sangramento GI e dengue; AAS não usar em virose salvo indicação específica
Situação	Resposta condicionada às restrições etárias e à indicação específica
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

248. Didanosina

Indicação	Uso anti-infeccioso histórico — avaliar alternativa contemporânea
Via	Conforme produto histórico
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não utilizar com base apenas em manual antigo; confirmar registro, disponibilidade e protocolo especializado
Situação	Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por obsolescência ou ausência de papel atual rotineiro
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

249. Digoxina

Indicação	Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg
Situação	Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

250. Digoxina

Indicação	Taquiarritmia supraventricular — controle/manutenção selecionada
Via	VO ou EV
Apresentação	Elixir 50 mcg/mL; confirmar produto e unidade
Dose	Selecionar regime por idade e cardiopediatria; diferenciar mcg de mg
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Monitorar ECG, K, Mg, função renal e nível quando indicado; múltiplas interações
Situação	Dose de ataque/manutenção varia por idade; selecionar o regime cardiopediátrico
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

251. Dimenidrinato

Indicação	Náuseas/vômitos — uso selecionado após tratar a causa e avaliar risco de QT
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar QT, distonia/efeitos extrapiramidais, interações e distúrbios eletrolíticos
Situação	Não usar rotineiramente; dose/idade dependem do produto e da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

252. Dimeticona

Indicação	Distensão/gases — alívio sintomático quando indicado
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Benefício variável; não mascara sinais de abdome agudo
Situação	Dose fixa por faixa etária e concentração do produto; não converter sem selecionar apresentação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

253. Dipirona (metamizol)

Indicação	Dor aguda
Via	VO/EV/IM
Apresentação	500 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose
Máximo	respeitar máximo por peso/idade e bula do produto
Intervalo	a cada 6 h se necessário
Preparo/administração	EV lenta; diluir se protocolo exigir
Monitorização	PA na via EV; reação alérgica
Cautelas	Evitar em hipersensibilidade a pirazonas ou discrasia prévia
Situação	Uso pediátrico conforme protocolo brasileiro
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

254. Dipirona (metamizol)

Indicação	Febre com desconforto
Via	VO/EV/IM
Apresentação	500 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose
Máximo	respeitar máximo por peso/idade e bula do produto
Intervalo	a cada 6 h se necessário
Preparo/administração	EV lenta; diluir se protocolo exigir
Monitorização	PA na via EV; reação alérgica
Cautelas	Evitar em hipersensibilidade a pirazonas ou discrasia prévia
Situação	Uso pediátrico conforme protocolo brasileiro
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

255. Dobutamina

Indicação	Choque com baixo débito/disfunção miocárdica
Via	EV/IO em BIC
Apresentação	Concentração padrão 1.000 mcg/mL (1 mg/mL)
Dose	5–20 mcg/kg/min
Máximo	titular à perfusão e débito; máximo conforme protocolo
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	Preparar concentração final de 1 mg/mL conforme farmácia/protocolo; bomba e linha dedicada quando indicada
Monitorização	PA, ECG, perfusão, diurese, lactato e sítio do acesso
Cautelas	Alta vigilância; corrigir hipovolemia quando pertinente; pode causar taquiarritmia/hipotensão
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

256. Domperidona

Indicação	Náuseas/vômitos — uso selecionado após tratar a causa e avaliar risco de QT
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar QT, distonia/efeitos extrapiramidais, interações e distúrbios eletrolíticos
Situação	Não usar rotineiramente; dose/idade dependem do produto e da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

257. Dopamina

Indicação	Choque com necessidade de suporte inotrópico/vasopressor — alternativa selecionada
Via	EV/IO em BIC
Apresentação	Concentração padrão 1.600 mcg/mL
Dose	5–20 mcg/kg/min
Máximo	titular ao efeito; preferir agentes orientados pelo fenótipo do choque
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	Preparar 400 mg em volume final de 250 mL = 1.600 mcg/mL; confirmar protocolo/biblioteca
Monitorização	PA, ECG, perfusão, lactato, diurese e sítio periférico
Cautelas	Alta vigilância; arritmogênica; não usar 'dose renal'
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

258. Dornase alfa

Indicação	Fibrose cística com secreção viscosa — manutenção inalatória
Via	Inalatória
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não misturar com outros fármacos no nebulizador; seguir equipe de fibrose cística
Situação	Dose fixa por ampola/dispositivo; uso especializado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

259. Doxiciclina

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

260. Dropropizina

Indicação	Tosse seca intensa — uso excepcional após excluir causa tratável
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não usar em lactentes; revisar sedação, interação serotoninérgica e contraindicações específicas
Situação	Antitussígeno não rotineiro; resposta depende das restrições etárias e do benefício esperado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

261. Ebastina

Indicação	Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Situação	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

262. Ebastina

Indicação	Urticária — tratamento sintomático conforme idade
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Situação	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

263. Emedastina

Indicação	Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto
Via	Nasal ou oftálmica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Situação	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

264. Emedastina

Indicação	Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto
Via	Nasal ou oftálmica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Situação	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

265. Epinastina

Indicação	Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto
Via	Nasal ou oftálmica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Situação	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

266. Epinastina

Indicação	Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto
Via	Nasal ou oftálmica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Situação	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

267. Erdosteína

Indicação	Secreção respiratória espessa — uso mucolítico apenas quando individualmente indicado
Via	VO ou inalatória conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Pode aumentar volume de secreções/broncoespasmo; contraindicações e idade mínima variam por produto
Situação	Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; resposta depende da idade e apresentação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

268. Eritromicina

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

269. Escopolamina

Indicação	Dor abdominal espasmódica — uso sintomático selecionado após excluir causa cirúrgica
Via	VO, IM ou EV conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Efeitos anticolinérgicos; evitar em glaucoma, retenção urinária, íleo e suspeita de obstrução
Situação	Dose e idade mínima variam por sal/apresentação; não intercambiar sais
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

270. Esmolol

Indicação	Emergência hipertensiva com indicação de beta-bloqueio
Via	EV em BIC
Apresentação	10 mg/mL
Dose	bolus 100–500 mcg/kg; depois 100–500 mcg/kg/min
Máximo	1.000 mcg/kg/min
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	Bomba e monitorização contínua
Monitorização	PA e ECG
Cautelas	Escolha depende da etiologia; evitar em asma/IC descompensada
Situação	Off-label pediátrico
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

271. Esmolol

Indicação	Taquiarritmia supraventricular/controle de frequência
Via	EV em BIC
Apresentação	10 mg/mL
Dose	bolus 100–500 mcg/kg; depois 100–500 mcg/kg/min
Máximo	1.000 mcg/kg/min
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	Diluição padronizada; bomba
Monitorização	ECG, PA contínua, perfusão
Cautelas	Evitar em choque, BAV, IC descompensada e broncoespasmo grave
Situação	Off-label pediátrico
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

272. Espiramicina

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

273. Espironolactona

Indicação	Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg
Situação	Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

274. Etofamida

Indicação	Uso anti-infeccioso intestinal/tópico histórico — confirmar papel atual
Via	VO ou tópica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar registro, formulação e alternativa com melhor evidência
Situação	Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por baixa padronização atual
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

275. Etomidato

Indicação	Indução para intubação
Via	EV
Apresentação	2 mg/mL
Dose	0,2–0,3 mg/kg
Máximo	dose única
Intervalo	bolus
Preparo/administração	Puro ou diluição mínima conforme protocolo
Monitorização	PA, mioclonias, ventilação
Cautelas	Evitar em sepse/choque séptico pediátrico quando houver alternativa
Situação	Uso anestésico; pediatria depende da bula
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

276. Fenitoína

Indicação	Estado de mal epiléptico — carga
Via	EV
Apresentação	50 mg/mL
Dose	20 mg/kg
Máximo	1,5 g
Intervalo	dose de carga
Preparo/administração	Somente SF 0,9%; infundir em 20 min; filtro conforme protocolo
Monitorização	ECG e PA contínuos
Cautelas	Não diluir em glicose; máx. 1 mg/kg/min e 50 mg/min
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

277. Fenitoína

Indicação	Manutenção após carga
Via	EV/VO
Apresentação	Solução injetável/oral de referência 50 mg/mL
Dose	5–8 mg/kg/dia divididos
Máximo	300–400 mg/dia usual adulto
Intervalo	a cada 8–12 h
Preparo/administração	Volume diário calculado a 50 mg/mL. Dividir em 2–3 tomadas conforme intervalo e via; para EV, usar somente diluente/linha compatíveis e monitorização.
Monitorização	Nível sérico, albumina, ECG se EV
Cautelas	Interações múltiplas; ajustar hepático e níveis
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

278. Fenobarbital

Indicação	Convulsão neonatal — carga
Via	EV
Apresentação	100 mg/mL
Dose	20 mg/kg; adicionais 10 mg/kg
Máximo	40 mg/kg total em muitos protocolos
Intervalo	conforme resposta
Preparo/administração	Aplicar protocolo neonatal; infusão lenta
Monitorização	EEG se disponível, FR, PA
Cautelas	Intervalo e manutenção dependem de IG/idade pós-natal
Situação	Uso neonatal estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

279. Fenobarbital

Indicação	Estado de mal epiléptico — segunda linha
Via	EV
Apresentação	200 mg/2 mL = 100 mg/mL
Dose	20 mg/kg
Máximo	1 g
Intervalo	dose de carga
Preparo/administração	Diluir/infundir conforme bula; máx. 1 mg/kg/min
Monitorização	FR, SpO ₂ , PA, sedação
Cautelas	Ventilação disponível; somar sedação de benzodiazepínicos
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

280. Fenobarbital

Indicação	Manutenção anticonvulsivante
Via	EV/VO
Apresentação	Ampola 100 mg/mL; diluição operacional 10 mg/mL
Dose	3–5 mg/kg/dia
Máximo	individualizar por nível
Intervalo	1–2 vezes/dia
Preparo/administração	Diluição operacional 1:10: 1 mL (100 mg) + 9 mL de diluente compatível = 10 mg/mL. Preparar/usar segundo farmácia, bula e protocolo de estabilidade.
Monitorização	Nível sérico, sedação, função hepática
Cautelas	Ajustar por níveis e função hepática/renal
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

281. Fenoterol

Indicação	Broncoespasmo agudo — alternativa beta-2 agonista conforme protocolo
Via	Inalatória ou EV conforme cenário
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Monitorar FC, K, glicemia e lactato em doses repetidas/infusão; preferir protocolo de asma
Situação	Selecionar formulação, via e faixa etária antes do cálculo
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

282. Fentanila

Indicação	Analgesia aguda EV
Via	EV
Apresentação	50 mcg/mL
Dose	0,5–2 mcg/kg/dose
Máximo	100 mcg/dose de referência; titular
Intervalo	a cada 30–60 min conforme resposta
Preparo/administração	EV lento em 3–5 min
Monitorização	FR, SpO ₂ , PA, sedação
Cautelas	Bolus rápido/dose alta pode causar rigidez torácica
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

283. Fentanila

Indicação	Analgesia intranasal sem acesso venoso (≥ 12 meses)
Via	Intranasal
Apresentação	Ideal 300 mcg/mL; ampola 50 mcg/mL limita volume
Dose	1,5 mcg/kg inicial; 0,75–1,5 mcg/kg de resgate
Máximo	100 mcg; usual 75 mcg se solução diluída
Intervalo	reavaliar em 5–10 min
Preparo/administração	Atomizador; dividir entre narinas
Monitorização	FR, SpO ₂ , sedação e dor
Cautelas	Evitar <12 meses, alteração de consciência ou obstrução/epistaxe bilateral
Situação	Off-label: via intranasal
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: sim

284. Fentanila

Indicação	Analgesia/sedação contínua pós-IOT
Via	EV em BIC
Apresentação	50 mcg/mL; concentração padronizada
Dose	0,5–4 mcg/kg/h; titular
Máximo	até 10 mcg/kg/h em protocolos especializados
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	Ex.: 500 mcg em 50 mL = 10 mcg/mL; mL/h = dose $\times$ peso/10
Monitorização	Sedação, dor, FR, PA; abstinência em uso prolongado
Cautelas	Dupla checagem de mcg e bomba
Situação	Off-label pediátrico conforme produto
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

285. Fentanila

Indicação	Sequência rápida de intubação/atenuação de resposta
Via	EV
Apresentação	50 mcg/mL
Dose	1–2 mcg/kg
Máximo	individualizar
Intervalo	dose única, lenta
Preparo/administração	Administrar lentamente antes da laringoscopia se hemodinamicamente adequado
Monitorização	PA, FC, FR, rigidez torácica
Cautelas	Não é agente de indução isolado; risco de hipotensão/bradicardia
Situação	Off-label por contexto
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

286. Fexofenadina

Indicação	Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Situação	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

287. Fexofenadina

Indicação	Urticária — tratamento sintomático conforme idade
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Situação	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

288. Fitomenadiona (Vitamina K)

Indicação	Profilaxia da deficiência de vitamina K no recém-nascido
Via	IM, VO ou EV conforme indicação/protocolo
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Via EV exige administração lenta e monitorização; confirmar produto e concentração
Situação	Dose depende de profilaxia versus sangramento e faixa de peso; não automatizada nesta linha
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

289. Fitomenadiona (Vitamina K)

Indicação	Tratamento da deficiência de vitamina K no recém-nascido
Via	IM, VO ou EV conforme indicação/protocolo
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Via EV exige administração lenta e monitorização; confirmar produto e concentração
Situação	Dose depende de profilaxia versus sangramento e faixa de peso; não automatizada nesta linha
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

290. Fluconazol

Indicação	Candidíase invasiva — tratamento
Via	VO ou EV
Apresentação	Solução oral 10 mg/mL ou solução EV 2 mg/mL
Dose	6–12 mg/kg/dose conforme foco e gravidade
Máximo	máximo 800 mg/dia no arquivo-base; confirmar protocolo
Intervalo	24/24 h
Preparo/administração	A saída calcula para solução oral 10 mg/mL; para EV 2 mg/mL multiplicar o volume por 5
Monitorização	Função hepática, QT/interações, culturas e resposta
Cautelas	Ajustar na disfunção renal; confirmar espécie/sensibilidade
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

291. Flumazenil

Indicação	Reversão selecionada de sedação por benzodiazepínico
Via	EV
Apresentação	0,1 mg/mL
Dose	0,01 mg/kg
Máximo	máximo inicial 0,2 mg; redosagem e máximo cumulativo conforme protocolo
Intervalo	reavaliar após 1 min; efeito pode ser mais curto que o benzodiazepínico
Preparo/administração	Administrar lentamente; manter suporte ventilatório
Monitorização	Ventilação, consciência, ECG e recorrência de sedação
Cautelas	Evitar em uso crônico de benzodiazepínico, epilepsia tratada ou intoxicação mista pró-convulsivante
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

292. Fluticasona

Indicação	Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade
Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Situação	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

293. Fluticasona

Indicação	Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade
Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Situação	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

294. Formoterol

Indicação	Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade
Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Situação	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

295. Formoterol

Indicação	Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade
Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Situação	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

296. Furazolidona

Indicação	Uso anti-infeccioso histórico — avaliar alternativa contemporânea
Via	Conforme produto histórico
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não utilizar com base apenas em manual antigo; confirmar registro, disponibilidade e protocolo especializado
Situação	Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por obsolescência ou ausência de papel atual rotineiro
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

297. Furosemida

Indicação	Infusão contínua em refratariedade
Via	EV em BIC
Apresentação	Padrão de infusão 2 mg/mL
Dose	0,05–0,4 mg/kg/h; iniciar 0,05 mg/kg/h e titular
Máximo	confirmar protocolo de UTI
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	Padrão 2 mg/mL: 10 mL de furosemida 10 mg/mL e completar para 50 mL com diluente compatível. Proteger compatibilidades e usar bomba.
Monitorização	Diurese horária, eletrólitos, PA
Cautelas	Avaliar resistência diurética e perfusão renal
Situação	Off-label pediátrico
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

298. Furosemida

Indicação	Sobrecarga volêmica/edema
Via	EV
Apresentação	10 mg/mL
Dose	1 mg/kg/dose; pode chegar a 2 mg/kg em refratariedade
Máximo	40 mg/dose inicial de referência; individualizar
Intervalo	a cada 12–24 h conforme resposta
Preparo/administração	EV em ≥5 min; pode diluir
Monitorização	Diurese, PA, Na, K, Mg, creatinina
Cautelas	Corrigir hipovolemia; risco de ototoxicidade com administração rápida
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

299. Gentamicina

Indicação	Bacteremia ou sepse por bactéria sensível — opção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)
Dose	2–2,5 mg/kg/dose
Máximo	individualizar por idade, função renal e níveis séricos
Intervalo	8/8 h
Preparo/administração	Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular
Cautelas	Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.
Situação	Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

300. Gentamicina

Indicação	Infecção de pele, osso ou tecidos moles por bactéria sensível — opção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)
Dose	2–2,5 mg/kg/dose
Máximo	individualizar por idade, função renal e níveis séricos
Intervalo	8/8 h
Preparo/administração	Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular
Cautelas	Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.
Situação	Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

301. Gentamicina

Indicação	Infecção do sistema nervoso central por bactéria sensível — em associação apropriada — opção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)
Dose	2–2,5 mg/kg/dose
Máximo	individualizar por idade, função renal e níveis séricos
Intervalo	8/8 h
Preparo/administração	Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular
Cautelas	Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.
Situação	Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

302. Gentamicina

Indicação	Infecção gastrointestinal por bactéria sensível — opção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)
Dose	2–2,5 mg/kg/dose
Máximo	individualizar por idade, função renal e níveis séricos
Intervalo	8/8 h
Preparo/administração	Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular
Cautelas	Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.
Situação	Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

303. Gentamicina

Indicação	Infecção grave por Gram-negativo — dose estendida
Via	EV
Apresentação	40 mg/mL
Dose	5–7,5 mg/kg/dose
Máximo	máximo e intervalo dependem de idade, função renal e protocolo de níveis
Intervalo	geralmente 24/24 h fora do período neonatal; individualizar
Preparo/administração	Aspirar volume calculado e diluir conforme protocolo; infundir em 30–60 min
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis quando indicados, ototoxicidade
Cautelas	Ajustar intervalo na disfunção renal; neonatos exigem esquema específico
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

304. Gentamicina

Indicação	Infecção intra-abdominal ou peritonite por bactéria sensível — opção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)
Dose	2–2,5 mg/kg/dose
Máximo	individualizar por idade, função renal e níveis séricos
Intervalo	8/8 h
Preparo/administração	Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular
Cautelas	Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.
Situação	Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

305. Gentamicina

Indicação	Infecção renal ou geniturinária por bactéria sensível — opção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)
Dose	2–2,5 mg/kg/dose
Máximo	individualizar por idade, função renal e níveis séricos
Intervalo	8/8 h
Preparo/administração	Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular
Cautelas	Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.
Situação	Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

306. Gentamicina

Indicação	Infecção respiratória por bactéria sensível — opção IM
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)
Dose	2–2,5 mg/kg/dose
Máximo	individualizar por idade, função renal e níveis séricos
Intervalo	8/8 h
Preparo/administração	Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular
Cautelas	Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.
Situação	Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

307. Gentamicina

Indicação	Sepse neonatal por bactéria sensível — opção IM no recém-nascido com até 1 semana
Via	IM profunda
Apresentação	Ampola pediátrica brasileira 20 mg/mL ou 40 mg/mL; cálculo exibido para 20 mg/mL
Dose	2,5–3 mg/kg/dose
Máximo	ajustar por idade gestacional, função renal e níveis séricos
Intervalo	12/12 h
Preparo/administração	Aspirar a dose da solução 20 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular
Cautelas	Em sepsis/choque, a via EV costuma ser preferida. Confirmar apresentação 20 mg/mL antes de usar o volume calculado.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema para prematuro/RN com até 1 semana
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

308. Glucametacina

Indicação	Dor/inflamação ou indicação especializada — uso condicionado à idade e ao diagnóstico
Via	VO, retal ou tópica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Evitar em desidratação, doença renal, sangramento GI e dengue; AAS não usar em virose salvo indicação específica
Situação	Resposta condicionada às restrições etárias e à indicação específica
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

309. Gluconato de cálcio

Indicação	Hipercalcemia com alteração no ECG
Via	EV
Apresentação	10% = 100 mg/mL
Dose	50–100 mg/kg
Máximo	10–20 mL conforme protocolo; repetir se ECG persistir
Intervalo	em 5–10 min se instável
Preparo/administração	Pode usar 10% não diluído em situação ameaçadora à vida
Monitorização	ECG contínuo, acesso e extravasamento
Cautelas	Não reduz K; estabiliza membrana. Não misturar com bicarbonato/fosfato
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

310. Gluconato de cálcio

Indicação	Hipocalcemia sintomática
Via	EV
Apresentação	10% = 100 mg/mL
Dose	50–200 mg/kg
Máximo	conforme protocolo e cálcio iônico
Intervalo	em 10–20 min
Preparo/administração	Diluir para 50 mg/mL quando estável
Monitorização	ECG, Ca iônico, sítio
Cautelas	Extravasamento causa necrose; acesso central preferível em alta concentração
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

311. Gluconato de cálcio

Indicação	Intoxicação por bloqueador de canal de cálcio/hipermagnesemia
Via	EV
Apresentação	10%
Dose	0,6–1 mL/kg
Máximo	repetição depende de ECG/hemodinâmica e toxicologia
Intervalo	conforme resposta
Preparo/administração	Consultar CIATox; bomba se infusão
Monitorização	ECG, Ca iônico, PA
Cautelas	Necessita protocolo toxicológico específico
Situação	Off-label por indicação toxicológica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

312. Gramicidina

Indicação	Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

313. Gramicidina

Indicação	Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

314. Granisetrona

Indicação	Náuseas/vômitos — uso selecionado após tratar a causa e avaliar risco de QT
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar QT, distonia/efeitos extrapiramidais, interações e distúrbios eletrolíticos
Situação	Não usar rotineiramente; dose/idade dependem do produto e da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

315. Griseofulvina

Indicação	Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente
Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Situação	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

316. Haloperidol

Indicação	Agitação psicomotora grave
Via	IM/VO
Apresentação	5 mg/mL
Dose	0,05–0,1 mg/kg/dose
Máximo	5 mg/dose
Intervalo	reavaliar; não repetir antes do intervalo do protocolo
Preparo/administração	Desescalada é primeira linha; IM profunda; evitar EV
Monitorização	ECG/QT, PA, distonia, sedação
Cautelas	Evitar em QT longo e toxíndromes anticolinérgica/simpaticomimética; considerar agente preferido do protocolo local
Situação	Off-label pediátrico
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

317. Haloperidol

Indicação	Delirium hiperativo em UTI
Via	EV/IM/VO conforme protocolo
Apresentação	5 mg/mL; preferir diluição para dose pequena
Dose	0,01–0,05 mg/kg/dose
Máximo	2 mg inicialmente; limite institucional
Intervalo	a cada 6–8 h se necessário
Preparo/administração	Usar concentração que permita medir; protocolo de delirium
Monitorização	ECG/QT, eletrólitos, sintomas extrapiramidais
Cautelas	Tratar causa do delirium; não usar rotineiramente sem avaliação especializada
Situação	Off-label pediátrico; evidência limitada
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

318. Hidralazina

Indicação	Emergência hipertensiva
Via	EV
Apresentação	20 mg/mL
Dose	0,1–0,2 mg/kg/dose
Máximo	0,6 mg/kg/dose
Intervalo	a cada 4–6 h conforme protocolo/resposta
Preparo/administração	Administrar em 3–5 min ou infusão intermitente conforme protocolo
Monitorização	PA frequente, FC, sintomas neurológicos
Cautelas	Resposta imprevisível; evitar queda excessiva; preferir agente titulável quando possível
Situação	Off-label pediátrico
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

319. Hidrato de cloral

Indicação	Indicação neurológica/sedativa especializada
Via	VO ou via hospitalar conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar depressão do SNC, QT, efeitos extrapiramidais e necessidade de monitorização cardiorrespiratória
Situação	Uso restrito/off-label conforme cenário; selecionar protocolo especializado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: sim

320. Hidroclorotiazida

Indicação	Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg
Situação	Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

321. Hidrocortisona

Indicação	Asma grave sem tolerância VO
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola 100 mg; diluição de trabalho 10 mg/mL
Dose	4 mg/kg/dose
Máximo	100 mg/dose
Intervalo	a cada 6 h
Preparo/administração	Reconstituir 100 mg conforme sistema/bula (solução 50 mg/mL). Para 10 mg/mL: 1 mL = 50 mg + 4 mL de SF 0,9%/SG 5%. Confirmar produto e estabilidade.
Monitorização	Glicemia, PA, resposta
Cautelas	Migrar para VO quando possível
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

322. Hidrocortisona

Indicação	Choque refratário com suspeita de insuficiência adrenal
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola 100 mg; diluição de trabalho 10 mg/mL
Dose	1–2 mg/kg/dose inicial
Máximo	seguir protocolo de UTI
Intervalo	conforme protocolo
Preparo/administração	Reconstituir 100 mg conforme sistema/bula (solução 50 mg/mL). Para 10 mg/mL: 1 mL = 50 mg + 4 mL de SF 0,9%/SG 5%. Confirmar produto e estabilidade.
Monitorização	PA, glicemia, eletrólitos
Cautelas	Usar se suspeita/documentação de insuficiência adrenal ou protocolo de choque refratário
Situação	Uso selecionado em diretriz
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

323. Hidrocortisona

Indicação	Crise adrenal
Via	EV/IM
Apresentação	Frasco-ampola 100 mg; diluição de trabalho 10 mg/mL
Dose	2 mg/kg IV/IM (máx. 100 mg) OU dose por faixa etária do protocolo
Máximo	100 mg inicial
Intervalo	seguido de reposição dividida/contínua
Preparo/administração	Reconstituir 100 mg conforme sistema/bula (solução 50 mg/mL). Para 10 mg/mL: 1 mL = 50 mg + 4 mL de SF 0,9%/SG 5%. Confirmar produto e estabilidade.
Monitorização	PA, glicemia, Na, K
Cautelas	Superfície corporal exige altura; não estimar sem altura
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

324. Hidroxicloroquina

Indicação	Doença reumatológica pediátrica — tratamento modificador
Via	VO
Apresentação	Comprimidos; manipulação pode ser necessária conforme peso
Dose	Não automatizada sem protocolo reumatológico e apresentação definida
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Monitorar retina, QT/interações e função renal/hepática conforme risco
Situação	Uso especializado; dose e máximo dependem do peso real e diagnóstico
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

325. Hidroxicloroquina

Indicação	Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária
Via	VO ou tópica conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Situação	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

326. Hidróxido de alumínio + magnésio

Indicação	Dispepsia/refluxo — uso eventual
Via	VO
Apresentação	Suspensão oral — concentração varia por marca
Dose	NÃO padronizar em mL/kg sem produto e idade
Máximo	≥12 anos: seguir bula do produto; <12 anos: avaliação médica
Intervalo	uso curto
Preparo/administração	Não há uma concentração universal segura para conversão automática. Registrar a concentração do produto antes de prescrever.
Monitorização	Sintomas, Mg/Al se uso repetido
Cautelas	Evitar em insuficiência renal; não usar 1–2 mL/kg como regra geral
Situação	Dados pediátricos e formulações variáveis
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

327. Hidroxiquinolina

Indicação	Uso anti-infeccioso intestinal/tópico histórico — confirmar papel atual
Via	VO ou tópica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar registro, formulação e alternativa com melhor evidência
Situação	Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por baixa padronização atual
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

328. Hidroxizina

Indicação	Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Situação	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

329. Hidroxizina

Indicação	Urticária — tratamento sintomático conforme idade
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Situação	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

330. Hioscina

Indicação	Dor abdominal espasmódica — uso sintomático selecionado após excluir causa cirúrgica
Via	VO, IM ou EV conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Efeitos anticolinérgicos; evitar em glaucoma, retenção urinária, íleo e suspeita de obstrução
Situação	Dose e idade mínima variam por sal/apresentação; não intercambiar sais
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

331. Ibuprofeno

Indicação	Dor aguda — criança hidratada
Via	VO
Apresentação	Gotas 100 mg/mL
Dose	5–10 mg/kg/dose
Máximo	máximo 40 mg/kg/dia; máximo absoluto conforme idade/bula
Intervalo	6/6–8/8 h se necessário
Preparo/administração	Confirmar que o frasco é 100 mg/mL; medir em mL com seringa
Monitorização	Dor/febre, hidratação, tolerância GI, diurese
Cautelas	Evitar em desidratação, disfunção renal, sangramento GI, suspeita de dengue e alergia a AINE
Situação	Uso pediátrico; respeitar idade/peso mínimos da bula
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

332. Ibuprofeno

Indicação	Febre com desconforto — criança hidratada
Via	VO
Apresentação	Gotas 100 mg/mL
Dose	5–10 mg/kg/dose
Máximo	máximo 40 mg/kg/dia; máximo absoluto conforme idade/bula
Intervalo	6/6–8/8 h se necessário
Preparo/administração	Confirmar que o frasco é 100 mg/mL; medir em mL com seringa
Monitorização	Dor/febre, hidratação, tolerância GI, diurese
Cautelas	Evitar em desidratação, disfunção renal, sangramento GI, suspeita de dengue e alergia a AINE
Situação	Uso pediátrico; respeitar idade/peso mínimos da bula
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

333. Idoxuridina

Indicação	Uso anti-infeccioso histórico — avaliar alternativa contemporânea
Via	Conforme produto histórico
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não utilizar com base apenas em manual antigo; confirmar registro, disponibilidade e protocolo especializado
Situação	Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por obsolescência ou ausência de papel atual rotineiro
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

334. Imipenem / cilastatina sódica

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

335. Indometacina

Indicação	Persistência do canal arterial em prematuros — fechamento farmacológico
Via	EV
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Avaliar função renal, plaquetas, perfusão intestinal/cerebral e contraindicações
Situação	Dose depende de idade pós-natal e protocolo neonatal específico
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

336. Ipratrópio brometo

Indicação	Crise asmática moderada/grave — primeiras doses
Via	Nebulização
Apresentação	0,25 mg/mL
Dose	<20 kg: 0,25 mg; ≥20 kg: 0,5 mg
Máximo	0,5 mg/dose
Intervalo	a cada 20 min por 3 doses; protocolos graves até 2 h
Preparo/administração	Associar a salbutamol; completar volume conforme nebulizador
Monitorização	FC, esforço, SpO ₂
Cautelas	Sem benefício como monoterapia de manutenção
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

337. Isoniazida

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

338. Ivermectina

Indicação	Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária
Via	VO ou tópica conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Situação	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

339. Ketodex (cetamina + dexmedetomidina)

Indicação	Sedoanalgesia procedural dolorosa — estratégia 1:1 protocolar
Via	EV lenta em bomba
Apresentação	Cetamina 50 mg/mL + dexmedetomidina 100 mcg/mL
Dose	cetamina 1 mg/kg + dexmedetomidina 1 mcg/kg em 10 min
Máximo	sem máximo universal; NÃO repetir automaticamente a combinação
Intervalo	dose inicial; reavaliar em 10–15 min
Preparo/administração	Se premix institucional for validado: cetamina 100 mg (2 mL) + dexmedetomidina 100 mcg (1 mL) + SF 0,9% 17 mL = 20 mL; finais 5 mg/mL + 5 mcg/mL. Administrar 0,2 mL/kg em 10 min. Caso contrário, preparar separadamente
Monitorização	Sedação formal: ECG, PA a cada 5 min, SpO ₂ e capnografia contínuas; O ₂ , aspiração e material de via aérea disponíveis
Cautelas	Não existe formulação comercial/premix universal. Bradicardia/hipotensão, secreções, vômitos e laringoespasmos; não presumir ausência de depressão respiratória
Situação	Off-label; estratégia sem padronização universal
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

340. Labetalol

Indicação	Emergência hipertensiva — bolus
Via	EV
Apresentação	5 mg/mL
Dose	0,2–1 mg/kg/dose
Máximo	40 mg/dose
Intervalo	a cada 10 min conforme resposta
Preparo/administração	EV lento
Monitorização	PA contínua/frequente, FC, perfusão
Cautelas	Evitar em asma, bradicardia, BAV e IC descompensada
Situação	Off-label pediátrico
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

341. Labetalol

Indicação	Emergência hipertensiva — infusão
Via	EV em BIC
Apresentação	Solução 5 mg/mL; concentração usual de infusão 5 mg/mL
Dose	0,25–1 mg/kg/h; titular
Máximo	3 mg/kg/h
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	Usar 5 mg/mL sem diluição adicional quando compatível com protocolo/equipamento; bomba e monitorização contínua.
Monitorização	PA e ECG contínuos
Cautelas	Mesmas contraindicações do bolus
Situação	Off-label pediátrico
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

342. Lactulose

Indicação	Constipação funcional — desimpactação
Via	VO ou retal conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias
Situação	Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

343. Lactulose

Indicação	Constipação funcional — manutenção
Via	VO ou retal conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias
Situação	Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

344. Lamotrigina

Indicação	Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica
Situação	Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

345. Lanatosídeo C

Indicação	Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg
Situação	Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

346. Levocabastina

Indicação	Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto
Via	Nasal ou oftálmica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Situação	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

347. Levocabastina

Indicação	Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto
Via	Nasal ou oftálmica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Situação	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

348. Levodropropizina

Indicação	Tosse seca intensa — uso excepcional após excluir causa tratável
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não usar em lactentes; revisar sedação, interação serotoninérgica e contraindicações específicas
Situação	Antitussígeno não rotineiro; resposta depende das restrições etárias e do benefício esperado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

349. Levofloxacin

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

350. Levotiroxina sódica

Indicação	Terapia endócrina de reposição — acompanhamento especializado
Via	VO ou SC conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não calcular superfície corporal sem altura; monitorar crescimento e exames específicos
Situação	Dose individualizada por idade, diagnóstico, alvo laboratorial e, às vezes, superfície corporal
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

351. Lidocaína

Indicação	FV/TV sem pulso refratária — alternativa antiarrítmica
Via	EV/IO
Apresentação	20 mg/mL (2%) sem vasoconstritor
Dose	1 mg/kg
Máximo	máximo 100 mg no bolus inicial; manutenção conforme PALS/protocolo
Intervalo	bolus
Preparo/administração	Confirmar concentração e ausência de vasoconstritor; administrar conforme algoritmo
Monitorização	ECG, pressão, perfusão e sinais de toxicidade neurológica
Cautelas	Alta vigilância; dose cumulativa e hepatopatia alteram risco de toxicidade
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

352. Lincomicina

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

353. Linezolid

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

354. Lodoxamida

Indicação	Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto
Via	Nasal ou oftálmica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Situação	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

355. Lodoxamida

Indicação	Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto
Via	Nasal ou oftálmica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Situação	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

356. Loratadina

Indicação	Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Situação	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

357. Loratadina

Indicação	Urticária — tratamento sintomático conforme idade
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Situação	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

358. Manitol

Indicação	Hipertensão intracraniana/edema cerebral — terapia hiperosmolar selecionada
Via	EV
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Monitorar osmolaridade, Na, função renal, volemia e risco de hipotensão/rebote
Situação	Dose e concentração dependem do cenário e de protocolo neurocrítico
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

359. Mebendazol

Indicação	Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária
Via	VO ou tópica conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Situação	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

360. Meropenem

Indicação	Infecção grave por Gram-negativo/ESBL sem meningite
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola 500 mg; solução de trabalho 50 mg/mL
Dose	20 mg/kg/dose
Máximo	máximo 1 g/dose nesta indicação; confirmar protocolo
Intervalo	8/8 h; infusão usual 15–30 min ou prolongada conforme protocolo
Preparo/administração	Reconstituir e diluir conforme bula/farmácia; concentração exibida 50 mg/mL
Monitorização	Função renal, resposta clínica, culturas, neurotoxicidade
Cautelas	Ajustar função renal; reservar conforme epidemiologia/antibiograma
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

361. Meropenem

Indicação	Meningite bacteriana ou infecção do SNC por agente sensível
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola 500 mg; solução de trabalho 50 mg/mL
Dose	40 mg/kg/dose
Máximo	máximo 2 g/dose; confirmar faixa etária/protocolo
Intervalo	8/8 h
Preparo/administração	Reconstituir e diluir conforme bula/farmácia; concentração exibida 50 mg/mL
Monitorização	Função renal, culturas, avaliação neurológica e resposta clínica
Cautelas	Ajustar função renal; risco de convulsões, sobretudo em predisposição
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

362. Metoclopramida

Indicação	Migrânea com náusea
Via	EV
Apresentação	5 mg/mL
Dose	0,1-0,15 mg/kg
Máximo	10 mg
Intervalo	dose única; reavaliar
Preparo/administração	Diluir e infundir lentamente
Monitorização	Acatisia/distonia
Cautelas	Considerar tratamento de reação extrapiramidal; ≥ 1 ano
Situação	Off-label pediátrico
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: sim

363. Metoclopramida

Indicação	Náusea/vômito — segunda linha em ≥ 1 ano
Via	EV/IM/VO
Apresentação	5 mg/mL
Dose	0,1-0,15 mg/kg/dose
Máximo	10 mg/dose; 0,5 mg/kg/dia
Intervalo	até 3 vezes/dia
Preparo/administração	EV lento ≥ 3 min
Monitorização	Distonia/acatisia, sedação
Cautelas	Contraindicada < 1 ano; uso curto; evitar em obstrução, Parkinsonismo e epilepsia descompensada
Situação	Uso pediátrico restrito
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

364. Metronidazol

Indicação	Infecção anaeróbia intra-abdominal grave
Via	EV
Apresentação	Bolsa 5 mg/mL
Dose	30 mg/kg/dia divididos 8/8 h = 10 mg/kg/dose
Máximo	máximo 4 g/dia no arquivo-base; confirmar foco
Intervalo	8/8 h
Preparo/administração	Solução pronta 5 mg/mL; infundir conforme bula/protocolo
Monitorização	Resposta clínica, função hepática em curso prolongado, neurotoxicidade
Cautelas	Ajustar em hepatopatia grave; revisar interações
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

365. Metronidazol

Indicação	Infecção odontogênica com componente anaeróbio — adjuvante quando indicado
Via	EV
Apresentação	Bolsa 5 mg/mL
Dose	30 mg/kg/dia divididos 8/8 h = 10 mg/kg/dose
Máximo	máximo 4 g/dia no arquivo-base; confirmar foco
Intervalo	8/8 h
Preparo/administração	Solução pronta 5 mg/mL; infundir conforme bula/protocolo
Monitorização	Resposta clínica, função hepática em curso prolongado, neurotoxicidade
Cautelas	Ajustar em hepatopatia grave; revisar interações
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

366. Midazolam

Indicação	Estado de mal com acesso EV/IO
Via	EV/IO
Apresentação	5 mg/mL
Dose	0,15 mg/kg
Máximo	10 mg/dose
Intervalo	pode repetir uma vez; máximo 2 doses de benzodiazepínico
Preparo/administração	EV lento; ventilação disponível
Monitorização	FR, SpO ₂ , PA, nível de consciência
Cautelas	Somar doses pré-hospitalares
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

367. Midazolam

Indicação	Estado de mal sem acesso — bucal/intranasal
Via	Bucal/IN
Apresentação	5 mg/mL
Dose	bucal 0,3 mg/kg; IN 0,2–0,3 mg/kg
Máximo	10 mg
Intervalo	dose de resgate; respeitar máximo de benzodiazepínicos
Preparo/administração	Atomizador na IN; dividir narinas
Monitorização	FR, SpO ₂ , PA
Cautelas	Volume nasal pode limitar; preferir formulação concentrada
Situação	Off-label: via com solução injetável; diretriz aceita
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

368. Midazolam

Indicação	Estado de mal sem acesso — IM
Via	IM
Apresentação	5 mg/mL
Dose	0,2 mg/kg
Máximo	10 mg
Intervalo	dose de resgate
Preparo/administração	IM profunda
Monitorização	FR, SpO ₂ , PA
Cautelas	Não atrasar segunda linha após 2 benzodiazepínicos
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

369. Midazolam

Indicação	Sedação contínua pós-IOT
Via	EV em BIC
Apresentação	5 mg/mL; diluição padronizada
Dose	0,025–0,12 mg/kg/h; faixa ampliada até 0,5 mg/kg/h em UTI
Máximo	titular por escala de sedação
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	Ex.: 50 mg em 50 mL = 1 mg/mL; mL/h = dose × peso
Monitorização	Sedação, PA, FR; delirium/abstinência
Cautelas	Acúmulo em insuficiência hepática/renal; dupla checagem
Situação	Off-label pediátrico conforme duração/contexto
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

370. Midazolam

Indicação	Sedação de procedimento
Via	EV
Apresentação	5 mg/mL; preferir diluição 1 mg/mL
Dose	0,025–0,1 mg/kg inicial conforme idade; titular
Máximo	6 mg (6m–5a) ou 10 mg (6–12a) em referência CHEO
Intervalo	incrementos após ≥ 2 –3 min
Preparo/administração	Diluir para 1 mg/mL para titulação
Monitorização	FR, SpO ₂ , PA; capnografia se sedação moderada/profunda
Cautelas	Não fornece analgesia; combinar aumenta depressão respiratória
Situação	Uso pediátrico em bula; faixa etária específica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

371. Mometasona

Indicação	Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade
Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Situação	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

372. Mometasona

Indicação	Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade
Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Situação	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

373. Monossulfiram

Indicação	Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária
Via	VO ou tópica conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Situação	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

374. Montelukaste sódico

Indicação	Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade
Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Situação	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

375. Montelukaste sódico

Indicação	Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade
Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Situação	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

376. Morfina

Indicação	Analgesia contínua pós-operatória/CTI
Via	EV em BIC
Apresentação	10 mg/mL; concentração padronizada
Dose	0,01–0,04 mg/kg/h
Máximo	titular por dor/sedação
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	Ex.: 50 mg em 50 mL = 1 mg/mL
Monitorização	FR, PA, sedação, íleo, abstinência
Cautelas	Não usar como terapia rotineira do edema agudo de pulmão pediátrico
Situação	Off-label pediátrico conforme contexto
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

377. Morfina

Indicação	Dor intensa — bolus
Via	EV/IM/SC
Apresentação	10 mg/mL; diluir para 1 mg/mL
Dose	0,05–0,1 mg/kg/dose
Máximo	5 mg/dose inicial de referência
Intervalo	a cada 2–4 h; titular
Preparo/administração	1 mL (10 mg) + 9 mL SF = 1 mg/mL
Monitorização	FR, SpO ₂ , PA, sedação, dor
Cautelas	Reduzir em hipovolemia; ajustar em disfunção renal
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

378. Moxifloxacina

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

379. Mupirocina

Indicação	Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

380. Mupirocina

Indicação	Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

381. N-acetil aspartilglutamato de sódio

Indicação	Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto
Via	Nasal ou oftálmica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Situação	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

382. N-acetil aspartilglutamato de sódio

Indicação	Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto
Via	Nasal ou oftálmica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Situação	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

383. Naloxona

Indicação	Depressão respiratória iatrogênica por opioide — reversão titulada
Via	EV/IM
Apresentação	0,4 mg/mL
Dose	1–5 mcg/kg; escalar para 10 mcg/kg
Máximo	100–400 mcg conforme resposta
Intervalo	a cada 2–3 min
Preparo/administração	Diluir 0,4 mg para 10 mL = 0,04 mg/mL para titulação
Monitorização	Ventilação, consciência, dor, abstinência
Cautelas	Objetivo é ventilação, não despertar completo em usuário crônico
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

384. Naloxona

Indicação	Overdose aguda com apneia/coma
Via	EV/IM/IN conforme produto/protocolo
Apresentação	0,4 mg/mL
Dose	0,1 mg/kg
Máximo	2 mg/dose
Intervalo	repetir a cada 2–3 min
Preparo/administração	Priorizar ventilação; solução pode ser usada pura
Monitorização	FR, SpO ₂ , consciência
Cautelas	Observar recorrência; meia-vida menor que muitos opioides
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

385. Naloxona

Indicação	Recorrência de toxicidade — infusão
Via	EV em BIC
Apresentação	Infusão de referência 100 mcg/mL
Dose	usual 24–40 mcg/kg/h; alternativamente $\approx 2/3$ do bolus efetivo de despertar por hora
Máximo	titular à ventilação
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	100 mcg/mL: 2 mg (5 mL de 0,4 mg/mL) + 15 mL de diluente = 20 mL. Titular à ventilação e ao menor grau de reversão necessário.
Monitorização	FR, consciência, abstinência
Cautelas	Consultar toxicologia; bolus de resgate pode ser necessário
Situação	Off-label: infusão contínua
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

386. Naproxeno

Indicação	Artrite em crianças ≥ 2 anos — uso selecionado
Via	VO
Apresentação	Suspensão 25 mg/mL
Dose	5–7 mg/kg/dose
Máximo	máximo 500 mg/dose no arquivo-base; confirmar indicação
Intervalo	12/12 h
Preparo/administração	Confirmar apresentação 25 mg/mL; agitar e medir com seringa
Monitorização	Dor/inflamação, tolerância GI, função renal e hidratação
Cautelas	Evitar em desidratação, doença renal, sangramento GI, dengue e alergia a AINE
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

387. Naproxeno

Indicação	Dor inflamatória em crianças ≥ 2 anos — uso selecionado
Via	VO
Apresentação	Suspensão 25 mg/mL
Dose	5–7 mg/kg/dose
Máximo	máximo 500 mg/dose no arquivo-base; confirmar indicação
Intervalo	12/12 h
Preparo/administração	Confirmar apresentação 25 mg/mL; agitar e medir com seringa
Monitorização	Dor/inflamação, tolerância GI, função renal e hidratação
Cautelas	Evitar em desidratação, doença renal, sangramento GI, dengue e alergia a AINE
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

388. Nedocromil sódico

Indicação	Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto
Via	Nasal ou oftálmica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Situação	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

389. Nedocromil sódico

Indicação	Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto
Via	Nasal ou oftálmica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Situação	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

390. Neomicina

Indicação	Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

391. Neomicina

Indicação	Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

392. Nifedipina

Indicação	Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg
Situação	Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

393. Nimesulida

Indicação	Dor/inflamação ou indicação especializada — uso condicionado à idade e ao diagnóstico
Via	VO, retal ou tópica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Evitar em desidratação, doença renal, sangramento GI e dengue; AAS não usar em virose salvo indicação específica
Situação	Resposta condicionada às restrições etárias e à indicação específica
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

394. Nimorazol

Indicação	Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária
Via	VO ou tópica conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Situação	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

395. Nistatina

Indicação	Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente
Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Situação	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

396. Nitrofurantoína

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

397. Nitroglicerina

Indicação	Edema pulmonar cardiogênico/insuficiência cardíaca com hipertensão
Via	EV em BIC
Apresentação	Padrão de infusão 200 mcg/mL
Dose	0,25–0,5 mcg/kg/min inicial; titular até 5 mcg/kg/min
Máximo	20 mcg/kg/min
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	Preparar em concentração final de 200 mcg/mL conforme produto/protocolo; usar frasco/equipo compatível e bomba.
Monitorização	PA contínua, perfusão, metemoglobina em altas doses
Cautelas	Contraindicada com inibidor PDE5 recente e hipotensão
Situação	Off-label pediátrico
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

398. Nitroglicerina

Indicação	Isquemia miocárdica no adolescente com hipertensão
Via	EV em BIC
Apresentação	Padrão de infusão 200 mcg/mL
Dose	0,25–0,5 mcg/kg/min; titular
Máximo	20 mcg/kg/min; protocolo cardiologia
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	Preparar em concentração final de 200 mcg/mL conforme produto/protocolo; usar frasco/equipo compatível e bomba.
Monitorização	PA, ECG, dor
Cautelas	Excluir uso de PDE5 e infarto de VD
Situação	Off-label pediátrico
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

399. Nitroprussiato de sódio

Indicação	Emergência hipertensiva
Via	EV em BIC
Apresentação	Padrão de infusão 200 mcg/mL
Dose	0,3–0,5 mcg/kg/min inicial; titular 0,5–8 mcg/kg/min
Máximo	10 mcg/kg/min apenas por curto período em protocolos
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	200 mcg/mL: 10 mg (0,4 mL de 25 mg/mL) + 49,6 mL de SG 5% = 50 mL. Proteger da luz; linha dedicada.
Monitorização	PA invasiva se possível, lactato/acidose; tiocianato em uso prolongado
Cautelas	Risco de cianeto/tiocianato, maior em IR/IH e altas doses
Situação	Uso pediátrico especializado
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

400. Nitroprussiato de sódio

Indicação	Insuficiência cardíaca com pós-carga elevada
Via	EV em BIC
Apresentação	Padrão de infusão 200 mcg/mL
Dose	0,3–5 mcg/kg/min
Máximo	titular à hemodinâmica
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	200 mcg/mL: 10 mg + diluente SG 5% até 50 mL. Proteger da luz; linha dedicada e monitorização invasiva quando indicada.
Monitorização	PA, perfusão, lactato
Cautelas	UTI/cardiologia; monitorar toxicidade
Situação	Off-label por contexto
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

401. Noradrenalina (norepinefrina)

Indicação	Anafilaxia refratária com vasoplegia apesar de adrenalina
Via	EV em BIC
Apresentação	Padrão de infusão 16 mcg/mL
Dose	0,05 mcg/kg/min; titular
Máximo	protocolo de UTI
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	16 mcg/mL: 4 mg em volume final de 250 mL. Bomba; central preferível, acesso periférico apenas com vigilância do sítio.
Monitorização	PA contínua, ECG, perfusão
Cautelas	Especialista/UTI; tratar causas reversíveis
Situação	Off-label; resgate especializado
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

402. Noradrenalina (norepinefrina)

Indicação	Choque vasoplégico/distributivo
Via	EV/IO em BIC
Apresentação	Padrão de infusão 16 mcg/mL
Dose	iniciar 0,05 mcg/kg/min; faixa 0,01–0,4 mcg/kg/min
Máximo	1 mcg/kg/min de referência; maior só protocolo especializado
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	16 mcg/mL: 4 mg em volume final de 250 mL. Bomba/biblioteca; dupla checagem de mcg versus mg.
Monitorização	PA, perfusão, lactato, diurese, sítio
Cautelas	Dupla checagem de mcg/min e extravasamento
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

403. Óleo mineral

Indicação	Constipação funcional — desimpactação
Via	VO ou retal conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias
Situação	Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

404. Óleo mineral

Indicação	Constipação funcional — manutenção
Via	VO ou retal conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias
Situação	Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

405. Olopatadina

Indicação	Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto
Via	Nasal ou oftálmica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Situação	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

406. Olopatadina

Indicação	Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto
Via	Nasal ou oftálmica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Situação	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

407. Omeprazol

Indicação	Úlcera péptica/erosiva sem hemorragia maciça
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola 40 mg; 4 mg/mL reconstituído; 0,4 mg/mL final
Dose	0,5 mg/kg/dose
Máximo	2 mg/kg/dia; limite institucional
Intervalo	a cada 12–24 h
Preparo/administração	Reconstituir 40 mg com 10 mL de SF 0,9% = 4 mg/mL. Aspirar a dose e diluir para 0,4 mg/mL; infundir em 30 min.
Monitorização	Sintomas, Mg se prolongado
Cautelas	Migrar para VO assim que possível; experiência EV pediátrica limitada
Situação	Off-label EV em pediatria conforme produto/local
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: sim

408. Ondansetrona

Indicação	Gastroenterite com vômitos — facilitar SRO
Via	VO
Apresentação	Solução 2 mg/mL; VO 4/8 mg
Dose	0,15 mg/kg, dose única; alternativa: 8–15 kg 2 mg, 15–30 kg 4 mg, >30 kg 8 mg
Máximo	8 mg
Intervalo	dose única
Preparo/administração	Preferir comprimido/solução oral
Monitorização	Hidratação; QT se fatores de risco
Cautelas	Aplicável tipicamente 6 meses–12 anos; não prescrever rotineiramente múltiplas doses para casa
Situação	Off-label para gastroenterite
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: sim

409. Ondansetrona

Indicação	Náusea por quimioterapia
Via	EV/VO
Apresentação	2 mg/mL
Dose	0,15–0,2 mg/kg/dose
Máximo	protocolo oncológico prevalece
Intervalo	primeira dose antes da quimioterapia; até 3 doses/24 h
Preparo/administração	Infundir conforme bula
Monitorização	QT, função hepática
Cautelas	Seguir protocolo oncológico específico
Situação	Uso pediátrico em bula/protocolo oncológico
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

410. Ondansetrona

Indicação	Náusea/vômito pós-operatório
Via	EV
Apresentação	2 mg/mL
Dose	0,1 mg/kg
Máximo	4 mg
Intervalo	dose; repetir conforme protocolo
Preparo/administração	EV lento
Monitorização	QT, eletrólitos em risco
Cautelas	Cautela em QT longo e hepatopatia grave
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

411. Oxacilina

Indicação	Infecção grave por MSSA sem SNC
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola 1 g; padrão operacional 100 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose
Máximo	2 g/dose; 12 g/dia
Intervalo	a cada 6 h
Preparo/administração	Reconstituir para 100 mg/mL; aspirar a dose e realizar diluição 1:5 para concentração final de 20 mg/mL, conforme protocolo/compatibilidade.
Monitorização	Culturas, função hepática/renal, neutropenia
Cautelas	Ajustar se disfunção hepática e renal concomitante
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

412. Oxacilina

Indicação	Infecção leve a moderada de vias aéreas superiores por estafilococo sensível — opção IM, <40 kg
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 500 mg; adicionar 2,7 mL de água para injetáveis → cerca de 500 mg/3 mL = 166,7 mg/mL
Dose	12,5 mg/kg/dose = 50 mg/kg/dia
Máximo	máximo 500 mg (3 mL) por dose nesta linha
Intervalo	6/6 h
Preparo/administração	Adicionar 2,7 mL de água para injetáveis, agitar até solução límpida e aplicar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função hepática/renal e hemograma em curso prolongado
Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Infecção grave, disseminada, SNC, endocardite ou osteomielite exige avaliação para esquema EV.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; linha IM restrita a infecção leve/moderada selecionada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

413. Oxacilina

Indicação	Infecção leve a moderada de vias aéreas superiores por estafilococo sensível — opção IM, ≥40 kg
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 500 mg; adicionar 2,7 mL de água para injetáveis → cerca de 500 mg/3 mL = 166,7 mg/mL
Dose	250-500 mg/dose
Máximo	máximo 500 mg (3 mL) por dose nesta linha
Intervalo	4/4-6/6 h conforme gravidade
Preparo/administração	Adicionar 2,7 mL de água para injetáveis, agitar até solução límpida e aspirar 1,5-3 mL.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função hepática/renal e hemograma em curso prolongado
Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Infecção grave, disseminada, SNC, endocardite ou osteomielite exige avaliação para esquema EV.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; linha IM restrita a infecção leve/moderada selecionada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

414. Oxacilina

Indicação	Infecção localizada de pele ou tecidos moles por estafilococo sensível — opção IM, <40 kg
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 500 mg; adicionar 2,7 mL de água para injetáveis → cerca de 500 mg/3 mL = 166,7 mg/mL
Dose	12,5 mg/kg/dose = 50 mg/kg/dia
Máximo	máximo 500 mg (3 mL) por dose nesta linha
Intervalo	6/6 h
Preparo/administração	Adicionar 2,7 mL de água para injetáveis, agitar até solução límpida e aplicar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função hepática/renal e hemograma em curso prolongado
Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Infecção grave, disseminada, SNC, endocardite ou osteomielite exige avaliação para esquema EV.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; linha IM restrita a infecção leve/moderada selecionada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

415. Oxacilina

Indicação	Infeção localizada de pele ou tecidos moles por estafilococo sensível — opção IM, ≥40 kg
Via	IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 500 mg; adicionar 2,7 mL de água para injetáveis → cerca de 500 mg/3 mL = 166,7 mg/mL
Dose	250–500 mg/dose
Máximo	máximo 500 mg (3 mL) por dose nesta linha
Intervalo	4/4–6/6 h conforme gravidade
Preparo/administração	Adicionar 2,7 mL de água para injetáveis, agitar até solução límpida e aspirar 1,5–3 mL.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função hepática/renal e hemograma em curso prolongado
Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Infeção grave, disseminada, SNC, endocardite ou osteomielite exige avaliação para esquema EV.
Situação	Apresentação brasileira IM/EV; linha IM restrita a infeção leve/moderada selecionada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

416. Oxacilina

Indicação	Meningite por MSSA
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola 1 g; padrão operacional 100 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose
Máximo	2 g/dose; 12 g/dia
Intervalo	a cada 4 h
Preparo/administração	Reconstituir para 100 mg/mL; aspirar a dose e realizar diluição 1:5 para concentração final de 20 mg/mL, conforme protocolo/compatibilidade.
Monitorização	LCR/culturas, função hepática
Cautelas	Infectologia; ajustar conforme sensibilidade
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

417. Oxcarbazepina

Indicação	Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica
Situação	Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

418. Oxiconazol

Indicação	Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente
Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Situação	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

419. Oxitetraciclina

Indicação	Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

420. Oxitetraciclina

Indicação	Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

421. Pantoprazol

Indicação	Hemorragia digestiva alta — terapia acidossupressora inicial
Via	EV
Apresentação	Frasco-ampola 40 mg; 4 mg/mL reconstituído; 0,8 mg/mL final
Dose	1 mg/kg, dose inicial
Máximo	80 mg/dose
Intervalo	dose única inicial; sequência por gastro/protocolo
Preparo/administração	Reconstituir 40 mg com 10 mL de SF 0,9% = 4 mg/mL. Para doses pediátricas/infusão, diluir a 0,8 mg/mL.
Monitorização	Hemodinâmica, Hb, endoscopia
Cautelas	Estabilização e controle da fonte são prioritários; acionar gastro/cirurgia
Situação	Off-label pediátrico
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

422. Paracetamol (acetaminofeno)

Indicação	Dor aguda
Via	VO
Apresentação	Solução 100 mg/mL
Dose	10–15 mg/kg/dose
Máximo	75 mg/kg/dia após termo; usar 60 mg/kg/dia como limite conservador institucional
Intervalo	a cada 4–6 h
Preparo/administração	Sem diluição; seringa oral
Monitorização	Dose total de todas as associações
Cautelas	Reduzir em hepatopatia/desnutrição; não exceder máximo do produto
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

423. Paracetamol (acetaminofeno)

Indicação	Febre com desconforto
Via	VO
Apresentação	Solução 100 mg/mL
Dose	10–15 mg/kg/dose
Máximo	75 mg/kg/dia após termo; usar 60 mg/kg/dia como limite conservador institucional
Intervalo	a cada 4–6 h
Preparo/administração	Sem diluição; seringa oral
Monitorização	Dose total de todas as associações
Cautelas	Reduzir em hepatopatia/desnutrição; não exceder máximo do produto
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

424. Penicilamina

Indicação	Doença inflamatória/metabólica específica — uso especializado
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Janela terapêutica/interações relevantes; monitorar hemograma, função renal/hepática conforme fármaco
Situação	Dose e titulação dependem da doença e idade; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

425. Penicilina (benzatina, G, V)

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar sal/formulação conforme síndrome
Via	VO, IM ou EV conforme sal
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, sal, concentração e via; penicilina benzatina nunca EV
Situação	Não intercambiar benzatina, procaína, cristalina ou penicilina V; linhas específicas originais foram preservadas
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

426. Penicilina G benzatina

Indicação	Faringoamigdalite estreptocócica
Via	IM profunda
Apresentação	Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI/4 mL ou 1.200.000 UI/4 mL
Dose	<27 kg: 600.000 UI; ≥27 kg: 1.200.000 UI
Máximo	1.200.000 UI
Intervalo	dose única
Preparo/administração	IM profunda exclusivamente. Usar o frasco correspondente ao peso: <27 kg, 600.000 UI/4 mL; ≥27 kg, 1.200.000 UI/4 mL. A reconstituição varia por fabricante.
Monitorização	Anafilaxia, dor local
Cautelas	Não intercambiar com procaína ou cristalina
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

427. Penicilina G benzatina

Indicação	Sífilis adquirida — esquema selecionado
Via	IM profunda
Apresentação	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI/4 mL = 300.000 UI/mL
Dose	50.000 UI/kg/dose
Máximo	2.400.000 UI/dose
Intervalo	dose única ou semanal ×3 conforme estágio
Preparo/administração	Usar apresentação final 1.200.000 UI/4 mL; IM profunda, nunca EV. Para 2.400.000 UI, dividir 8 mL em dois sítios conforme protocolo.
Monitorização	Sorologia e seguimento
Cautelas	Não usar combinações benzatina/procaína; excluir neurosífilis
Situação	Uso pediátrico estabelecido; esquema depende do estágio
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

428. Penicilina G benzatina

Indicação	Sífilis congênita — esquema selecionado
Via	IM profunda
Apresentação	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI/4 mL = 300.000 UI/mL
Dose	50.000 UI/kg/dose
Máximo	2.400.000 UI/dose
Intervalo	dose única ou semanal ×3 conforme estágio
Preparo/administração	Usar apresentação final 1.200.000 UI/4 mL; IM profunda, nunca EV. Para 2.400.000 UI, dividir 8 mL em dois sítios conforme protocolo.
Monitorização	Sorologia e seguimento
Cautelas	Não usar combinações benzatina/procaína; excluir neurosífilis
Situação	Uso pediátrico estabelecido; esquema depende do estágio
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

429. Penicilina G cristalina

Indicação	Endocardite por agente sensível
Via	EV
Apresentação	Frasco 5.000.000 UI; 1.000.000 UI/mL reconstituído
Dose	400.000 UI/kg/dia divididas a cada 4 h
Máximo	4 milhões UI/dose
Intervalo	a cada 4 h
Preparo/administração	Reconstituir para 1.000.000 UI/mL conforme bula/protocolo; depois diluir 1:10 para solução de trabalho 100.000 UI/mL.
Monitorização	Culturas, LCR, eletrólitos, função renal
Cautelas	Ajustar em IR; infectologia
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

430. Penicilina G cristalina

Indicação	Infecção grave sem meningite
Via	EV
Apresentação	Frasco 5.000.000 UI; 1.000.000 UI/mL reconstituído
Dose	200.000 UI/kg/dia divididas a cada 4 h
Máximo	4 milhões UI/dose
Intervalo	a cada 4 h
Preparo/administração	Reconstituir 5.000.000 UI com 3,2 mL do diluente indicado para volume final aproximado de 5 mL = 1.000.000 UI/mL; depois diluir 1:10 para 100.000 UI/mL.
Monitorização	Culturas, função renal, Na/K conforme sal
Cautelas	Ajustar em insuficiência renal
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

431. Penicilina G cristalina

Indicação	Meningite por agente sensível
Via	EV
Apresentação	Frasco 5.000.000 UI; 1.000.000 UI/mL reconstituído
Dose	400.000 UI/kg/dia divididas a cada 4 h
Máximo	4 milhões UI/dose
Intervalo	a cada 4 h
Preparo/administração	Reconstituir para 1.000.000 UI/mL conforme bula/protocolo; depois diluir 1:10 para solução de trabalho 100.000 UI/mL.
Monitorização	Culturas, LCR, eletrólitos, função renal
Cautelas	Ajustar em IR; infectologia
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

432. Penicilina G cristalina

Indicação	Sífilis congênita
Via	EV
Apresentação	Frasco 5.000.000 UI; 1.000.000 UI/mL reconstituído
Dose	50.000 UI/kg/dose
Máximo	—
Intervalo	RN: a cada 12 h nos 7 primeiros dias e 8 h depois; total 10 dias
Preparo/administração	Reconstituir para 1.000.000 UI/mL conforme bula/protocolo; diluição de trabalho 1:10 = 100.000 UI/mL.
Monitorização	Clínica, LCR, sorologia
Cautelas	Intervalo neonatal é idade-dependente
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

433. Penicilina G procaína

Indicação	Sífilis congênita — alternativa específica
Via	IM
Apresentação	Penicilina G procaína 600.000 UI/mL, suspensão IM
Dose	50.000 UI/kg/dose
Máximo	2.400.000 UI/dose
Intervalo	a cada 24 h por 10 dias
Preparo/administração	Usar somente a apresentação específica 600.000 UI/mL, IM profunda; nunca EV. Não intercambiar com benzatina ou cristalina.
Monitorização	Sorologia, clínica
Cautelas	Não intercambiar com benzatina/cristalina; confirmar disponibilidade local
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

434. Permetrina

Indicação	Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária
Via	VO ou tópica conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Situação	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

435. Petidina (Meperidina)

Indicação	Dor moderada/intensa — opção opioide selecionada por protocolo e idade
Via	VO, EV, IM ou transmucosa conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Monitorar ventilação/sedação; codeína e tramadol têm restrições importantes em menores de 12 anos e após adenoamigdalectomia
Situação	Uso restrito; resposta condicionada às contraindicações etárias e à variabilidade metabólica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

436. Picossulfato sódico

Indicação	Constipação funcional — desimpactação
Via	VO ou retal conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias
Situação	Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

437. Picossulfato sódico

Indicação	Constipação funcional — manutenção
Via	VO ou retal conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias
Situação	Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

438. Pimetixeno

Indicação	Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Situação	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

439. Pimetixeno

Indicação	Urticária — tratamento sintomático conforme idade
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Situação	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

440. Pipazetato

Indicação	Tosse seca intensa — uso excepcional após excluir causa tratável
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não usar em lactentes; revisar sedação, interação serotoninérgica e contraindicações específicas
Situação	Antitussígeno não rotineiro; resposta depende das restrições etárias e do benefício esperado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

441. Pirantel (Pamoato)

Indicação	Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária
Via	VO ou tópica conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Situação	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

442. Pirimetamina

Indicação	Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária
Via	VO ou tópica conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Situação	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

443. Pirvínio (Pamoato)

Indicação	Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária
Via	VO ou tópica conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Situação	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

444. Polimixina B

Indicação	Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

445. Polimixina B

Indicação	Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

446. Prednisolona

Indicação	Exacerbação de asma moderada/grave
Via	VO
Apresentação	Solução oral 3 mg/mL
Dose	1–2 mg/kg/dia
Máximo	máximo 40–50 mg/dia conforme diretriz/protocolo
Intervalo	1 vez/dia por curso curto conforme gravidade
Preparo/administração	Medir com seringa oral; confirmar concentração 3 mg/mL
Monitorização	Resposta respiratória, glicemia/PA quando pertinente
Cautelas	Não usar rotineiramente em bronquiolite ou IVAS viral sem indicação
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

447. Prednisona

Indicação	Exacerbação de asma moderada/grave — alternativa à prednisolona
Via	VO
Apresentação	Comprimidos 5 ou 20 mg; cálculo exibido em mg, não mL
Dose	1–2 mg/kg/dia
Máximo	máximo 40–50 mg/dia conforme protocolo
Intervalo	1 vez/dia por curso curto
Preparo/administração	Selecionar combinação de comprimidos compatível; não converter em mL sem suspensão definida
Monitorização	Resposta respiratória e eventos adversos
Cautelas	Linha calcula mg totais; confirmar formulação e capacidade de deglutição
Situação	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

448. Prometazina

Indicação	Náusea/vômito — uso excepcional em ≥ 2 anos
Via	IM/VO
Apresentação	25 mg/mL
Dose	0,25–0,5 mg/kg/dose
Máximo	25 mg/dose
Intervalo	a cada 6–8 h
Preparo/administração	Evitar EV pelo risco de lesão tecidual grave
Monitorização	Sedação e FR
Cautelas	Preferir antieméticos com melhor perfil; contraindicada <2 anos
Situação	Uso pediátrico restrito
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

449. Prometazina

Indicação	Reação alérgica/prurido — alternativa em ≥ 2 anos
Via	IM/VO
Apresentação	25 mg/mL
Dose	0,25 mg/kg/dose
Máximo	25 mg/dose
Intervalo	a cada 4–6 h se necessário
Preparo/administração	Preferir VO; se injetável, seguir bula e protocolo de segurança
Monitorização	Sedação, FR, efeitos anticolinérgicos
Cautelas	Contraindicada <2 anos; risco de depressão respiratória; não substitui adrenalina na anafilaxia
Situação	Uso pediátrico restrito
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

450. Propranolol

Indicação	Sintomas adrenérgicos em tireotoxicose
Via	VO
Apresentação	Solução oral 20 mg/5 mL = 4 mg/mL
Dose	2 mg/kg/dia divididos
Máximo	individualizar com especialista
Intervalo	a cada 6–12 h
Preparo/administração	Usar solução oral comercial 4 mg/mL; medir com seringa oral. Não substituir por Hemangeol sem recalcular a concentração.
Monitorização	FC, PA, glicemia
Cautelas	Evitar em asma/IC; tratar causa
Situação	Off-label pediátrico
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: sim

451. Propranolol

Indicação	Taquiarritmia supraventricular — manutenção
Via	VO
Apresentação	Solução oral 20 mg/5 mL = 4 mg/mL
Dose	1–5 mg/kg/dia divididos
Máximo	5 mg/kg/dia
Intervalo	a cada 6–8 h
Preparo/administração	Usar solução oral comercial 4 mg/mL; medir com seringa oral e titular com FC/PA/glicemia.
Monitorização	FC, PA, glicemia em lactentes
Cautelas	Evitar em asma, choque, BAV; não é tratamento inicial da TSV instável
Situação	Off-label pediátrico conforme indicação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: sim

452. Ranitidina

Indicação	Doença ácido-péptica — uso selecionado
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar interações e função renal; não usar ranitidina disponível de origem não autorizada
Situação	Ranitidina permanece suspensa/retirada por risco de NDMA; não gerar dose
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

453. Ranitidina

Indicação	Refluxo gastroesofágico — uso selecionado
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar interações e função renal; não usar ranitidina disponível de origem não autorizada
Situação	Ranitidina permanece suspensa/retirada por risco de NDMA; não gerar dose
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

454. Rifampicina

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

455. Roxitromicina

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

456. Saccharomyces boulardii

Indicação	Diarreia aguda — adjuvante cepa-específico, quando indicado
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Evitar em imunossupressão grave, paciente crítico ou com cateter venoso central pelo risco de fungemia
Situação	Benefício depende de cepa/dose; não substitui reidratação oral
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

457. Salbutamol — inalador

Indicação	Crise asmática leve/moderada
Via	Inalatória com espaçador
Apresentação	Inalador dosimetrado 100 mcg/jato
Dose	4–10 jatos por dose conforme gravidade/idade
Máximo	10 jatos por ciclo inicial em muitos protocolos
Intervalo	a cada 20 min na primeira hora; reavaliar
Preparo/administração	Usar espaçador; a unidade operacional é jato, não mL.
Monitorização	FC, tremor, SpO ₂ , resposta
Cautelas	SABA não deve ser único tratamento crônico; associar corticoide conforme crise
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

458. Salbutamol — inalador

Indicação	Resgate de broncoespasmo
Via	Inalatória
Apresentação	Inalador dosimetrado 100 mcg/jato
Dose	1–2 jatos
Máximo	avaliar controle se uso frequente
Intervalo	a cada 4 h se necessário por curto período
Preparo/administração	Usar espaçador; a unidade operacional é jato, não mL.
Monitorização	Sintomas e uso de resgate
Cautelas	Uso repetido indica controle inadequado
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

459. Salbutamol — nebulização

Indicação	Crise asmática moderada/grave
Via	Nebulização
Apresentação	5 mg/mL (0,5%)
Dose	0,15 mg/kg/dose; mínimo 2,5 mg
Máximo	5 mg/dose
Intervalo	a cada 20 min por 3 doses
Preparo/administração	Completar com SF 0,9% até volume do nebulizador
Monitorização	FC, tremor, K, lactato em doses repetidas
Cautelas	Associar ipratrópio nas crises graves iniciais
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

460. Salbutamol — nebulização

Indicação	Estado de mal asmático — nebulização contínua
Via	Nebulização contínua
Apresentação	5 mg/mL
Dose	0,3–0,5 mg/kg/h
Máximo	10–20 mg/h conforme peso/protocolo
Intervalo	contínuo, reavaliar frequentemente
Preparo/administração	Preparar no sistema de nebulização contínua conforme protocolo
Monitorização	ECG, K, lactato, glicemia, resposta
Cautelas	UTI/sala vermelha; risco de taquiarritmia e hipocalemia
Situação	Off-label por regime contínuo
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

461. Salmeterol

Indicação	Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade
Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Situação	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

462. Salmeterol

Indicação	Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade
Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Situação	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

463. Secnidazol

Indicação	Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária
Via	VO ou tópica conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Situação	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

464. Sertaconazol

Indicação	Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente
Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Situação	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

465. Simeticona

Indicação	Distensão/gases — alívio sintomático quando indicado
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Benefício variável; não mascara sinais de abdome agudo
Situação	Dose fixa por faixa etária e concentração do produto; não converter sem selecionar apresentação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

466. Sinvastatina

Indicação	Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg
Situação	Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

467. Sobrerol

Indicação	Secreção respiratória espessa — uso mucolítico apenas quando individualmente indicado
Via	VO ou inalatória conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Pode aumentar volume de secreções/broncoespasmo; contraindicações e idade mínima variam por produto
Situação	Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; resposta depende da idade e apresentação
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

468. Solução de reidratação oral (SRO)

Indicação	Alguma desidratação — Plano B
Via	VO/SNG
Apresentação	SRO baixa osmolaridade pronta ou sachê corretamente diluído
Dose	75 mL/kg em 4 h
Máximo	guiar por resposta e perdas
Intervalo	fracionado continuamente
Preparo/administração	Pequenos volumes frequentes; manter aleitamento
Monitorização	Perfusão, diurese, vômitos, peso
Cautelas	Desnutrição grave e choque exigem protocolo específico
Situação	Diretriz OMS
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

469. Solução de reidratação oral (SRO)

Indicação	Reposição de perdas contínuas
Via	VO
Apresentação	SRO baixa osmolaridade
Dose	<2 anos: 50–100 mL; 2–10 anos: 100–200 mL após cada evacuação; alternativa 10 mL/kg
Máximo	conforme sede/perdas
Intervalo	após cada evacuação/vômito
Preparo/administração	Oferecer com copo/colher/seringa
Monitorização	Hidratação e aceitação
Cautelas	Não diluir incorretamente o sachê
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

470. Somatropina (Hormônio do crescimento)

Indicação	Terapia endócrina de reposição — acompanhamento especializado
Via	VO ou SC conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não calcular superfície corporal sem altura; monitorar crescimento e exames específicos
Situação	Dose individualizada por idade, diagnóstico, alvo laboratorial e, às vezes, superfície corporal
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

471. Soro glicosado 10%

Indicação	Hipoglicemia sintomática
Via	EV/IO
Apresentação	100 mg/mL
Dose	<6 meses: 2,5–5 mL/kg; ≥6 meses: 5 mL/kg
Máximo	25 g de glicose/dose
Intervalo	bolus em 2–5 min; reavaliar glicemia em 5–10 min
Preparo/administração	Solução pronta; acesso seguro
Monitorização	Glicemia seriada, extravasamento
Cautelas	Tratar causa e iniciar GIR de manutenção se necessário
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

472. Soro glicosado 10%

Indicação	Infusão para aporte de glicose
Via	EV em BIC
Apresentação	SG 10% = 100 mg/mL de glicose
Dose	GIR inicial de referência 4–8 mg/kg/min; individualizar por idade, glicemia e contexto
Máximo	titular à glicemia
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	Usar SG 10% pronta ou preparo validado. Fórmula: mL/h = GIR (mg/kg/min) × peso × 60 ÷ 100 mg/mL.
Monitorização	Glicemia, Na, balanço
Cautelas	RN/lactentes requerem protocolo específico; não confundir com manutenção isotônica
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

473. Soro glicosado 5%

Indicação	Componente/diluyente de solução de manutenção
Via	EV
Apresentação	Solução isotônica de manutenção com dextrose/K quando indicados; SG 5% isolado não é padrão
Dose	Integrar a solução isotônica; ver aba Soroterapia 100%
Máximo	individualizar
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	A coluna H calcula a manutenção horária pela regra 4–2–1. O valor é da solução final prescrita, não de SG 5% isolado. Ajustar para doença renal/cardíaca, SIADH, neonatos e perdas.
Monitorização	Na, glicemia, balanço
Cautelas	Não usar isolado para manutenção em 28 d–18 a sem indicação específica
Situação	Diretriz: não usar isoladamente como manutenção rotineira
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

474. Soro glicosado 50%

Indicação	Preparo de soluções menos concentradas
Via	EV somente após diluição pediátrica
Apresentação	SG 50% = 500 mg/mL; usar somente para preparo/diluição validada
Dose	Não administrar em bolus direto rotineiro em criança
Máximo	—
Intervalo	conforme preparo
Preparo/administração	Para 100 mL de SG 10%: retirar 20 mL de SG 50% e completar com 80 mL de diluente compatível. Homogeneizar e rotular; não administrar SG 50% em bolus pediátrico.
Monitorização	Conferir glicose final e osmolaridade
Cautelas	Risco elevado de flebite/necrose; farmácia/protocolo
Situação	Uso como concentrado
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

475. Soro polieletrólítico balanceado

Indicação	Choque/hipoperfusão — bolus
Via	EV/IO
Apresentação	Ringer lactato/Plasma-Lyte ou equivalente
Dose	10–20 mL/kg
Máximo	reavaliar antes de repetir
Intervalo	em 5–20 min
Preparo/administração	Solução pronta; aquecer se grande volume
Monitorização	Perfusão, PA, sinais de sobrecarga
Cautelas	Ringer contém cálcio: não coadministrar ceftriaxona em RN; não é contraindicação automática na hipercalemia
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

476. Soro polieletrólítico balanceado

Indicação	Reposição de desidratação/deficit
Via	EV
Apresentação	Cristaloide balanceado; volume depende da avaliação clínica
Dose	deficit estimado 50–100 mL/kg para desidratação de 5–10%; somar manutenção e perdas separadamente
Máximo	evitar automatizar sem clínica/laboratório
Intervalo	contínuo
Preparo/administração	Estimativa: déficit (mL) = peso (kg) × % de desidratação × 10. A faixa H usa 5–10%; reavaliar e não infundir automaticamente como bolus único.
Monitorização	Na, K, glicemia, balanço
Cautelas	DKA, desnutrição grave, queimado e RN têm protocolos próprios
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

477. Sucralfato

Indicação	Doença ácido-péptica — uso selecionado
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar interações e função renal; não usar ranitidina disponível de origem não autorizada
Situação	Ranitidina permanece suspensa/retirada por risco de NDMA; não gerar dose
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

478. Sucralfato

Indicação	Refluxo gastroesofágico — uso selecionado
Via	VO ou EV conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar interações e função renal; não usar ranitidina disponível de origem não autorizada
Situação	Ranitidina permanece suspensa/retirada por risco de NDMA; não gerar dose
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

479. Sulfadiazina de prata

Indicação	Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

480. Sulfadiazina de prata

Indicação	Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

481. Sulfametoxazol + Trimetoprima

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

482. Sulfato de magnésio

Indicação	Asma grave refratária ao tratamento inicial
Via	EV
Apresentação	10% = 100 mg/mL
Dose	25–50 mg/kg
Máximo	2 g
Intervalo	dose única em 20–30 min
Preparo/administração	Diluir em 50–100 mL conforme restrição hídrica
Monitorização	PA, FR, reflexos, diurese
Cautelas	Cautela em IR e bloqueio neuromuscular
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

483. Sulfato de magnésio

Indicação	Eclâmpsia — adolescente/adulta
Via	EV em BIC
Apresentação	Sulfato de magnésio 10% ou 50%; ataque obstétrico 4–6 g
Dose	Seguir protocolo obstétrico
Máximo	4–6 g de ataque; 1–2 g/h
Intervalo	contínuo após ataque
Preparo/administração	Aspirar 40–60 mL da solução 10% OU 8–12 mL da solução 50%; diluir e administrar conforme protocolo obstétrico. Linha destinada a adolescente/adulta.
Monitorização	FR, reflexos, diurese, Mg
Cautelas	Gluconato de cálcio disponível como antídoto
Situação	Diretriz obstétrica; não é dose pediátrica por peso
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

484. Sulfato de magnésio

Indicação	Torsades de pointes/hipomagnesemia com arritmia
Via	EV/IO
Apresentação	100 mg/mL
Dose	25–50 mg/kg
Máximo	2 g
Intervalo	em 10–20 min; mais rápido se PCR
Preparo/administração	Diluir conforme urgência e protocolo
Monitorização	ECG, PA, reflexos
Cautelas	Ajustar em IR
Situação	Diretriz pediátrica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

485. Surfactante pulmonar (porcino/bovino)

Indicação	Síndrome do desconforto respiratório neonatal — resgate
Via	Intratraqueal
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Administrar por equipe neonatal treinada; ajustar ventilação e monitorar bradicardia/dessaturação
Situação	Dose depende do produto (poractanto/beractanto); selecionar marca e concentração
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

486. Suxametônio (succinilcolina)

Indicação	Sequência rápida de intubação — bloqueio neuromuscular
Via	EV
Apresentação	20 mg/mL após reconstituição/preparo validado
Dose	<2 anos: 2 mg/kg; ≥2 anos: 1–1,5 mg/kg
Máximo	máximo conforme protocolo e peso
Intervalo	dose única; início rápido e curta duração
Preparo/administração	A linha exibe a faixa 1–2 mg/kg; selecionar a dose pela idade antes de programar
Monitorização	ECG, SpO ₂ , ETCO ₂ , ventilação e temperatura
Cautelas	Evitar em hipercalemia/risco, miopatia, queimadura/denervação tardia, hipertermia maligna e após imobilização prolongada
Situação	Uso pediátrico restrito; avaliar contraindicações antes da administração
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

487. Teicoplanina

Indicação	Diarreia ou colite por Clostridioides difficile associada a antibiótico — adolescente >16 a 18 anos
Via	VO após reconstituição
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	200 mg/dose
Máximo	não extrapolar esta linha para ≤16 anos
Intervalo	12/12 h por 7–14 dias
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente e administrar 1,6 mL da solução de 125 mg/mL por via oral.
Monitorização	Resposta clínica, frequência das evacuações e recorrência
Cautelas	Uso oral específico desta indicação; não usar esta linha para infecção sistêmica.
Situação	Indicação e esquema de adulto na bula profissional brasileira; confirmar infectologia e alternativa de primeira linha
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

488. Teicoplanina

Indicação	Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, ataque EV
Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose
Máximo	em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização de níveis
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

489. Teicoplanina

Indicação	Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, manutenção EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose
Máximo	endocardite por S. aureus ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

490. Teicoplanina

Indicação	Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, ataque EV
Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose
Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

491. Teicoplanina

Indicação	Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, manutenção EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose
Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; endocardite por <i>S. aureus</i> ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

492. Teicoplanina

Indicação	Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, ataque EV
Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose
Máximo	usar o número de frascos necessário; confirmar protocolo e níveis séricos em infecção grave
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; criança acima de 2 meses até 16 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

493. Teicoplanina

Indicação	Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção grave/neutropenia EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose
Máximo	monitorar níveis séricos e ajustar manutenção por função renal após o 4º dia
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção grave por Gram-positivo ou criança neutropênica, acima de 2 meses até 16 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

494. Teicoplanina

Indicação	Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção não grave EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose
Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção por Gram-positivo em geral, acima de 2 meses até 16 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

495. Teicoplanina

Indicação	Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, ataque EV
Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	16 mg/kg, dose única de ataque no primeiro dia
Máximo	confirmar idade gestacional, função renal, indicação e protocolo neonatal
Intervalo	dose inicial única no primeiro dia
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

496. Teicoplanina

Indicação	Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, manutenção EV
Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	8 mg/kg/dose
Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

497. Teicoplanina

Indicação	Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, ataque EV
Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose
Máximo	em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização de níveis
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

498. Teicoplanina

Indicação	Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, manutenção EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose
Máximo	endocardite por <i>S. aureus</i> ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

499. Teicoplanina

Indicação	Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, ataque EV
Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose
Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

500. Teicoplanina

Indicação	Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, manutenção EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose
Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; endocardite por <i>S. aureus</i> ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

501. Teicoplanina

Indicação	Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, ataque EV
Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose
Máximo	usar o número de frascos necessário; confirmar protocolo e níveis séricos em infecção grave
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; criança acima de 2 meses até 16 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

502. Teicoplanina

Indicação	Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção grave/neutropenia EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose
Máximo	monitorar níveis séricos e ajustar manutenção por função renal após o 4º dia
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção grave por Gram-positivo ou criança neutropênica, acima de 2 meses até 16 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

503. Teicoplanina

Indicação	Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção não grave EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose
Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção por Gram-positivo em geral, acima de 2 meses até 16 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

504. Teicoplanina

Indicação	Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, ataque EV
Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	16 mg/kg, dose única de ataque no primeiro dia
Máximo	confirmar idade gestacional, função renal, indicação e protocolo neonatal
Intervalo	dose inicial única no primeiro dia
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

505. Teicoplanina

Indicação	Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, manutenção EV
Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	8 mg/kg/dose
Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

506. Teicoplanina

Indicação	Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, ataque EV
Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose
Máximo	em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização de níveis
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

507. Teicoplanina

Indicação	Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, manutenção EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose
Máximo	endocardite por <i>S. aureus</i> ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

508. Teicoplanina

Indicação	Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, ataque EV
Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose
Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

509. Teicoplanina

Indicação	Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, manutenção EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose
Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; endocardite por <i>S. aureus</i> ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

510. Teicoplanina

Indicação	Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, ataque EV
Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose
Máximo	usar o número de frascos necessário; confirmar protocolo e níveis séricos em infecção grave
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; criança acima de 2 meses até 16 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

511. Teicoplanina

Indicação	Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção grave/neutropenia EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose
Máximo	monitorar níveis séricos e ajustar manutenção por função renal após o 4º dia
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção grave por Gram-positivo ou criança neutropênica, acima de 2 meses até 16 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

512. Teicoplanina

Indicação	Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção não grave EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose
Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção por Gram-positivo em geral, acima de 2 meses até 16 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

513. Teicoplanina

Indicação	Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, ataque EV
Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	16 mg/kg, dose única de ataque no primeiro dia
Máximo	confirmar idade gestacional, função renal, indicação e protocolo neonatal
Intervalo	dose inicial única no primeiro dia
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

514. Teicoplanina

Indicação	Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, manutenção EV
Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	8 mg/kg/dose
Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

515. Teicoplanina

Indicação	Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, ataque EV
Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose
Máximo	em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização de níveis
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

516. Teicoplanina

Indicação	Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, manutenção EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose
Máximo	endocardite por <i>S. aureus</i> ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

517. Teicoplanina

Indicação	Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, ataque EV
Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose
Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

518. Teicoplanina

Indicação	Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, manutenção EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose
Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; endocardite por <i>S. aureus</i> ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

519. Teicoplanina

Indicação	Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, ataque EV
Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose
Máximo	usar o número de frascos necessário; confirmar protocolo e níveis séricos em infecção grave
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; criança acima de 2 meses até 16 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

520. Teicoplanina

Indicação	Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção grave/neutropenia EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose
Máximo	monitorar níveis séricos e ajustar manutenção por função renal após o 4º dia
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção grave por Gram-positivo ou criança neutropênica, acima de 2 meses até 16 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

521. Teicoplanina

Indicação	Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção não grave EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose
Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção por Gram-positivo em geral, acima de 2 meses até 16 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

522. Teicoplanina

Indicação	Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, ataque EV
Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	16 mg/kg, dose única de ataque no primeiro dia
Máximo	confirmar idade gestacional, função renal, indicação e protocolo neonatal
Intervalo	dose inicial única no primeiro dia
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

523. Teicoplanina

Indicação	Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, manutenção EV
Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	8 mg/kg/dose
Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

524. Teicoplanina

Indicação	Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, ataque EV
Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose
Máximo	em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização de níveis
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

525. Teicoplanina

Indicação	Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, manutenção EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose
Máximo	endocardite por <i>S. aureus</i> ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

526. Teicoplanina

Indicação	Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, ataque EV
Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose
Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

527. Teicoplanina

Indicação	Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, manutenção EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose
Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; endocardite por <i>S. aureus</i> ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

528. Teicoplanina

Indicação	Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, ataque EV
Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose
Máximo	usar o número de frascos necessário; confirmar protocolo e níveis séricos em infecção grave
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; criança acima de 2 meses até 16 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

529. Teicoplanina

Indicação	Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção grave/neutropenia EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose
Máximo	monitorar níveis séricos e ajustar manutenção por função renal após o 4º dia
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção grave por Gram-positivo ou criança neutropênica, acima de 2 meses até 16 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

530. Teicoplanina

Indicação	Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção não grave EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose
Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção por Gram-positivo em geral, acima de 2 meses até 16 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

531. Teicoplanina

Indicação	Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, ataque EV
Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	16 mg/kg, dose única de ataque no primeiro dia
Máximo	confirmar idade gestacional, função renal, indicação e protocolo neonatal
Intervalo	dose inicial única no primeiro dia
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

532. Teicoplanina

Indicação	Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, manutenção EV
Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	8 mg/kg/dose
Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

533. Teicoplanina

Indicação	Peritonite associada à diálise peritoneal ambulatorial contínua — adolescente >16 a 18 anos
Via	Ataque EV seguido de administração intraperitoneal na bolsa de diálise
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	Ataque de 400 mg EV; depois 20 mg/L por bolsa na 1ª semana, 20 mg/L em bolsas alternadas na 2ª e 20 mg/L na bolsa noturna na 3ª
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	conforme cada bolsa e a semana do tratamento
Preparo/administração	Preparação intraperitoneal exclusivamente pela equipe de diálise/farmácia, com técnica asséptica e protocolo institucional.
Monitorização	Efluente, culturas, resposta peritoneal, função renal residual e níveis quando indicados
Cautelas	Não converter automaticamente para mL sem conhecer o volume exato de cada bolsa e o protocolo nefrológico.
Situação	Bula profissional brasileira; regime por volume da bolsa, não pelo peso corporal
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

534. Teicoplanina

Indicação	Peritonite associada à diálise peritoneal ambulatorial contínua — criança/adolescente até 16 anos
Via	Via intraperitoneal sob protocolo de diálise
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	Definir concentração por litro e esquema com nefrologia pediátrica, infectologia e farmácia clínica
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	conforme cada bolsa e protocolo pediátrico institucional
Preparo/administração	Preparação intraperitoneal exclusivamente pela equipe de diálise/farmácia, com técnica asséptica.
Monitorização	Efluente, culturas, resposta peritoneal, função renal residual e níveis quando indicados
Cautelas	Não aplicar automaticamente o regime fixo de adulto a crianças.
Situação	A bula brasileira descreve o regime intraperitoneal sem estratificação pediátrica; cálculo não automatizado nesta faixa
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

535. Teicoplanina

Indicação	Profilaxia de endocardite por Gram-positivo em cirurgia dental — adolescente >16 a 18 anos e >85 kg
Via	EV na indução anestésica
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg, dose única
Máximo	dose única; confirmar protocolo perioperatório
Intervalo	dose única no momento da indução anestésica
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e administrar por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Indicação e esquema de adulto na bula profissional brasileira; confirmar cardiologia/infectologia
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

536. Teicoplanina

Indicação	Profilaxia de endocardite por Gram-positivo em cirurgia dental — adolescente >16 a 18 anos e ≤85 kg
Via	EV na indução anestésica
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg, dose única
Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg
Intervalo	dose única no momento da indução anestésica
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Indicação e esquema de adulto na bula profissional brasileira; confirmar cardiologia/infectologia
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

537. Teicoplanina

Indicação	Profilaxia de infecção por Gram-positivo em cirurgia ortopédica ou vascular — adolescente >16 a 18 anos e >85 kg
Via	EV na indução anestésica
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg, dose única
Máximo	dose única; confirmar protocolo perioperatório
Intervalo	dose única no momento da indução anestésica
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e administrar por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Indicação e esquema de adulto na bula profissional brasileira; confirmar protocolo cirúrgico
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

538. Teicoplanina

Indicação	Profilaxia de infecção por Gram-positivo em cirurgia ortopédica ou vascular — adolescente >16 a 18 anos e ≤85 kg
Via	EV na indução anestésica
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg, dose única
Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg
Intervalo	dose única no momento da indução anestésica
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Indicação e esquema de adulto na bula profissional brasileira; confirmar protocolo cirúrgico
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

539. Teicoplanina

Indicação	Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, ataque EV
Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose
Máximo	em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização de níveis
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

540. Teicoplanina

Indicação	Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, manutenção EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose
Máximo	endocardite por <i>S. aureus</i> ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

541. Teicoplanina

Indicação	Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, ataque EV
Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose
Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

542. Teicoplanina

Indicação	Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, manutenção EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose
Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; endocardite por <i>S. aureus</i> ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

543. Teicoplanina

Indicação	Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, ataque EV
Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose
Máximo	usar o número de frascos necessário; confirmar protocolo e níveis séricos em infecção grave
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; criança acima de 2 meses até 16 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

544. Teicoplanina

Indicação	Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção grave/neutropenia EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose
Máximo	monitorar níveis séricos e ajustar manutenção por função renal após o 4º dia
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção grave por Gram-positivo ou criança neutropênica, acima de 2 meses até 16 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

545. Teicoplanina

Indicação	Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção não grave EV/IM
Via	EV ou IM profunda
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose
Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção por Gram-positivo em geral, acima de 2 meses até 16 anos
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

546. Teicoplanina

Indicação	Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, ataque EV
Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	16 mg/kg, dose única de ataque no primeiro dia
Máximo	confirmar idade gestacional, função renal, indicação e protocolo neonatal
Intervalo	dose inicial única no primeiro dia
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

547. Teicoplanina

Indicação	Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, manutenção EV
Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido
Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	8 mg/kg/dose
Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque
Preparo/administração	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados
Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Situação	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

548. Teofilina

Indicação	Broncoespasmo — terapia adjuvante selecionada, não de primeira linha
Via	VO ou EV conforme fármaco/produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Janela terapêutica estreita para xantinas; revisar interações, arritmia, convulsão e níveis quando aplicável
Situação	Referência documental; benefício-risco e papel atual devem ser confirmados
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

549. Terbinafina

Indicação	Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente
Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Situação	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

550. Terbutalina

Indicação	Broncoespasmo agudo — alternativa beta-2 agonista conforme protocolo
Via	Inalatória ou EV conforme cenário
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Monitorar FC, K, glicemia e lactato em doses repetidas/infusão; preferir protocolo de asma
Situação	Selecionar formulação, via e faixa etária antes do cálculo
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

551. Tetraciclina

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

552. Tioconazol

Indicação	Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente
Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Situação	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

553. Tirotricina

Indicação	Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

554. Tirotricina

Indicação	Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

555. Tobramicina

Indicação	Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

556. Tobramicina

Indicação	Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto
Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Situação	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

557. Tolnaftato

Indicação	Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente
Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Situação	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

558. Topiramato

Indicação	Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica
Situação	Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

559. Tramadol

Indicação	Dor moderada/intensa — opção opioide selecionada por protocolo e idade
Via	VO, EV, IM ou transmucosa conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Monitorar ventilação/sedação; codeína e tramadol têm restrições importantes em menores de 12 anos e após adenoamigdalectomia
Situação	Uso restrito; resposta condicionada às contraindicações etárias e à variabilidade metabólica
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

560. Triancinolona

Indicação	Doença inflamatória/alérgica específica — corticoide sistêmico ou tópico
Via	VO, IM, tópica ou intra-articular conforme produto
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; avaliar duração, desmame e imunossupressão
Situação	Potência e equivalência variam; selecionar indicação e formulação antes de calcular
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

561. Trimetoprima + Sulfadiazina

Indicação	Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma
Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Situação	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

562. Urapidil

Indicação	Emergência hipertensiva
Via	EV
Apresentação	Ampola 50 mg/10 mL = 5 mg/mL, porém sem dose pediátrica validada
Dose	Sem dose pediátrica de consulta rápida validada para esta planilha
Máximo	usar somente protocolo especializado
Intervalo	bolus/infusão conforme centro
Preparo/administração	Não gerar volume a partir de dose adulta. Selecionar agente pediátrico/protocolo institucional.
Monitorização	PA contínua
Cautelas	Preferir labetalol/nicardipina/nitroprussiato conforme etiologia e protocolo
Situação	Off-label; dados pediátricos limitados
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: sim

563. Ureia

Indicação	Desbridamento enzimático de lesão selecionada
Via	Tópica
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Proteger pele íntegra; confirmar indicação e curativo/protocolo de feridas
Situação	Aplicação depende da concentração, área e tipo de lesão; não calcular por peso
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

564. Ureia

Indicação	Hidratação cutânea de lesão selecionada
Via	Tópica
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Proteger pele íntegra; confirmar indicação e curativo/protocolo de feridas
Situação	Aplicação depende da concentração, área e tipo de lesão; não calcular por peso
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

565. Valproato sódico (Ácido valproico)

Indicação	Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica
Situação	Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

566. Vancomicina

Indicação	Infecção grave por MRSA/Gram-positivo resistente
Via	EV
Apresentação	Frasco 500 mg ou 1 g; 50 mg/mL reconstituído; 5 mg/mL final
Dose	15 mg/kg/dose
Máximo	750–1000 mg/dose conforme serviço
Intervalo	a cada 6 h inicialmente; individualizar por AUC
Preparo/administração	Reconstituir 500 mg com 10 mL ou 1 g com 20 mL = 50 mg/mL. Diluir adicionalmente para 5 mg/mL; infundir por ≥60 min e mais lento conforme dose/reação.
Monitorização	AUC/MIC alvo 400–600, creatinina, reação infusional
Cautelas	Ajustar por função renal e TDM; não usar dose fixa sem monitorização
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

567. Vancomicina

Indicação	Meningite ou infecção do SNC por Gram-positivo resistente
Via	EV
Apresentação	Frasco 500 mg ou 1 g; 50 mg/mL reconstituído; 5 mg/mL final
Dose	15 mg/kg/dose
Máximo	monitorar AUC; 60 mg/kg/dia inicial frequente
Intervalo	a cada 6 h
Preparo/administração	Reconstituir 500 mg com 10 mL ou 1 g com 20 mL = 50 mg/mL. Diluir adicionalmente para 5 mg/mL; infundir por ≥60 min e mais lento conforme dose/reação.
Monitorização	AUC, culturas/LCR, função renal
Cautelas	Infectologia/farmácia clínica; ajustar à MIC e foco
Situação	Uso pediátrico estabelecido
Marcadores	Alta vigilância: sim · Off-label: não

568. Vigabatrina

Indicação	Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica
Via	VO
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica
Situação	Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

569. Vitamina A

Indicação	Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica
Via	VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI
Situação	Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

570. Vitamina B1 (Tiamina)

Indicação	Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica
Via	VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI
Situação	Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

571. Vitamina B12

Indicação	Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica
Via	VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI
Situação	Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

572. Vitamina B5 (Dexpantenol)

Indicação	Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica
Via	VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI
Situação	Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

573. Vitamina B6 (Piridoxina)

Indicação	Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica
Via	VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI
Situação	Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

574. Vitamina C

Indicação	Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica
Via	VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI
Situação	Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

575. Vitamina E

Indicação	Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica
Via	VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI
Situação	Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

576. Zafirlucaste

Indicação	Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade
Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Situação	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

577. Zafirlucaste

Indicação	Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade
Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco
Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas
Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto
Preparo/administração	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco
Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Situação	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate
Marcadores	Alta vigilância: não · Off-label: não

12. Matriz de apresentações prioritárias

Fármaco	Apresentações configuradas	Regra
Dipirona	500 mg/mL gotas; 100 e 50 mg/mL solução; supositório 300 mg	Dose clínica preservada; supositório somente em idade/peso compatíveis
Paracetamol	200; 140; 100; 32 mg/mL	Conversão por concentração; gotas apenas com equivalência do produto
Ibuprofeno	100; 50; 20 mg/mL	Somente ≥6 meses e peso compatível; evitar em desidratação/doença renal/dengue
Cetoprofeno	20 mg/mL gotas	Somente faixa etária compatível; curta duração
Ondansetrona	0,8 mg/mL; ODT 4 e 8 mg	Somente contexto compatível; dose única selecionada; avaliar QT, eletrólitos e interações
Mometasona nasal	50 mcg/jato	Condicional a indicação nasal; não é rotina na OMA

13. Arquitetura, validação e reconstrução

- Aplicação cliente em React/TypeScript, empacotada como Site Vnext/Cloudflare Worker.
- Arquivos essenciais: `app/page.tsx`, `app/globals.css`, `app/layout.tsx`, `app/medication-inventory.json`, `app/requested-diagnoses.ts`, `app/clinical-scores.ts` e manifesto de hospedagem.
- Validações: catálogo 238/238; inventário 265/265 medicamentos, 577/577 linhas e 391/391 indicações; build ESM e manifesto válidos.
- Checklist de reconstrução: restaurar identidade do Site; instalar dependências bloqueadas; validar inventários; executar lint, build, teste de HTML; testar seleção, apresentação, cópia e responsividade; publicar checkpoint e confirmar estado terminal.

14. Checklist final de auditoria

- ☐ Diagnóstico e gravidade confirmados
- ☐ Peso e idade atuais
- ☐ Alergias e medicamentos em uso verificados
- ☐ Função renal/hepática considerada
- ☐ Indicação individual presente
- ☐ Apresentação brasileira confirmada
- ☐ Dose e máximos conferidos
- ☐ Conversão e checagem reversa concluídas
- ☐ Intervalo e duração definidos
- ☐ Duplicidade terapêutica excluída
- ☐ Contraindicações e interações avaliadas
- ☐ Off-label identificado
- ☐ Via domiciliar versus hospitalar separada
- ☐ Linguagem simples revisada
- ☐ Alarmes e retorno incluídos
- ☐ Fonte e data da revisão registradas
- ☐ Todos os itens selecionados aparecem na prévia

15. Dossiê por princípio ativo

Uma ficha por princípio ativo consolida todas as apresentações, indicações, vias, limites e cautelas cadastradas. A ficha é inventário auditável: habilitação na receita depende do diagnóstico, idade, peso e validação vigente.

15.001 — Acebrofilina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Broncoespasmo — terapia adjuvante selecionada, não de primeira linha

Via: VO ou EV conforme fármaco/produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Janela terapêutica estreita para xantinas; revisar interações, arritmia, convulsão e níveis quando aplicável

Situação: Referência documental; benefício-risco e papel atual devem ser confirmados

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.002 — Acetilcisteína

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Intoxicação por paracetamol — antídoto

Via: EV ou VO

Apresentação: Apresentação EV/VO variável; confirmar concentração do produto

Dose: Regime de ataque e manutenção específico; usar nomograma/protocolo toxicológico

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Esquema contínuo por etapas; duração guiada por paracetamol, AST/ALT, INR e evolução

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Risco de reação anafilactoide EV; não atrasar quando indicação definida; consultar CIATox

Situação: Esquema depende de protocolo, tempo e via; selecionar o regime antes de calcular

Indicação 2: Secreção respiratória espessa — uso mucolítico apenas quando individualmente indicado

Via: VO ou inalatória conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Pode aumentar volume de secreções/broncoespasmo; contraindicações e idade mínima variam por produto

Situação: Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; resposta depende da idade e apresentação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.003 — Aciclovir

Linhas cadastradas: 4. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Encefalite por HSV — tratamento hospitalar

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola; concentração reconstituída varia por produto

Dose: Selecionar faixa neonatal versus criança/adolescente e protocolo de SNC

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Ajustar função renal; hidratação e infusão adequada reduzem risco de nefrotoxicidade

Situação: Dose varia por idade e pode usar mg/kg ou mg/m²; selecionar a faixa etária

Indicação 2: Infecção disseminada por HSV — tratamento hospitalar

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola; concentração reconstituída varia por produto

Dose: Selecionar faixa neonatal versus criança/adolescente e protocolo de SNC

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Ajustar função renal; hidratação e infusão adequada reduzem risco de nefrotoxicidade

Situação: Dose varia por idade e pode usar mg/kg ou mg/m²; selecionar a faixa etária

Indicação 3: Infecção por HSV — tratamento conforme idade, gravidade e imunidade

Via: VO ou EV conforme cenário

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Ajustar função renal; hidratação e monitorização renal na via EV

Situação: Dose e unidade podem ser mg/kg ou mg/m²; selecionar síndrome e faixa etária antes de calcular

Indicação 4: Varicela — tratamento conforme idade, gravidade e imunidade

Via: VO ou EV conforme cenário

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Ajustar função renal; hidratação e monitorização renal na via EV

Situação: Dose e unidade podem ser mg/kg ou mg/m²; selecionar síndrome e faixa etária antes de calcular

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.004 — Adenosina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Taquicardia supraventricular regular com pulso — 1ª dose

Via: EV/IO, push ultrarrápido seguido de flush

Apresentação: 3 mg/mL

Dose: 0,1 mg/kg

Máximo: máximo 6 mg

Intervalo: dose inicial; repetir com 0,2 mg/kg se necessário

Preparo/administração: Usar acesso o mais proximal possível; administrar em push imediato e flush

Monitorização: ECG contínuo, PA, perfusão; registrar ritmo antes/durante/depois

Cautelas: Alta vigilância; sincronizar equipe e flush; considerar QRS e diagnóstico diferencial

Situação: Diretriz PALS 2025

Indicação 2: Taquicardia supraventricular regular com pulso — 2ª dose

Via: EV/IO, push ultrarrápido seguido de flush

Apresentação: 3 mg/mL

Dose: 0,2 mg/kg

Máximo: máximo 12 mg

Intervalo: após falha da 1ª dose

Preparo/administração: Usar acesso o mais proximal possível; administrar em push imediato e flush

Monitorização: ECG contínuo, PA, perfusão; registrar ritmo antes/durante/depois

Cautelas: Alta vigilância; confirmar dose escalonada e diagnóstico de TSV regular

Situação: Diretriz PALS 2025

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.005 — Adrenalina (epinefrina)

Linhas cadastradas: 5. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Anafilaxia

Via: IM, coxa ântero-lateral

Apresentação: 1 mg/mL

Dose: 0,01 mg/kg

Máximo: 0,5 mg/dose; alguns protocolos limitam criança a 0,3 mg

Intervalo: repetir após 5 min se necessário

Preparo/administração: Pura; seringa de 1 mL

Monitorização: ABCDE, PA, FC, SpO₂; observar resposta

Cautelas: Sem contraindicação absoluta na anafilaxia; confirmar limite institucional 0,3 vs 0,5 mg

Situação: Diretriz pediátrica

Indicação 2: Anafilaxia refratária após 2 doses IM

Via: EV em BIC

Apresentação: Padrões de infusão: 10 ou 20 mcg/mL

Dose: iniciar 0,05 mcg/kg/min; titular em ambiente monitorizado

Máximo: confirmar protocolo institucional

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: 10 mcg/mL: 0,5 mg (0,5 mL de 1 mg/mL) e completar para 50 mL. 20 mcg/mL: 1 mg e completar para 50 mL. Bomba com biblioteca e dupla checagem.

Monitorização: PA contínua se possível, ECG, perfusão

Cautelas: Manter adrenalina IM enquanto prepara infusão; considerar UTI

Situação: Off-label: infusão em anafilaxia refratária

Indicação 3: Choque com disfunção miocárdica/baixo débito

Via: EV/IO em BIC

Apresentação: Padrões de infusão: 10 ou 20 mcg/mL

Dose: iniciar 0,05 mcg/kg/min; usual 0,05–0,3 mcg/kg/min

Máximo: máx. de referência 1 mcg/kg/min; titular ao efeito

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: 10 mcg/mL: 0,5 mg em volume final de 50 mL. 20 mcg/mL: 1 mg em volume final de 50 mL. Bomba/biblioteca; central preferível.

Monitorização: PA, perfusão, lactato, diurese, ECG, sítio periférico

Cautelas: Alta vigilância; dupla checagem de mcg versus mg

Situação: Diretriz pediátrica

Indicação 4: Crupe moderado/grave com estridor em repouso

Via: Nebulização

Apresentação: 1 mg/mL

Dose: 0,5 mL/kg = 0,5 mg/kg

Máximo: 5 mL = 5 mg

Intervalo: dose; repetir conforme resposta e suporte disponível

Preparo/administração: Nebulizar volume calculado; completar volume apenas se o nebulizador exigir

Monitorização: FC, SpO₂, estridor; observar ≥3 h após última dose

Cautelas: Associar dexametasona; preparar via aérea se resposta inadequada

Situação: Diretriz pediátrica; uso por nebulização

Indicação 5: PCR

Via: EV/IO

Apresentação: 1 mg/10 mL = 0,1 mg/mL

Dose: 0,01 mg/kg = 10 mcg/kg

Máximo: 1 mg/dose

Intervalo: a cada 3–5 min

Preparo/administração: Solução 0,1 mg/mL; flush após dose

Monitorização: ECG, ETCO₂, qualidade da RCP

Cautelas: Não usar solução 1 mg/mL por engano na via EV/IO

Situação: Diretriz pediátrica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.006 — Albendazol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via: VO ou tópica conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais

Situação: Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.007 — Alizaprida

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Náuseas/vômitos — uso selecionado após tratar a causa e avaliar risco de QT

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar QT, distonia/efeitos extrapiramidais, interações e distúrbios eletrolíticos

Situação: Não usar rotineiramente; dose/idade dependem do produto e da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.008 — Amantadina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Indicação neurológica/sedativa especializada

Via: VO ou via hospitalar conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar depressão do SNC, QT, efeitos extrapiramidais e necessidade de monitorização cardiorrespiratória

Situação: Uso restrito/off-label conforme cenário; selecionar protocolo especializado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.009 — Amicacina

Linhas cadastradas: 11. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Bacteremia ou sepse por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL

Dose: 5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h

Máximo: máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal

Intervalo: 8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg

Preparo/administração: Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular

Cautelas: Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira

Indicação 2: Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL

Dose: 5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h

Máximo: máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal

Intervalo: 8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg

Preparo/administração: Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular

Cautelas: Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira

Indicação 3: Infecção de queimadura por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL

Dose: 5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h

Máximo: máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal

Intervalo: 8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg

Preparo/administração: Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular

Cautelas: Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira

Indicação 4: Infecção grave por Gram-negativo

Via: EV

Apresentação: 250 mg/mL

Dose: 15-20 mg/kg/dose

Máximo: 1,5 g/dose

Intervalo: a cada 24 h

Preparo/administração: Diluir em SF 0,9% ou SG 5%; infundir em 30–60 min

Monitorização: Creatinina, diurese; níveis quando indicado

Cautelas: Ajustar intervalo na disfunção renal; antibiograma/protocolo local

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 5: Infecção intra-abdominal ou peritonite por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL

Dose: 5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h

Máximo: máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal

Intervalo: 8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg

Preparo/administração: Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular

Cautelas: Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira

Indicação 6: Infecção osteoarticular por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL

Dose: 5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h

Máximo: máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal

Intervalo: 8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg

Preparo/administração: Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular

Cautelas: Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira

Indicação 7: Infecção pós-operatória por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL

Dose: 5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h

Máximo: máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal

Intervalo: 8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg

Preparo/administração: Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular

Cautelas: Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira

Indicação 8: Infecção respiratória grave por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL

Dose: 5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h

Máximo: máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal

Intervalo: 8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg

Preparo/administração: Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular

Cautelas: Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira

Indicação 9: Infecção urinária recorrente, complicada ou grave por bactéria sensível — opção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL

Dose: 5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h

Máximo: máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal

Intervalo: 8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg

Preparo/administração: Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular

Cautelas: Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira

Indicação 10: Seps neonatal por bactéria Gram-negativa sensível — ataque IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola brasileira 100 mg/2 mL = 50 mg/mL

Dose: 10 mg/kg, dose de ataque

Máximo: prosseguir com a linha de manutenção neonatal e ajustar por função renal/níveis

Intervalo: dose inicial única

Preparo/administração: Aspirar diretamente da ampola de 50 mg/mL; não diluir para uso IM.

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular

Cautelas: Prematuros podem iniciar diretamente com 7,5 mg/kg 12/12 h; validar idade gestacional e protocolo neonatal.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; dose de ataque neonatal da bula brasileira

Indicação 11: Seps neonatal por bactéria Gram-negativa sensível — manutenção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola brasileira 100 mg/2 mL = 50 mg/mL

Dose: 7,5 mg/kg/dose

Máximo: ajustar por função renal, idade gestacional e níveis séricos

Intervalo: 12/12 h

Preparo/administração: Aspirar diretamente da ampola de 50 mg/mL; não diluir para uso IM.

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular

Cautelas: Validar idade gestacional e protocolo neonatal; evitar associação com outros nefro/ototóxicos quando possível.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; manutenção neonatal da bula brasileira

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.010 — Amilorida

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg

Situação: Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.011 — Aminofilina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Broncoespasmo — terapia adjuvante selecionada, não de primeira linha

Via: VO ou EV conforme fármaco/produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Janela terapêutica estreita para xantinas; revisar interações, arritmia, convulsão e níveis quando aplicável

Situação: Referência documental; benefício-risco e papel atual devem ser confirmados

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.012 — Amoxicilina

Linhas cadastradas: 3. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Otite média aguda — dose alta quando antibiótico indicado

Via: VO

Apresentação: Suspensão 400 mg/5 mL = 80 mg/mL

Dose: 80–90 mg/kg/dia divididos 12/12 h = 40–45 mg/kg/dose

Máximo: máximo diário conforme protocolo/indicação; arquivo-base usa 4 g/dia

Intervalo: 12/12 h; duração conforme foco e evolução

Preparo/administração: Agitar; medir com seringa oral; confirmar concentração 400 mg/5 mL

Monitorização: Resposta em 48–72 h, tolerância GI, reação alérgica

Cautelas: Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia a betalactâmicos

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Indicação 2: Pneumonia adquirida na comunidade — tratamento oral de pneumococo suspeito

Via: VO

Apresentação: Suspensão 400 mg/5 mL = 80 mg/mL

Dose: 80–90 mg/kg/dia divididos 12/12 h = 40–45 mg/kg/dose

Máximo: máximo diário conforme protocolo/indicação; arquivo-base usa 4 g/dia

Intervalo: 12/12 h; duração conforme foco e evolução

Preparo/administração: Agitar; medir com seringa oral; confirmar concentração 400 mg/5 mL

Monitorização: Resposta em 48–72 h, tolerância GI, reação alérgica

Cautelas: Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia a betalactâmicos

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Indicação 3: Rinossinusite bacteriana aguda — dose alta quando indicada

Via: VO

Apresentação: Suspensão 400 mg/5 mL = 80 mg/mL

Dose: 80–90 mg/kg/dia divididos 12/12 h = 40–45 mg/kg/dose

Máximo: máximo diário conforme protocolo/indicação; arquivo-base usa 4 g/dia

Intervalo: 12/12 h; duração conforme foco e evolução

Preparo/administração: Agitar; medir com seringa oral; confirmar concentração 400 mg/5 mL

Monitorização: Resposta em 48–72 h, tolerância GI, reação alérgica

Cautelas: Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia a betalactâmicos

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.013 — Amoxicilina + clavulanato de potássio

Linhas cadastradas: 61. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Aborto séptico por agente sensível — adolescente >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 2: Amigdalite bacteriana por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 3: Amigdalite bacteriana por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 4: Amigdalite bacteriana por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 5: Broncopneumonia por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 6: Broncopneumonia por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 7: Broncopneumonia por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 8: Bronquite bacteriana aguda por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 9: Bronquite bacteriana aguda por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 10: Bronquite bacteriana aguda por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente

adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 11: Bronquite bacteriana crônica exacerbada por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 12: Bronquite bacteriana crônica exacerbada por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 13: Bronquite bacteriana crônica exacerbada por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 14: Celulite bacteriana por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 15: Celulite bacteriana por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 16: Celulite bacteriana por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 17: Cistite por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 18: Cistite por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 19: Cistite por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 20: Ferimento infectado por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 21: Ferimento infectado por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 22: Ferimento infectado por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 23: Furúnculo ou abscesso por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 24: Furúnculo ou abscesso por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 25: Furúnculo ou abscesso por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 26: Infecção genital feminina por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 27: Infecção genital feminina por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 28: Infecção genital feminina por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 29: Infecção pós-cirúrgica por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 30: Infecção pós-cirúrgica por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 31: Infecção pós-cirúrgica por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 32: Osteomielite por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min;

para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 33: Osteomielite por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 34: Osteomielite por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 35: Otite média aguda com risco de beta-lactamase ou falha à amoxicilina

Via: VO

Apresentação: Suspensão 400 mg + 57 mg/5 mL; 80 mg/mL de amoxicilina

Dose: 80–90 mg/kg/dia de amoxicilina divididos 12/12 h

Máximo: máximo pela amoxicilina conforme foco; minimizar clavulanato excessivo

Intervalo: 12/12 h; duração conforme foco

Preparo/administração: Calcular pela amoxicilina; agitar e refrigerar conforme bula do produto

Monitorização: Resposta clínica, diarreia, reação alérgica e hepatotoxicidade rara

Cautelas: Confirmar razão amoxicilina:clavulanato; ajustar função renal; alergia a betalactâmicos

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Indicação 36: Otite média bacteriana por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 37: Otite média bacteriana por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 38: Otite média bacteriana por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 39: Peritonite por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 40: Peritonite por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 41: Peritonite por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 42: Pielonefrite por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 43: Pielonefrite por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 44: Pielonefrite por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 45: Pneumonia lobar por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 46: Pneumonia lobar por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 47: Pneumonia lobar por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 48: Rinossinusite bacteriana com risco de beta-lactamase ou falha à amoxicilina

Via: VO

Apresentação: Suspensão 400 mg + 57 mg/5 mL; 80 mg/mL de amoxicilina

Dose: 80–90 mg/kg/dia de amoxicilina divididos 12/12 h

Máximo: máximo pela amoxicilina conforme foco; minimizar clavulanato excessivo

Intervalo: 12/12 h; duração conforme foco

Preparo/administração: Calcular pela amoxicilina; agitar e refrigerar conforme bula do produto

Monitorização: Resposta clínica, diarreia, reação alérgica e hepatotoxicidade rara

Cautelas: Confirmar razão amoxicilina:clavulanato; ajustar função renal; alergia a betalactâmicos

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Indicação 49: Sepsis intra-abdominal por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente

adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 50: Sepse intra-abdominal por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 51: Sepse intra-abdominal por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 52: Sepse por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 53: Sepses por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 54: Sepses por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 55: Sepses puerperal por agente sensível — adolescente >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 56: Sinusite bacteriana por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 57: Sinusite bacteriana por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 58: Sinusite bacteriana por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 59: Uretrite por agente sensível — >12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato

Máximo: 1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 60: Uretrite por agente sensível — 0 a <3 meses

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Indicação 61: Uretrite por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via: EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)

Dose: 30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato

Máximo: a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo: 8/8 h; em infecção grave, 6/6 h

Preparo/administração: Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade

Cautelas: Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Situação: Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.014 — Amoxicilina + Sulbactam

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.015 — Ampicilina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção grave sem acometimento do SNC

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola 500 mg ou 1 g; padrão operacional 100 mg/mL

Dose: 50 mg/kg/dose

Máximo: 2 g/dose

Intervalo: a cada 6 h

Preparo/administração: Padrão operacional: 500 mg + 5 mL ou 1 g + 10 mL = 100 mg/mL. Confirmar volume de reconstituição na bula da marca; diluir depois se necessário.

Monitorização: Resposta clínica, culturas

Cautelas: Ajustar em insuficiência renal; alergia beta-lactâmico

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 2: Meningite/infecção do SNC

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola 500 mg ou 1 g; padrão operacional 100 mg/mL

Dose: 50 mg/kg/dose a cada 4 h OU 75 mg/kg/dose a cada 6 h

Máximo: 2 g/dose; 300 mg/kg/dia

Intervalo: a cada 4-6 h

Preparo/administração: Padrão operacional: 500 mg + 5 mL ou 1 g + 10 mL = 100 mg/mL. Confirmar bula da marca; usar o volume correspondente a 50 ou 75 mg/kg.

Monitorização: Culturas, LCR, função renal

Cautelas: RN: intervalo depende de IG e idade pós-natal

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.016 — Ampicilina + sulbactam

Linhas cadastradas: 10. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Epiglotite bacteriana por agente sensível — opção IM após a primeira semana

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam

Dose: 37,5 mg/kg/dose do produto 6/6 h ou 50 mg/kg/dose do produto 8/8 h = 25-33,33 mg/kg de ampicilina/dose

Máximo: máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes

Intervalo: 6/6 h no esquema de 37,5 mg/kg/dose ou 8/8 h no esquema de 50 mg/kg/dose

Preparo/administração: Reconstituir com água para injetáveis; lidocaína 0,5% pode reduzir dor somente quando não contraindicada. Usar a solução IM em até 1 hora e dividir volumes grandes entre sítios.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade

Cautelas: Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite, infecção intra-abdominal/pélvica grave ou necessidade de dose alta, preferir via EV.

Situação: Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g

Indicação 2: Epiglotite bacteriana por agente sensível — opção IM na primeira semana de vida

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam

Dose: 37,5 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de ampicilina + 12,5 mg/kg de sulbactam

Máximo: máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes

Intervalo: 12/12 h na primeira semana, especialmente em prematuros

Preparo/administração: Reconstituir com água para injetáveis; usar a solução IM em até 1 hora. A lidocaína 0,5% não deve ser usada no recém-nascido.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade

Cautelas: Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite ou infecção grave, preferir via EV e protocolo neonatal.

Situação: Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g

Indicação 3: Infecção de pele ou tecidos moles por agente sensível — opção IM após a primeira semana

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam

Dose: 37,5 mg/kg/dose do produto 6/6 h ou 50 mg/kg/dose do produto 8/8 h = 25-33,33 mg/kg de ampicilina/dose

Máximo: máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes

Intervalo: 6/6 h no esquema de 37,5 mg/kg/dose ou 8/8 h no esquema de 50 mg/kg/dose

Preparo/administração: Reconstituir com água para injetáveis; lidocaína 0,5% pode reduzir dor somente quando não contraindicada. Usar a solução IM em até 1 hora e dividir volumes grandes entre sítios.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade

Cautelas: Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite, infecção intra-abdominal/pélvica grave ou necessidade de dose alta, preferir via EV.

Situação: Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g

Indicação 4: Infecção de pele ou tecidos moles por agente sensível — opção IM na primeira semana de vida

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam

Dose: 37,5 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de ampicilina + 12,5 mg/kg de sulbactam

Máximo: máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes

Intervalo: 12/12 h na primeira semana, especialmente em prematuros

Preparo/administração: Reconstituir com água para injetáveis; usar a solução IM em até 1 hora. A lidocaína 0,5% não deve ser usada no recém-nascido.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade

Cautelas: Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite ou infecção grave, preferir via EV e protocolo neonatal.

Situação: Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g

Indicação 5: Otite média bacteriana por agente sensível — opção IM após a primeira semana

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam

Dose: 37,5 mg/kg/dose do produto 6/6 h ou 50 mg/kg/dose do produto 8/8 h = 25–33,33 mg/kg de ampicilina/dose

Máximo: máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes

Intervalo: 6/6 h no esquema de 37,5 mg/kg/dose ou 8/8 h no esquema de 50 mg/kg/dose

Preparo/administração: Reconstituir com água para injetáveis; lidocaína 0,5% pode reduzir dor somente quando não contraindicada. Usar a solução IM em até 1 hora e dividir volumes grandes entre sítios.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade

Cautelas: Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite, infecção intra-abdominal/pélvica grave ou necessidade de dose alta, preferir via EV.

Situação: Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g

Indicação 6: Otite média bacteriana por agente sensível — opção IM na primeira semana de vida

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam

Dose: 37,5 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de ampicilina + 12,5 mg/kg de sulbactam

Máximo: máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes

Intervalo: 12/12 h na primeira semana, especialmente em prematuros

Preparo/administração: Reconstituir com água para injetáveis; usar a solução IM em até 1 hora. A lidocaína 0,5% não deve ser usada no recém-nascido.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade

Cautelas: Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite ou infecção grave, preferir via EV e protocolo neonatal.

Situação: Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g

Indicação 7: Pneumonia bacteriana por agente sensível — opção IM após a primeira semana

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam

Dose: 37,5 mg/kg/dose do produto 6/6 h ou 50 mg/kg/dose do produto 8/8 h = 25–33,33 mg/kg de ampicilina/dose

Máximo: máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes

Intervalo: 6/6 h no esquema de 37,5 mg/kg/dose ou 8/8 h no esquema de 50 mg/kg/dose

Preparo/administração: Reconstituir com água para injetáveis; lidocaína 0,5% pode reduzir dor somente quando não contraindicada. Usar a solução IM em até 1 hora e dividir volumes grandes entre sítios.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade

Cautelas: Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite, infecção intra-abdominal/pélvica grave ou necessidade de dose alta, preferir via EV.

Situação: Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g

Indicação 8: Pneumonia bacteriana por agente sensível — opção IM na primeira semana de vida

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam

Dose: 37,5 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de ampicilina + 12,5 mg/kg de sulbactam

Máximo: máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes

Intervalo: 12/12 h na primeira semana, especialmente em prematuros

Preparo/administração: Reconstituir com água para injetáveis; usar a solução IM em até 1 hora. A lidocaína 0,5% não deve ser usada no recém-nascido.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade

Cautelas: Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite ou infecção grave, preferir via EV e protocolo neonatal.

Situação: Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g

Indicação 9: Sinusite bacteriana por agente sensível — opção IM após a primeira semana

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam

Dose: 37,5 mg/kg/dose do produto 6/6 h ou 50 mg/kg/dose do produto 8/8 h = 25–33,33 mg/kg de ampicilina/dose

Máximo: máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes

Intervalo: 6/6 h no esquema de 37,5 mg/kg/dose ou 8/8 h no esquema de 50 mg/kg/dose

Preparo/administração: Reconstituir com água para injetáveis; lidocaína 0,5% pode reduzir dor somente quando não contraindicada. Usar a solução IM em até 1 hora e dividir volumes grandes entre sítios.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade

Cautelas: Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite, infecção intra-abdominal/pélvica grave ou necessidade de dose alta, preferir via EV.

Situação: Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g

Indicação 10: Sinusite bacteriana por agente sensível — opção IM na primeira semana de vida

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam

Dose: 37,5 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de ampicilina + 12,5 mg/kg de sulbactam

Máximo: máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes

Intervalo: 12/12 h na primeira semana, especialmente em prematuros

Preparo/administração: Reconstituir com água para injetáveis; usar a solução IM em até 1 hora. A lidocaína 0,5% não deve ser usada no recém-nascido.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade

Cautelas: Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite ou infecção grave, preferir via EV e protocolo neonatal.

Situação: Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.017 — Ampicilina-sulbactam

Linhas cadastradas: 6. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção de pele e tecidos moles

Via: EV

Apresentação: 1,5 g ou 3 g; 250 mg/mL de ampicilina após reconstituição

Dose: 50 mg/kg/dose de ampicilina (= 75 mg/kg/dose do produto)

Máximo: 2 g de ampicilina/dose

Intervalo: a cada 6 h

Preparo/administração: Reconstituir conforme bula para 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam; para EV, diluir até 30 mg/mL de ampicilina (faixa de bula: 2-30 mg/mL).

Monitorização: Resposta, culturas, função hepática/renal

Cautelas: Ajustar em insuficiência renal; sempre declarar base ampicilina

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 2: Infecção intra-abdominal bacteriana

Via: EV

Apresentação: 1,5 g ou 3 g; 250 mg/mL de ampicilina após reconstituição

Dose: 50 mg/kg/dose de ampicilina (= 75 mg/kg/dose do produto)

Máximo: 2 g de ampicilina/dose

Intervalo: a cada 6 h

Preparo/administração: Reconstituir conforme bula para 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam; para EV, diluir até 30 mg/mL de ampicilina (faixa de bula: 2-30 mg/mL).

Monitorização: Resposta, culturas, função hepática/renal

Cautelas: Ajustar em insuficiência renal; sempre declarar base ampicilina

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 3: Infecção polimicrobiana grave

Via: EV

Apresentação: 1,5 g ou 3 g; 250 mg/mL de ampicilina após reconstituição

Dose: 50 mg/kg/dose de ampicilina

Máximo: 2 g de ampicilina/dose

Intervalo: a cada 6 h

Preparo/administração: Reconstituir conforme bula para 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam; para EV, diluir até 30 mg/mL de ampicilina.

Monitorização: Ferida, culturas quando indicadas

Cautelas: Avaliar profilaxia antirrábica/antitetânica conforme exposição

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 4: Infecção respiratória bacteriana

Via: EV

Apresentação: 1,5 g ou 3 g; 250 mg/mL de ampicilina após reconstituição

Dose: 50 mg/kg/dose de ampicilina (= 75 mg/kg/dose do produto)

Máximo: 2 g de ampicilina/dose

Intervalo: a cada 6 h

Preparo/administração: Reconstituir conforme bula para 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam; para EV, diluir até 30 mg/mL de ampicilina (faixa de bula: 2-30 mg/mL).

Monitorização: Resposta, culturas, função hepática/renal

Cautelas: Ajustar em insuficiência renal; sempre declarar base ampicilina

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 5: Mordedura animal

Via: EV

Apresentação: 1,5 g ou 3 g; 250 mg/mL de ampicilina após reconstituição

Dose: 50 mg/kg/dose de ampicilina

Máximo: 2 g de ampicilina/dose

Intervalo: a cada 6 h

Preparo/administração: Reconstituir conforme bula para 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam; para EV, diluir até 30 mg/mL de ampicilina.

Monitorização: Ferida, culturas quando indicadas

Cautelas: Avaliar profilaxia antirrábica/antitetânica conforme exposição

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 6: Mordedura humana

Via: EV

Apresentação: 1,5 g ou 3 g; 250 mg/mL de ampicilina após reconstituição

Dose: 50 mg/kg/dose de ampicilina

Máximo: 2 g de ampicilina/dose

Intervalo: a cada 6 h

Preparo/administração: Reconstituir conforme bula para 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam; para EV, diluir até 30 mg/mL de ampicilina.

Monitorização: Ferida, culturas quando indicadas

Cautelas: Avaliar profilaxia antirrábica/antitetânica conforme exposição

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.018 — Anfotericina B

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via: Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância

Situação: Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.019 — Azelastina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto

Via: Nasal ou oftálmica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima

Situação: Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL

Indicação 2: Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto

Via: Nasal ou oftálmica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima

Situação: Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.020 — Azitromicina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Pneumonia atípica — continuidade VO

Via: VO

Apresentação: Suspensão oral 200 mg/5 mL = 40 mg/mL

Dose: 10 mg/kg no dia 1; 5 mg/kg/dia nos dias 2-5

Máximo: 500 mg no dia 1; 250 mg/dia depois

Intervalo: a cada 24 h

Preparo/administração: Reconstituir o frasco até o volume indicado pelo fabricante; concentração de referência 200 mg/5 mL. Agitar antes de cada retirada.

Monitorização: Resposta clínica

Cautelas: Uso deve seguir epidemiologia e protocolo antimicrobiano

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 2: Pneumonia atípica com necessidade de via EV

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola 500 mg; solução final 1-2 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose

Máximo: 500 mg/dose

Intervalo: a cada 24 h

Preparo/administração: Reconstituir conforme bula e diluir a concentração final de 2 mg/mL (preferida para menor volume) ou 1 mg/mL; infundir por pelo menos 1 hora.

Monitorização: ECG se risco de QT, função hepática

Cautelas: Evitar associação com outros prolongadores de QT quando possível

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.021 — Aztreonam

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.022 — Bacitracina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Indicação 2: Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.023 — Bamifilina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Broncoespasmo — terapia adjuvante selecionada, não de primeira linha

Via: VO ou EV conforme fármaco/produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Janela terapêutica estreita para xantinas; revisar interações, arritmia, convulsão e níveis quando aplicável

Situação: Referência documental; benefício-risco e papel atual devem ser confirmados

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.024 — Beclometasona

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Controle de asma persistente

Via: Inalatória

Apresentação: Inalador 50 mcg/jato

Dose: 100–400 mcg/dia, divididos

Máximo: definido pelo degrau terapêutico

Intervalo: 1–2 vezes/dia

Preparo/administração: Usar o dispositivo e espaçador; a unidade operacional é jato, não mL.

Monitorização: Controle de sintomas, técnica, crescimento em uso prolongado

Cautelas: Não é medicação de resgate

Situação: Uso pediátrico em bula; dose depende da idade/dispositivo

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.025 — Benzidamina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dor/inflamação local — uso tópico conforme produto e idade

Via: Tópica/oromucosa/retal conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Evitar ingestão, uso em mucosa lesada extensa e formulação inadequada para a idade

Situação: Posologia por aplicação depende da formulação; não converter em mL

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.026 — Benzilpenicilina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar sal/formulação conforme síndrome

Via: VO, IM ou EV conforme sal

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, sal, concentração e via; penicilina benzatina nunca EV

Situação: Não intercambiar benzatina, procaína, cristalina ou penicilina V; linhas específicas originais foram preservadas

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.027 — Benzoato de benzila

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via: VO ou tópica conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais

Situação: Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.028 — Betametasona

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Doença inflamatória/alérgica específica — corticoide sistêmico ou tópico

Via: VO, IM, tópica ou intra-articular conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; avaliar duração, desmame e imunossupressão

Situação: Potência e equivalência variam; selecionar indicação e formulação antes de calcular

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.029 — Brometo de N-butilescopolamina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dor abdominal espasmódica — uso sintomático selecionado após excluir causa cirúrgica

Via: VO, IM ou EV conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Efeitos anticolinérgicos; evitar em glaucoma, retenção urinária, íleo e suspeita de obstrução

Situação: Dose e idade mínima variam por sal/apresentação; não intercambiar sais

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.030 — Bromexina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Secreção respiratória espessa — uso mucolítico apenas quando individualmente indicado

Via: VO ou inalatória conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Pode aumentar volume de secreções/broncoespasmo; contraindicações e idade mínima variam por produto

Situação: Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; resposta depende da idade e apresentação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.031 — Bromoprida

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Náuseas/vômitos — uso selecionado após tratar a causa e avaliar risco de QT

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar QT, distonia/efeitos extrapiramidais, interações e distúrbios eletrolíticos

Situação: Não usar rotineiramente; dose/idade dependem do produto e da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.032 — Budesonida

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Controle de asma quando nebulização é necessária

Via: Nebulização

Apresentação: Suspensão 0,25 ou 0,5 mg/mL

Dose: 0,25–0,5 mg/dose

Máximo: máximo depende da idade/degrau; usual até 1 mg/dia

Intervalo: 1–2 vezes/dia

Preparo/administração: Pura ou completar volume conforme nebulizador

Monitorização: Controle, candidíase oral, crescimento

Cautelas: Não é broncodilatador de resgate; não usar rotineiramente na bronquiolite

Situação: Uso pediátrico em bula; ajustar por idade

Indicação 2: Crupe quando dexametasona não é viável

Via: Nebulização

Apresentação: Suspensão para nebulização

Dose: 2 mg, dose única

Máximo: 2 mg

Intervalo: dose única

Preparo/administração: Nebulizar; não misturar sem compatibilidade confirmada

Monitorização: Estridor, esforço respiratório

Cautelas: Dexametasona sistêmica continua preferida na maioria dos protocolos

Situação: Off-label/alternativa em protocolo

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.033 — Bumetanida

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg

Situação: Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.034 — Buprenorfina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dor moderada/intensa — opção opioide selecionada por protocolo e idade

Via: VO, EV, IM ou transmucosa conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Monitorar ventilação/sedação; codeína e tramadol têm restrições importantes em menores de 12 anos e após adenoamigdalectomia

Situação: Uso restrito; resposta condicionada às contraindicações etárias e à variabilidade metabólica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.035 — Cambendazol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via: VO ou tópica conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais

Situação: Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.036 — Captopril

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg

Situação: Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.037 — Carbamazepina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica

Situação: Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.038 — Carbocisteína

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Secreção respiratória espessa — uso mucolítico apenas quando individualmente indicado

Via: VO ou inalatória conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Pode aumentar volume de secreções/broncoespasmo; contraindicações e idade mínima variam por produto

Situação: Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; resposta depende da idade e apresentação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.039 — Cefaclor

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Otite média aguda por agente sensível — alternativa

Via: VO

Apresentação: Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL

Dose: 40 mg/kg/dia divididos 8/8 h = 13,33 mg/kg/dose

Máximo: máximo 1 g/dia no arquivo-base

Intervalo: 8/8 h

Preparo/administração: Reconstituir conforme bula; agitar antes de usar

Monitorização: Resposta clínica, alergia, diarreia

Cautelas: Ajustar função renal; confirmar alergia a cefalosporinas/betalactâmicos

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Indicação 2: Rinossinusite bacteriana por agente sensível — alternativa

Via: VO

Apresentação: Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL

Dose: 40 mg/kg/dia divididos 8/8 h = 13,33 mg/kg/dose

Máximo: máximo 1 g/dia no arquivo-base

Intervalo: 8/8 h

Preparo/administração: Reconstituir conforme bula; agitar antes de usar

Monitorização: Resposta clínica, alergia, diarreia

Cautelas: Ajustar função renal; confirmar alergia a cefalosporinas/betalactâmicos

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.040 — Cefadroxila

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.041 — Cefalexina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção de pele/partes moles por agente sensível

Via: VO

Apresentação: Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL

Dose: 12,5 mg/kg/dose; o intervalo define 25 mg/kg/dia (12/12 h) ou 50 mg/kg/dia (6/6 h)

Máximo: máximo 4 g/dia no arquivo-base; confirmar indicação

Intervalo: dividir em 2-4 doses

Preparo/administração: Reconstituir conforme bula; agitar; medir com seringa oral

Monitorização: Resposta clínica, tolerância GI, alergia

Cautelas: Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia imediata grave a betalactâmicos

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Indicação 2: Infecção urinária afebril por agente sensível

Via: VO

Apresentação: Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL

Dose: 12,5 mg/kg/dose; o intervalo define 25 mg/kg/dia (12/12 h) ou 50 mg/kg/dia (6/6 h)

Máximo: máximo 4 g/dia no arquivo-base; confirmar indicação

Intervalo: dividir em 2-4 doses

Preparo/administração: Reconstituir conforme bula; agitar; medir com seringa oral

Monitorização: Resposta clínica, tolerância GI, alergia

Cautelas: Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia imediata grave a betalactâmicos

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.042 — Cefalotina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.043 — Cefazolina

Linhas cadastradas: 3. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção grave por MSSA

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola 1 g; solução de referência 100 mg/mL

Dose: 50 mg/kg/dose

Máximo: 2 g/dose

Intervalo: a cada 8 h

Preparo/administração: Reconstituir 1 g para concentração de 100 mg/mL; para infusão, diluir adicionalmente conforme bula/protocolo e compatibilidade.

Monitorização: Culturas, função renal

Cautelas: Ajustar em insuficiência renal

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 2: Infecção leve/moderada por MSSA/estreptococos

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola 1 g; solução de referência 100 mg/mL

Dose: 25 mg/kg/dose

Máximo: 1 g/dose

Intervalo: a cada 8 h

Preparo/administração: Reconstituir 1 g para concentração de 100 mg/mL; para infusão, diluir adicionalmente conforme bula/protocolo e compatibilidade.

Monitorização: Culturas, resposta

Cautelas: Ajustar em insuficiência renal

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 3: Profilaxia perioperatória

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola 1 g; solução de referência 100 mg/mL

Dose: 30 mg/kg/dose

Máximo: 2 g; 3 g se protocolo adulto/peso elevado

Intervalo: 30–60 min antes da incisão; redose conforme duração/perda

Preparo/administração: Reconstituir 1 g para concentração de 100 mg/mL; para infusão, diluir adicionalmente conforme bula/protocolo e compatibilidade.

Monitorização: Tempo da dose

Cautelas: Ajustar ao protocolo e tipo de cirurgia

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.044 — Cefepima

Linhas cadastradas: 8. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção de pele e estruturas cutâneas leve a moderada — opção IM — >2 meses e ≤40 kg

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 3 mL de água para injetáveis, SF 0,9% ou SG 5% → volume final aproximado 4,2 mL = 238 mg/mL

Dose: 50 mg/kg/dose

Máximo: máximo 1 g/dose e 1 g por glúteo; acima de 40 kg usar dose fixa da linha correspondente

Intervalo: 12/12 h por 10 dias; reavaliar foco, cultura e resposta

Preparo/administração: Reconstituir o frasco de 1 g com 3 mL; aspirar o volume calculado. Administrar profundamente em grande massa muscular; não exceder 1 g por glúteo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal, neurotoxicidade e reação local

Cautelas: Via EV é preferencial em infecção grave, risco de morte, choque, sepse, meningite ou neutropenia febril. Ajustar na disfunção renal.

Situação: Bula profissional brasileira; experiência pediátrica IM limitada; reservar a infecção leve/moderada selecionada

Indicação 2: Infecção de pele e estruturas cutâneas leve a moderada — opção IM — >40 kg

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 3 mL de água para injetáveis, SF 0,9% ou SG 5% → volume final aproximado 4,2 mL = 238 mg/mL

Dose: 1 g/dose

Máximo: máximo 1 g por glúteo nesta linha

Intervalo: 12/12 h; duração conforme foco e evolução

Preparo/administração: Reconstituir o frasco de 1 g com 3 mL e administrar todo o volume final aproximado de 4,2 mL por IM profunda.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal, neurotoxicidade e reação local

Cautelas: Via EV é preferencial em infecção grave, risco de morte, choque, sepse, meningite ou neutropenia febril. Ajustar na disfunção renal.

Situação: Bula profissional brasileira; experiência pediátrica IM limitada; reservar a infecção leve/moderada selecionada

Indicação 3: Infecção do trato urinário leve a moderada — opção IM — >2 meses e ≤40 kg

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 3 mL de água para injetáveis, SF 0,9% ou SG 5% → volume final aproximado 4,2 mL = 238 mg/mL

Dose: 50 mg/kg/dose

Máximo: máximo 1 g/dose e 1 g por glúteo; acima de 40 kg usar dose fixa da linha correspondente

Intervalo: 12/12 h por 10 dias; reavaliar foco, cultura e resposta

Preparo/administração: Reconstituir o frasco de 1 g com 3 mL; aspirar o volume calculado. Administrar profundamente em grande massa muscular; não exceder 1 g por glúteo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal, neurotoxicidade e reação local

Cautelas: Via EV é preferencial em infecção grave, risco de morte, choque, sepse, meningite ou neutropenia febril. Ajustar na disfunção renal.

Situação: Bula profissional brasileira; experiência pediátrica IM limitada; reservar a infecção leve/moderada selecionada

Indicação 4: Infecção do trato urinário leve a moderada — opção IM — >40 kg

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 3 mL de água para injetáveis, SF 0,9% ou SG 5% → volume final aproximado 4,2 mL = 238 mg/mL

Dose: 1 g/dose

Máximo: máximo 1 g por glúteo nesta linha

Intervalo: 12/12 h; duração conforme foco e evolução

Preparo/administração: Reconstituir o frasco de 1 g com 3 mL e administrar todo o volume final aproximado de 4,2 mL por IM profunda.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal, neurotoxicidade e reação local

Cautelas: Via EV é preferencial em infecção grave, risco de morte, choque, sepse, meningite ou neutropenia febril. Ajustar na disfunção renal.

Situação: Bula profissional brasileira; experiência pediátrica IM limitada; reservar a infecção leve/moderada selecionada

Indicação 5: Neutropenia febril

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola 1 g ou 2 g; 100 mg/mL reconstituído

Dose: 50 mg/kg/dose

Máximo: 2 g/dose

Intervalo: a cada 8 h

Preparo/administração: Reconstituir para 100 mg/mL; aspirar o volume calculado e diluir para concentração final de 40 mg/mL (dentro da faixa de compatibilidade de bula).

Monitorização: Culturas, função renal

Cautelas: Ajustar em insuficiência renal

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 6: Pneumonia bacteriana leve a moderada — opção IM — >2 meses e ≤40 kg

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 3 mL de água para injetáveis, SF 0,9% ou SG 5% → volume final aproximado 4,2 mL = 238 mg/mL

Dose: 50 mg/kg/dose

Máximo: máximo 1 g/dose e 1 g por glúteo; acima de 40 kg usar dose fixa da linha correspondente

Intervalo: 12/12 h por 10 dias; reavaliar foco, cultura e resposta

Preparo/administração: Reconstituir o frasco de 1 g com 3 mL; aspirar o volume calculado. Administrar profundamente em grande massa muscular; não exceder 1 g por glúteo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal, neurotoxicidade e reação local

Cautelas: Via EV é preferencial em infecção grave, risco de morte, choque, sepse, meningite ou neutropenia febril. Ajustar na disfunção renal.

Situação: Bula profissional brasileira; experiência pediátrica IM limitada; reservar a infecção leve/moderada selecionada

Indicação 7: Pneumonia bacteriana leve a moderada — opção IM — >40 kg

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 3 mL de água para injetáveis, SF 0,9% ou SG 5% → volume final aproximado 4,2 mL = 238 mg/mL

Dose: 1 g/dose

Máximo: máximo 1 g por glúteo nesta linha

Intervalo: 12/12 h; duração conforme foco e evolução

Preparo/administração: Reconstituir o frasco de 1 g com 3 mL e administrar todo o volume final aproximado de 4,2 mL por IM profunda.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal, neurotoxicidade e reação local

Cautelas: Via EV é preferencial em infecção grave, risco de morte, choque, sepse, meningite ou neutropenia febril. Ajustar na disfunção renal.

Situação: Bula profissional brasileira; experiência pediátrica IM limitada; reservar a infecção leve/moderada selecionada

Indicação 8: Sepse/infecção grave com risco de Gram-negativo resistente

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola 1 g ou 2 g; 100 mg/mL reconstituído

Dose: 50 mg/kg/dose

Máximo: 2 g/dose

Intervalo: a cada 8 h

Preparo/administração: Reconstituir para 100 mg/mL; aspirar o volume calculado e diluir para concentração final de 40 mg/mL (dentro da faixa de compatibilidade de bula).

Monitorização: Culturas, função renal, neurotoxicidade

Cautelas: Ajustar em insuficiência renal

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.045 — Cefotaxima

Linhas cadastradas: 7. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção com risco de vida por agente sensível — esquema EV

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 500 mg ou 1 g; solução reconstituída aproximadamente 215–216 mg/mL

Dose: 50 mg/kg/dose = 200 mg/kg/dia

Máximo: máximo operacional 3 g/dose (12 g/dia); confirmar protocolo e infectologia

Intervalo: 6/6 h

Preparo/administração: Reconstituir conforme o frasco e administrar por infusão nas doses altas, conforme bula/protocolo institucional.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e neurotoxicidade

Cautelas: Alta vigilância; ajustar na disfunção renal e reavaliar diariamente descalonamento/antibiograma.

Situação: Bula profissional brasileira; extremo superior de 200 mg/kg/dia reservado a risco de vida

Indicação 2: Infecção por agente sensível — esquema EV usual

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 500 mg ou 1 g; adicionar 2 mL ou 4 mL, respectivamente → aproximadamente 215–216 mg/mL

Dose: 25 mg/kg/dose = 50 mg/kg/dia

Máximo: máximo operacional 1 g/dose nesta linha; aumentar somente conforme gravidade/protocolo

Intervalo: 12/12 h

Preparo/administração: Reconstituir conforme o frasco; administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão conforme bula/protocolo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e neurotoxicidade

Cautelas: Ajustar na disfunção renal. Não misturar com bicarbonato de sódio.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema usual selecionado dentro da faixa de 50–100 mg/kg/dia

Indicação 3: Infecção por agente sensível — esquema IM usual

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 500 mg ou 1 g; adicionar 2 mL ou 4 mL, respectivamente → aproximadamente 215–216 mg/mL

Dose: 25 mg/kg/dose = 50 mg/kg/dia

Máximo: máximo 1 g/dose e 2 g/dia por IM; dividir volume >4 mL entre sítios

Intervalo: 12/12 h

Preparo/administração: Reconstituir com água para injetáveis e aplicar profundamente. Lidocaína 1% pode ser usada apenas por IM, nunca EV, e é contraindicada abaixo de 30 meses ou nas demais contraindicações da lidocaína.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação local

Cautelas: Preferir EV em infecção grave, risco de vida ou dose diária >2 g. Não usar lidocaína em criança <30 meses.

Situação: Bula profissional brasileira; IM somente em paciente estável e quando a dose diária não exceder 2 g

Indicação 4: Infecção por agente sensível — EV no prematuro/RN com até 1 semana

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 500 mg ou 1 g; adicionar 2 mL ou 4 mL, respectivamente → aproximadamente 215–216 mg/mL

Dose: 25–50 mg/kg/dose = 50–100 mg/kg/dia

Máximo: ajustar por idade gestacional, gravidade, função renal e protocolo neonatal

Intervalo: 12/12 h

Preparo/administração: Reconstituir conforme o frasco; administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão conforme bula/protocolo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e neurotoxicidade

Cautelas: Não usar IM no prematuro/RN desta faixa. Não usar lidocaína por via EV.

Situação: Bula profissional brasileira; somente EV nesta faixa neonatal

Indicação 5: Infecção por agente sensível — EV no prematuro/RN de >1 a 4 semanas

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 500 mg ou 1 g; adicionar 2 mL ou 4 mL, respectivamente → aproximadamente 215–216 mg/mL

Dose: 25–50 mg/kg/dose = 75–150 mg/kg/dia

Máximo: ajustar por idade gestacional, gravidade, função renal e protocolo neonatal

Intervalo: 8/8 h

Preparo/administração: Reconstituir conforme o frasco; administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão conforme bula/protocolo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e neurotoxicidade

Cautelas: Não usar IM no prematuro/RN desta faixa. Não usar lidocaína por via EV.

Situação: Bula profissional brasileira; somente EV nesta faixa neonatal

Indicação 6: Infecção típica por agente sensível — adolescente >12 anos

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 4 mL → volume final aproximado 4,63 mL = 216 mg/mL

Dose: 1 g/dose

Máximo: por IM, não exceder 2 g/dia e dividir volume >4 mL entre sítios; doses maiores devem ser EV

Intervalo: 12/12 h

Preparo/administração: Reconstituir com 4 mL. Para IM, aplicar profundamente e dividir entre sítios; para EV, administrar em 3–5 min ou infundir conforme bula.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação local

Cautelas: Lidocaína somente IM e se não houver contraindicação. Doses diárias >2 g devem ser EV.

Situação: Bula profissional brasileira; posologia de adulto/adolescente >12 anos

Indicação 7: Infecção típica por agente sensível — criança ≤12 anos com ≥50 kg

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 4 mL → volume final aproximado 4,63 mL = 216 mg/mL

Dose: 1 g/dose

Máximo: por IM, não exceder 2 g/dia e dividir volume >4 mL entre sítios; doses maiores devem ser EV

Intervalo: 12/12 h

Preparo/administração: Reconstituir com 4 mL. Para IM, aplicar profundamente e dividir entre sítios; para EV, administrar em 3–5 min ou infundir conforme bula.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação local

Cautelas: Lidocaína somente IM e se não houver contraindicação. Doses diárias >2 g devem ser EV.

Situação: Bula profissional brasileira; posologia de adulto/adolescente >12 anos

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.046 — Cefprozila

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.047 — Ceftazidima

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.048 — Ceftriaxona

Linhas cadastradas: 3. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Meningite bacteriana

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola 1 g; 100 mg/mL reconstituído

Dose: 50 mg/kg/dose

Máximo: 2 g/dose; 4 g/dia

Intervalo: a cada 12 h

Preparo/administração: EV: reconstituir 1 g conforme bula para 100 mg/mL; diluir o volume aspirado até 40 mg/mL. Aplicar restrições neonatais e incompatibilidade com cálcio.

Monitorização: LCR/culturas, resposta, função hepática

Cautelas: Não coadministrar com cálcio em RN ≤ 28 d; evitar em RN hiperbilirrubinêmico/prematuro

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 2: Otite média aguda — resgate

Via: IM/EV

Apresentação: Frasco-ampola 1 g; IM 250 mg/mL ou EV final 40 mg/mL

Dose: 50 mg/kg/dose

Máximo: 1 g/dose

Intervalo: a cada 24 h por 1–3 dias conforme cenário

Preparo/administração: IM: reconstituir conforme bula para 250 mg/mL. EV: reconstituir e diluir até 40 mg/mL. Não usar diluente com lidocaína por via EV.

Monitorização: Resposta em 48–72 h

Cautelas: Indicação depende de falha/intolerância e diagnóstico

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 3: Seps, pneumonia ou outra infecção grave sem meningite

Via: EV/IM

Apresentação: Frasco-ampola 1 g; 100 mg/mL reconstituído

Dose: 50 mg/kg/dose

Máximo: 2 g/dose

Intervalo: a cada 24 h

Preparo/administração: EV: reconstituir conforme bula para 100 mg/mL e diluir até 40 mg/mL; não misturar/coadministrar com cálcio quando contraindicado.

Monitorização: Culturas, função hepática/biliar

Cautelas: RN: contraindicações específicas para prematuridade, hiperbilirrubinemia e cálcio EV

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.049 — Cefuroxima

Linhas cadastradas: 9. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção de pele e tecidos moles por agente sensível — opção EV

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro Keroxime® 750 mg; EV: adicionar 8 mL de água para injetáveis → volume final aproximado 8,6 mL = 87,21 mg/mL

Dose: 20 mg/kg/dose = 60 mg/kg/dia divididos 8/8 h

Máximo: máximo 750 mg/dose nesta linha; doses maiores dependem da gravidade e protocolo

Intervalo: 8/8 h; duração conforme foco, cultura e resposta

Preparo/administração: Adicionar 8 mL de água para injetáveis ao frasco de 750 mg; o volume final aproximado é 8,6 mL. Aspirar o volume calculado; administrar EV direta em 3–5 min ou diluir para infusão conforme bula/protocolo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal e hipersensibilidade

Cautelas: Não usar esta linha para meningite. Ajustar na disfunção renal e confirmar alergia a betalactâmicos.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; regime usual de 60 mg/kg/dia para a maioria das infecções, fora de meningite

Indicação 2: Infecção de pele e tecidos moles por agente sensível — opção IM

Via: IM

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 750 mg; IM: adicionar 3 mL de água para injetáveis → volume final aproximado 3,5 mL = 214,29 mg/mL

Dose: 20 mg/kg/dose = 60 mg/kg/dia divididos 8/8 h

Máximo: máximo 750 mg/dose nesta linha; doses maiores dependem da gravidade e protocolo

Intervalo: 8/8 h; duração conforme foco, cultura e resposta

Preparo/administração: Adicionar 3 mL de água para injetáveis ao frasco de 750 mg e agitar delicadamente até formar suspensão opaca; o volume final aproximado é 3,5 mL. Aspirar o volume calculado.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal e hipersensibilidade

Cautelas: Não usar esta linha para meningite. Ajustar na disfunção renal e confirmar alergia a betalactâmicos.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; regime usual de 60 mg/kg/dia para a maioria das infecções, fora de meningite

Indicação 3: Infecção do trato urinário por agente sensível — opção EV

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro Keroxime® 750 mg; EV: adicionar 8 mL de água para injetáveis → volume final aproximado 8,6 mL = 87,21 mg/mL

Dose: 20 mg/kg/dose = 60 mg/kg/dia divididos 8/8 h

Máximo: máximo 750 mg/dose nesta linha; doses maiores dependem da gravidade e protocolo

Intervalo: 8/8 h; duração conforme foco, cultura e resposta

Preparo/administração: Adicionar 8 mL de água para injetáveis ao frasco de 750 mg; o volume final aproximado é 8,6 mL. Aspirar o volume calculado; administrar EV direta em 3–5 min ou diluir para infusão conforme bula/protocolo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal e hipersensibilidade

Cautelas: Não usar esta linha para meningite. Ajustar na disfunção renal e confirmar alergia a betalactâmicos.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; regime usual de 60 mg/kg/dia para a maioria das infecções, fora de meningite

Indicação 4: Infecção do trato urinário por agente sensível — opção IM

Via: IM

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 750 mg; IM: adicionar 3 mL de água para injetáveis → volume final aproximado 3,5 mL = 214,29 mg/mL

Dose: 20 mg/kg/dose = 60 mg/kg/dia divididos 8/8 h

Máximo: máximo 750 mg/dose nesta linha; doses maiores dependem da gravidade e protocolo

Intervalo: 8/8 h; duração conforme foco, cultura e resposta

Preparo/administração: Adicionar 3 mL de água para injetáveis ao frasco de 750 mg e agitar delicadamente até formar suspensão opaca; o volume final aproximado é 3,5 mL. Aspirar o volume calculado.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal e hipersensibilidade

Cautelas: Não usar esta linha para meningite. Ajustar na disfunção renal e confirmar alergia a betalactâmicos.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; regime usual de 60 mg/kg/dia para a maioria das infecções, fora de meningite

Indicação 5: Otite média aguda por agente sensível — alternativa oral

Via: VO

Apresentação: Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL

Dose: 30 mg/kg/dia divididos 12/12 h = 15 mg/kg/dose

Máximo: máximo 1 g/dia no arquivo-base para OMA/sinusite/piodermite

Intervalo: 12/12 h

Preparo/administração: Reconstituir conforme bula; administrar após alimento quando indicado pelo produto

Monitorização: Resposta clínica, alergia e tolerância GI

Cautelas: Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia a betalactâmicos

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Indicação 6: Pneumonia adquirida na comunidade por agente sensível — alternativa oral

Via: VO

Apresentação: Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL

Dose: 30 mg/kg/dia divididos 12/12 h = 15 mg/kg/dose

Máximo: máximo 1 g/dia no arquivo-base para OMA/sinusite/piodermite

Intervalo: 12/12 h

Preparo/administração: Reconstituir conforme bula; administrar após alimento quando indicado pelo produto

Monitorização: Resposta clínica, alergia e tolerância GI

Cautelas: Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia a betalactâmicos

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Indicação 7: Pneumonia bacteriana por agente sensível — opção EV

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro Keroxime® 750 mg; EV: adicionar 8 mL de água para injetáveis → volume final aproximado 8,6 mL = 87,21 mg/mL

Dose: 20 mg/kg/dose = 60 mg/kg/dia divididos 8/8 h

Máximo: máximo 750 mg/dose nesta linha; doses maiores dependem da gravidade e protocolo

Intervalo: 8/8 h; duração conforme foco, cultura e resposta

Preparo/administração: Adicionar 8 mL de água para injetáveis ao frasco de 750 mg; o volume final aproximado é 8,6 mL. Aspirar o volume calculado; administrar EV direta em 3–5 min ou diluir para infusão conforme bula/protocolo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal e hipersensibilidade

Cautelas: Não usar esta linha para meningite. Ajustar na disfunção renal e confirmar alergia a betalactâmicos.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; regime usual de 60 mg/kg/dia para a maioria das infecções, fora de meningite

Indicação 8: Pneumonia bacteriana por agente sensível — opção IM

Via: IM

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 750 mg; IM: adicionar 3 mL de água para injetáveis → volume final aproximado 3,5 mL = 214,29 mg/mL

Dose: 20 mg/kg/dose = 60 mg/kg/dia divididos 8/8 h

Máximo: máximo 750 mg/dose nesta linha; doses maiores dependem da gravidade e protocolo

Intervalo: 8/8 h; duração conforme foco, cultura e resposta

Preparo/administração: Adicionar 3 mL de água para injetáveis ao frasco de 750 mg e agitar delicadamente até formar suspensão opaca; o volume final aproximado é 3,5 mL. Aspirar o volume calculado.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função renal e hipersensibilidade

Cautelas: Não usar esta linha para meningite. Ajustar na disfunção renal e confirmar alergia a betalactâmicos.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; regime usual de 60 mg/kg/dia para a maioria das infecções, fora de meningite

Indicação 9: Rinossinusite bacteriana por agente sensível — alternativa oral

Via: VO

Apresentação: Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL

Dose: 30 mg/kg/dia divididos 12/12 h = 15 mg/kg/dose

Máximo: máximo 1 g/dia no arquivo-base para OMA/sinusite/piodermite

Intervalo: 12/12 h

Preparo/administração: Reconstituir conforme bula; administrar após alimento quando indicado pelo produto

Monitorização: Resposta clínica, alergia e tolerância GI

Cautelas: Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia a betalactâmicos

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.050 — Celulose natural

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Constipação funcional — desimpactação

Via: VO ou retal conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias

Situação: Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação

Indicação 2: Constipação funcional — manutenção

Via: VO ou retal conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias

Situação: Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.051 — Cetamina

Linhas cadastradas: 4. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Analgesia subdissociativa/infusão de dor aguda

Via: EV em BIC

Apresentação: 50 mg/mL; preferir diluição padronizada

Dose: 0,1–0,2 mg/kg bolus; 0,1–0,4 mg/kg/h

Máximo: máximo do protocolo especializado

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: Ex.: 50 mg/50 mL = 1 mg/mL; calcular mL/h pela dose

Monitorização: Dor, sedação, PA, FC, efeitos psicomiméticos

Cautelas: Prescrição por dor/anestesia/UTI; dupla checagem

Situação: Off-label: analgesia subdissociativa

Indicação 2: Indução em sequência rápida de intubação

Via: EV

Apresentação: 50 mg/mL

Dose: 1–2 mg/kg

Máximo: titular ao cenário; dose única

Intervalo: bolus lento

Preparo/administração: Pode usar pura; diluir para volumes muito pequenos conforme protocolo

Monitorização: PA, FC, SpO₂, ETCO₂; prontidão para via aérea

Cautelas: Não garante reflexos protetores; pode causar apneia/laringoespasma

Situação: Uso anestésico estabelecido

Indicação 3: Sedação dissociativa para procedimento

Via: EV

Apresentação: 50 mg/mL

Dose: 1–1,5 mg/kg inicial; 0,25–0,5 mg/kg de reforço

Máximo: 4,5 mg/kg total; >2,5 mg/kg aumenta eventos

Intervalo: reforços a cada 10 min

Preparo/administração: EV em 1–2 min; equipe e material de via aérea

Monitorização: Oximetria, ECG, observação contínua de via aérea

Cautelas: Considerar abortar se requerer >2,5 mg/kg

Situação: Uso consolidado; pode ser off-label conforme produto

Indicação 4: Sedação dissociativa sem acesso venoso

Via: IM

Apresentação: 50 mg/mL

Dose: 4 mg/kg inicial; reforço 2 mg/kg

Máximo: 6 mg/kg total

Intervalo: reforço após 10 min

Preparo/administração: IM profunda

Monitorização: Oximetria, ECG, observação de via aérea

Cautelas: Recuperação mais longa; risco de vômito/laringoespasma

Situação: Uso consolidado; pode ser off-label conforme produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.052 — Cetirizina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações

Situação: Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto

Indicação 2: Urticária — tratamento sintomático conforme idade

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações

Situação: Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.053 — Cetoconazol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via: Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância

Situação: Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.054 — Cetoprofeno

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dor inflamatória — uso selecionado conforme idade/bula

Via: VO

Apresentação: Solução oral 20 mg/mL

Dose: 1 mg/kg/dose

Máximo: máximo diário conforme idade e bula; arquivo-base cita 300 mg/dia

Intervalo: 8/8–12/12 h conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar concentração 20 mg/mL; medir com seringa

Monitorização: Dor, tolerância GI, hidratação e função renal quando pertinente

Cautelas: Evitar em desidratação, disfunção renal, sangramento GI, dengue e alergia a AINE

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.055 — Ciclesonida

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via: Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão

Situação: Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate

Indicação 2: Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via: Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão

Situação: Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.056 — Ciclopiroxolamina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via: Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância

Situação: Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.057 — Cimetidina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Doença ácido-péptica — uso selecionado

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar interações e função renal; não usar ranitidina disponível de origem não autorizada

Situação: Ranitidina permanece suspensa/retirada por risco de NDMA; não gerar dose

Indicação 2: Refluxo gastroesofágico — uso selecionado

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar interações e função renal; não usar ranitidina disponível de origem não autorizada

Situação: Ranitidina permanece suspensa/retirada por risco de NDMA; não gerar dose

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.058 — Cinchocaína

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dor/inflamação local — uso tópico conforme produto e idade

Via: Tópica/oromucosa/retal conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Evitar ingestão, uso em mucosa lesada extensa e formulação inadequada para a idade

Situação: Posologia por aplicação depende da formulação; não converter em mL

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.059 — Ciprofloxacina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.060 — Claritromicina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.061 — Clemastina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações

Situação: Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto

Indicação 2: Urticária — tratamento sintomático conforme idade

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações

Situação: Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.062 — Clindamicina

Linhas cadastradas: 5. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria sensível — gravidade moderada — opção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola brasileira 600 mg/4 mL = 150 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose = 30 mg/kg/dia

Máximo: máximo 600 mg (4 mL) por dose IM

Intervalo: 8/8 h

Preparo/administração: Usar sem diluição para administração IM; aplicar profundamente em grande massa muscular.

Monitorização: Resposta clínica, diarreia/colite por *C. difficile*, hemograma e função hepática em curso prolongado

Cautelas: Não usar para meningite. Em sepse, infecção necrosante, intra-abdominal/pélvica grave ou instabilidade, preferir EV e cobertura combinada apropriada.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; dose parenteral pediátrica dentro da faixa de bula

Indicação 2: Infecção dentária por bactéria sensível — gravidade moderada — opção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola brasileira 600 mg/4 mL = 150 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose = 30 mg/kg/dia

Máximo: máximo 600 mg (4 mL) por dose IM

Intervalo: 8/8 h

Preparo/administração: Usar sem diluição para administração IM; aplicar profundamente em grande massa muscular.

Monitorização: Resposta clínica, diarreia/colite por *C. difficile*, hemograma e função hepática em curso prolongado

Cautelas: Não usar para meningite. Em sepse, infecção necrosante, intra-abdominal/pélvica grave ou instabilidade, preferir EV e cobertura combinada apropriada.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; dose parenteral pediátrica dentro da faixa de bula

Indicação 3: Infecção osteoarticular ou toxina/necrosante

Via: EV

Apresentação: 150 mg/mL

Dose: 13 mg/kg/dose

Máximo: 900 mg/dose

Intervalo: a cada 8 h

Preparo/administração: Diluir; associar ao antimicrobiano definitivo quando supressão de toxina

Monitorização: Culturas, CK conforme síndrome, colite

Cautelas: Não usar monoterapia em choque toxigênico sem cobertura adequada

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 4: Infecção respiratória por bactéria sensível — gravidade moderada — opção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola brasileira 600 mg/4 mL = 150 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose = 30 mg/kg/dia

Máximo: máximo 600 mg (4 mL) por dose IM

Intervalo: 8/8 h

Preparo/administração: Usar sem diluição para administração IM; aplicar profundamente em grande massa muscular.

Monitorização: Resposta clínica, diarreia/colite por *C. difficile*, hemograma e função hepática em curso prolongado

Cautelas: Não usar para meningite. Em sepse, infecção necrosante, intra-abdominal/pélvica grave ou instabilidade, preferir EV e cobertura combinada apropriada.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; dose parenteral pediátrica dentro da faixa de bula

Indicação 5: Pele/tecidos moles, anaeróbios, infecção dentária

Via: EV

Apresentação: 600 mg/4 mL = 150 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose

Máximo: 600 mg/dose

Intervalo: a cada 8 h

Preparo/administração: Diluir e respeitar velocidade da bula

Monitorização: Diarreia/colite, função hepática

Cautelas: Sem ajuste renal rotineiro; ajustar contexto hepático

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.063 — Clioquinol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Uso anti-infeccioso intestinal/tópico histórico — confirmar papel atual

Via: VO ou tópica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar registro, formulação e alternativa com melhor evidência

Situação: Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por baixa padronização atual

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.064 — Clobazam

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica

Situação: Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.065 — Clonazepam

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica

Situação: Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.066 — Clonidina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Abstinência de opioide/sedativo — prevenção ou tratamento

Via: VO/enteral

Apresentação: Comprimido 0,1 mg = 100 mcg; solução oral 10 mcg/mL somente se padronizada pela farmácia

Dose: inicial 0,5–1 mcg/kg/dose a cada 6 h; usual 0,5–4 mcg/kg/dose a cada 4–6 h

Máximo: 4 mcg/kg/dose a cada 4 h

Intervalo: a cada 4–6 h; usar a menor dose eficaz

Preparo/administração: Usar solução 10 mcg/mL preparada/validada pela farmácia. Não improvisar solução à beira-leito sem dados de homogeneidade e estabilidade

Monitorização: PA, FC, sedação e escore de abstinência

Cautelas: Reter/reduzir se bradicardia ou hipotensão; retirar gradualmente em 1–2 semanas para evitar hipertensão rebote

Situação: Off-label pediátrico

Indicação 2: Transição/desmame de dexmedetomidina prolongada

Via: VO/enteral

Apresentação: Comprimido 0,1 mg = 100 mcg; solução oral 10 mcg/mL somente se padronizada pela farmácia

Dose: 1 mcg/kg/dose a cada 6 h foi o regime inicial mais frequente em protocolo publicado; individualizar

Máximo: não há conversão universal dexmedetomidina→clonidina

Intervalo: a cada 6 h durante a transição; desmame posterior protocolizado

Preparo/administração: Usar solução 10 mcg/mL validada; reduzir a dexmedetomidina somente conforme protocolo e resposta hemodinâmica

Monitorização: PA, FC, WAT-1/sinais de abstinência de agonista α_2

Cautelas: Bradicardia/hipotensão; não suspender clonidina abruptamente; maior evidência observacional

Situação: Off-label; protocolo institucional

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.067 — Cloperastina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Tosse seca intensa — uso excepcional após excluir causa tratável

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não usar em lactentes; revisar sedação, interação serotoninérgica e contraindicações específicas

Situação: Antitussígeno não rotineiro; resposta depende das restrições etárias e do benefício esperado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.068 — Cloranfenicol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.069 — Cloreto de potássio (KCl)

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Aditivo em manutenção após diurese estabelecida

Via: EV em solução de manutenção

Apresentação: 19,1% = 2,5 mEq/mL

Dose: 20 mEq/L usual; individualizar 0–40 mEq/L

Máximo: não adicionar se oligúria/IR/hipercalcemia

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: Retirar 4 mL da bolsa de 500 mL e adicionar 4 mL de KCl 19,1%

Monitorização: K, creatinina, diurese

Cautelas: Homogeneizar e rotular; bomba; dupla checagem

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 2: Reposição EV de hipocalcemia

Via: EV em BIC

Apresentação: 19,1% = 2,5 mEq/mL

Dose: 0,5–1 mEq/kg conforme gravidade

Máximo: velocidade usual <0,25 mEq/kg/h; nunca >0,5 mEq/kg/h; máx. 30 mEq/h

Intervalo: contínuo; reavaliar por ciclos

Preparo/administração: SEMPRE diluir; usual 20–40 mEq/L periférico; concentrações maiores só em protocolo

Monitorização: ECG, K seriado, função renal, acesso

Cautelas: Nunca IV direto; dupla checagem independente

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.070 — Cloreto de sódio 0,9%

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Choque/hipoperfusão — bolus

Via: EV/IO

Apresentação: Bolsa 100–500 mL

Dose: 10–20 mL/kg

Máximo: reavaliar antes de repetir

Intervalo: bolus em 5–20 min conforme choque

Preparo/administração: Solução pronta, aquecer se grande volume

Monitorização: Perfusão, PA, crepitações, hepatomegalia, diurese

Cautelas: Em sepse, reavaliar a cada bolus e interromper se sobrecarga

Situação: Diretriz pediátrica

Indicação 2: Manutenção pediátrica isotônica

Via: EV

Apresentação: Bolsa; preferir com dextrose e K apropriados

Dose: 100%: regra 4–2–1 mL/kg/h

Máximo: individualizar; frequentemente reduzir em risco de ADH

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: Combinar com dextrose e KCl apropriados; ver aba Soroterapia 100%

Monitorização: Na, glicemia, balanço, peso

Cautelas: Não usar fórmula automática em RN <28 d, DKA, IR, IC ou distúrbios do Na

Situação: Diretriz pediátrica ≥28 dias

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.071 — Cloroquina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via: VO ou tópica conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais

Situação: Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.072 — Clorpromazina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Indicação neurológica/sedativa especializada

Via: VO ou via hospitalar conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar depressão do SNC, QT, efeitos extrapiramidais e necessidade de monitorização cardiorrespiratória

Situação: Uso restrito/off-label conforme cenário; selecionar protocolo especializado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.073 — Clotrimazol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via: Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância

Situação: Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.074 — Codeína

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dor moderada/intensa — opção opioide selecionada por protocolo e idade

Via: VO, EV, IM ou transmucosa conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Monitorar ventilação/sedação; codeína e tramadol têm restrições importantes em menores de 12 anos e após adenoamigdalectomia

Situação: Uso restrito; resposta condicionada às contraindicações etárias e à variabilidade metabólica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.075 — Colagenase

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Desbridamento enzimático de lesão selecionada

Via: Tópica

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Proteger pele íntegra; confirmar indicação e curativo/protocolo de feridas

Situação: Aplicação depende da concentração, área e tipo de lesão; não calcular por peso

Indicação 2: Hidratação cutânea de lesão selecionada

Via: Tópica

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Proteger pele íntegra; confirmar indicação e curativo/protocolo de feridas

Situação: Aplicação depende da concentração, área e tipo de lesão; não calcular por peso

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.076 — Colchicina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Doença inflamatória/metabólica específica — uso especializado

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Janela terapêutica/interações relevantes; monitorar hemograma, função renal/hepática conforme fármaco

Situação: Dose e titulação dependem da doença e idade; não automatizada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.077 — Cromoglicato dissódico

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto

Via: Nasal ou oftálmica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima

Situação: Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL

Indicação 2: Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto

Via: Nasal ou oftálmica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima

Situação: Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.078 — Deflazacorte

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Doença inflamatória/alérgica específica — corticoide sistêmico ou tópico

Via: VO, IM, tópica ou intra-articular conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; avaliar duração, desmame e imunossupressão

Situação: Potência e equivalência variam; selecionar indicação e formulação antes de calcular

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.079 — Deltametrina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via: VO ou tópica conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais

Situação: Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.080 — Desloratadina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações

Situação: Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto

Indicação 2: Urticária — tratamento sintomático conforme idade

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações

Situação: Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.081 — Dexametasona

Linhas cadastradas: 3. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Crupe

Via: VO/IM/EV

Apresentação: 4 mg/mL

Dose: 0,6 mg/kg, dose única

Máximo: 12 mg no protocolo RCH; até 16 mg em outros protocolos

Intervalo: dose única

Preparo/administração: VO preferida se tolerada; EV/IM conforme gravidade

Monitorização: Estridor e esforço respiratório

Cautelas: Observar após adrenalina nebulizada; não atrasar manejo de via aérea

Situação: Diretriz pediátrica

Indicação 2: Exacerbação aguda de asma

Via: VO/EV/IM

Apresentação: 4 mg/mL

Dose: 0,6 mg/kg/dose

Máximo: 16 mg/dose

Intervalo: a cada 24 h por 1–2 doses

Preparo/administração: VO se possível

Monitorização: Resposta clínica, glicemia em risco

Cautelas: Não substitui broncodilatador; esquema local pode usar prednisolona

Situação: Diretriz pediátrica

Indicação 3: Meningite bacteriana — adjuvante selecionado

Via: EV

Apresentação: 4 mg/mL

Dose: 0,15 mg/kg/dose

Máximo: 10 mg/dose

Intervalo: a cada 6 h por 4 dias

Preparo/administração: Administrar antes ou com a primeira dose do antibiótico

Monitorização: Audição, evolução neurológica

Cautelas: Benefício depende de agente/epidemiologia; não iniciar tardiamente sem indicação

Situação: Uso por indicação específica; confirmar protocolo

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.082 — Dexmedetomidina

Linhas cadastradas: 5. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Sedação contínua em VM/pós-IOT

Via: EV em BIC

Apresentação: 200 mcg/2 mL = 100 mcg/mL; solução final padrão 4 mcg/mL

Dose: 0,2–1 mcg/kg/h; titular pela meta de sedação; evitar bolus em instabilidade

Máximo: até 2 mcg/kg/h apenas em protocolo especializado; usar a menor dose eficaz

Intervalo: contínuo; titular em incrementos conforme protocolo

Preparo/administração: Aspirar 2 mL (200 mcg) + 48 mL de SF 0,9% = 50 mL a 4 mcg/mL. mL/h = dose × peso ÷ 4

Monitorização: ECG, PA, SpO₂, perfusão e escala COMFORT-B/SBS; avaliar delirium/abstinência

Cautelas: Reduzir/titular cautelosamente na disfunção hepática; bradicardia, bloqueio AV, disfunção ventricular e hipovolemia; desmame após uso prolongado

Situação: Off-label pediátrico no Brasil; diretriz/uso em CTI

Indicação 2: Sedação de procedimento não invasivo — 1 mês a <2 anos

Via: EV em bomba

Apresentação: 200 mcg/2 mL = 100 mcg/mL; solução final 4 mcg/mL

Dose: carga 1,5 mcg/kg em 10 min; manutenção 0,5–1,5 mcg/kg/h (iniciar 1,5 e titular)

Máximo: 1,5 mcg/kg/h; não administrar carga rápida

Intervalo: carga em 10 min, seguida de infusão

Preparo/administração: 2 mL + 48 mL de SF 0,9% = 50 mL a 4 mcg/mL. Para a carga, programar mL/h = volume calculado × 6 durante 10 min

Monitorização: ECG, PA, SpO₂ e ventilação contínuas; capnografia conforme sedação; equipe de resgate de via aérea

Cautelas: Procedimento não doloroso; analgesia adicional se houver dor. Maior risco de bradicardia/hipotensão; reduzir na disfunção hepática

Situação: Aprovado nos EUA (bula 05/2026); off-label pediátrico no Brasil

Indicação 3: Sedação de procedimento não invasivo — 2 a <18 anos

Via: EV em bomba

Apresentação: 200 mcg/2 mL = 100 mcg/mL; solução final 4 mcg/mL

Dose: carga 2 mcg/kg em 10 min; manutenção 0,5–1,5 mcg/kg/h (iniciar 1,5 e titular)

Máximo: 1,5 mcg/kg/h; não administrar carga rápida

Intervalo: carga em 10 min, seguida de infusão

Preparo/administração: 2 mL + 48 mL de SF 0,9% = 50 mL a 4 mcg/mL. Para a carga, programar mL/h = volume calculado × 6 durante 10 min

Monitorização: ECG, PA, SpO₂ e ventilação contínuas; capnografia conforme sedação; equipe de resgate de via aérea

Cautelas: Procedimento não doloroso; analgesia adicional se houver dor. Maior risco de bradicardia/hipotensão; reduzir na disfunção hepática

Situação: Aprovado nos EUA (bula 05/2026); off-label pediátrico no Brasil

Indicação 4: Sedação para exame de imagem não doloroso (RM ou TC) sem acesso venoso — 1 mês a 10 anos

Via: IM profunda — off-label

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 200 mcg/2 mL = 100 mcg/mL; bula nacional aprova somente uso EV em adultos

Dose: 1–4 mcg/kg por aplicação IM no estudo; foram usadas aplicações únicas ou repetidas e a dose total média foi 2,4 mcg/kg para TC e 2,9 mcg/kg para RM

Máximo: sem máximo absoluto pediátrico validado; não repetir automaticamente e não extrapolar fora de protocolo formal de sedação

Intervalo: aplicação inicial; reavaliar sedação e hemodinâmica após 10–15 min (início médio no estudo: 13 min); qualquer nova aplicação exige protocolo institucional

Preparo/administração: Solução 100 mcg/mL sem diluição: 0,01–0,04 mL/kg/dose. Administrar profundamente em massa muscular adequada; documentar dose cumulativa.

Monitorização: Sedação formal: ECG, PA seriada, SpO₂ contínua e capnografia conforme profundidade; equipe e material de resgate de via aérea disponíveis

Cautelas: Não usar como analgesia exclusiva em procedimento doloroso. No estudo, 14% tiveram hipotensão transitória; cautela em hipovolemia, bradicardia, bloqueio AV e disfunção ventricular. Reduzir/titular com cautela na disfunção hepática.

Situação: Off-label pediátrico e off-label por via no Brasil; evidência observacional limitada (coorte retrospectiva de 65 crianças)

Indicação 5: Sedação/premedicação para procedimento não doloroso — via intranasal off-label, de 1 mês a <18 anos

Via: Intranasal com atomizador — off-label

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 200 mcg/2 mL = 100 mcg/mL; uso intranasal da solução injetável é off-label

Dose: 2–3 mcg/kg/dose IN; administrar 30–45 min antes quando usado como premedicação

Máximo: sem máximo absoluto pediátrico universal; volume preferencial ≤0,3 mL por narina por aplicação; não repetir automaticamente

Intervalo: dose única; reavaliar após 30 min conforme protocolo de sedação

Preparo/administração: Solução 100 mcg/mL sem diluição: 0,02–0,03 mL/kg. Dividir o volume entre as narinas; se exceder 0,3 mL por narina, fracionar conforme protocolo/dispositivo.

Monitorização: Sedação formal: ECG, PA seriada, SpO₂ contínua e capnografia conforme profundidade; equipe e material de resgate de via aérea disponíveis

Cautelas: Início mais lento e resposta variável; estímulo pode despertar o paciente. Bradicardia/hipotensão; cautela em hipovolemia, distúrbio de condução e disfunção ventricular/hepática. Analgesia adicional se o procedimento for doloroso.

Situação: Off-label pediátrico e off-label por via no Brasil; sustentado por revisão sistemática pediátrica e protocolos especializados

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.083 — Dextroclorofeniramina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações

Situação: Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto

Indicação 2: Urticária — tratamento sintomático conforme idade

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações

Situação: Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.084 — Dextrometorfano

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Tosse seca intensa — uso excepcional após excluir causa tratável

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não usar em lactentes; revisar sedação, interação serotoninérgica e contraindicações específicas

Situação: Antitussígeno não rotineiro; resposta depende das restrições etárias e do benefício esperado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.085 — Diazepam

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Estado de mal epiléptico com acesso EV

Via: EV

Apresentação: 5 mg/mL

Dose: 0,15–0,2 mg/kg

Máximo: 10 mg/dose

Intervalo: pode repetir uma vez conforme protocolo; máximo 2 benzodiazepínicos

Preparo/administração: EV lento; não misturar sem compatibilidade

Monitorização: FR, SpO₂, PA; ventilação disponível

Cautelas: Risco de depressão respiratória e hipotensão

Situação: Diretriz pediátrica

Indicação 2: Estado de mal sem acesso venoso

Via: Retal

Apresentação: Solução retal padronizada 5 mg/mL ou aplicador comercial

Dose: 0,5 mg/kg

Máximo: 20 mg/dose

Intervalo: dose de resgate; respeitar total de benzodiazepínicos

Preparo/administração: Cálculo válido apenas para solução retal 5 mg/mL. Se gel/aplicador pré-cheio, selecionar a dose comercial mais próxima conforme protocolo; não extrapolar ampola EV para via retal sem validação.

Monitorização: FR, SpO₂, nível de consciência

Cautelas: Via intranasal com ampola não deve ser presumida; usar produto/protocolo específico

Situação: Diretriz pediátrica; formulação retal apropriada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.086 — Dicicloverina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dor abdominal espasmódica — uso sintomático selecionado após excluir causa cirúrgica

Via: VO, IM ou EV conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Efeitos anticolinérgicos; evitar em glaucoma, retenção urinária, íleo e suspeita de obstrução

Situação: Dose e idade mínima variam por sal/apresentação; não intercambiar sais

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.087 — Diclofenaco (dietilamônio, potássico, sódico)

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dor/inflamação ou indicação especializada — uso condicionado à idade e ao diagnóstico

Via: VO, retal ou tópica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Evitar em desidratação, doença renal, sangramento GI e dengue; AAS não usar em virose salvo indicação específica

Situação: Resposta condicionada às restrições etárias e à indicação específica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.088 — Didanosina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Uso anti-infeccioso histórico — avaliar alternativa contemporânea

Via: Conforme produto histórico

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não utilizar com base apenas em manual antigo; confirmar registro, disponibilidade e protocolo especializado

Situação: Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por obsolescência ou ausência de papel atual rotineiro

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.089 — Digoxina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg

Situação: Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada

Indicação 2: Taquiarritmia supraventricular — controle/manutenção selecionada

Via: VO ou EV

Apresentação: Elixir 50 mcg/mL; confirmar produto e unidade

Dose: Selecionar regime por idade e cardiopediatria; diferenciar mcg de mg

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Monitorar ECG, K, Mg, função renal e nível quando indicado; múltiplas interações

Situação: Dose de ataque/manutenção varia por idade; selecionar o regime cardiopediátrico

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.090 — Dimenidrinato

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Náuseas/vômitos — uso selecionado após tratar a causa e avaliar risco de QT

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar QT, distonia/efeitos extrapiramidais, interações e distúrbios eletrolíticos

Situação: Não usar rotineiramente; dose/idade dependem do produto e da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.091 — Dimeticona

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Distensão/gases — alívio sintomático quando indicado

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Benefício variável; não mascara sinais de abdome agudo

Situação: Dose fixa por faixa etária e concentração do produto; não converter sem selecionar apresentação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.092 — Dipirona (metamizol)

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dor aguda

Via: VO/EV/IM

Apresentação: 500 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose

Máximo: respeitar máximo por peso/idade e bula do produto

Intervalo: a cada 6 h se necessário

Preparo/administração: EV lenta; diluir se protocolo exigir

Monitorização: PA na via EV; reação alérgica

Cautelas: Evitar em hipersensibilidade a pirazonas ou discrasia prévia

Situação: Uso pediátrico conforme protocolo brasileiro

Indicação 2: Febre com desconforto

Via: VO/EV/IM

Apresentação: 500 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose

Máximo: respeitar máximo por peso/idade e bula do produto

Intervalo: a cada 6 h se necessário

Preparo/administração: EV lenta; diluir se protocolo exigir

Monitorização: PA na via EV; reação alérgica

Cautelas: Evitar em hipersensibilidade a pirazonas ou discrasia prévia

Situação: Uso pediátrico conforme protocolo brasileiro

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.093 — Dobutamina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Choque com baixo débito/disfunção miocárdica

Via: EV/IO em BIC

Apresentação: Concentração padrão 1.000 mcg/mL (1 mg/mL)

Dose: 5–20 mcg/kg/min

Máximo: titular à perfusão e débito; máximo conforme protocolo

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: Preparar concentração final de 1 mg/mL conforme farmácia/protocolo; bomba e linha dedicada quando indicada

Monitorização: PA, ECG, perfusão, diurese, lactato e sítio do acesso

Cautelas: Alta vigilância; corrigir hipovolemia quando pertinente; pode causar taquiarritmia/hipotensão

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.094 — Domperidona

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Náuseas/vômitos — uso selecionado após tratar a causa e avaliar risco de QT

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar QT, distonia/efeitos extrapiramidais, interações e distúrbios eletrolíticos

Situação: Não usar rotineiramente; dose/idade dependem do produto e da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.095 — Dopamina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Choque com necessidade de suporte inotrópico/vasopressor — alternativa selecionada

Via: EV/IO em BIC

Apresentação: Concentração padrão 1.600 mcg/mL

Dose: 5–20 mcg/kg/min

Máximo: titular ao efeito; preferir agentes orientados pelo fenótipo do choque

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: Preparar 400 mg em volume final de 250 mL = 1.600 mcg/mL; confirmar protocolo/biblioteca

Monitorização: PA, ECG, perfusão, lactato, diurese e sítio periférico

Cautelas: Alta vigilância; arritmogênica; não usar 'dose renal'

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.096 — Dornase alfa

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Fibrose cística com secreção viscosa — manutenção inalatória

Via: Inalatória

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não misturar com outros fármacos no nebulizador; seguir equipe de fibrose cística

Situação: Dose fixa por ampola/dispositivo; uso especializado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.097 — Doxiciclina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.098 — Dropropizina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Tosse seca intensa — uso excepcional após excluir causa tratável

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não usar em lactentes; revisar sedação, interação serotoninérgica e contraindicações específicas

Situação: Antitussígeno não rotineiro; resposta depende das restrições etárias e do benefício esperado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.099 — Ebastina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações

Situação: Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto

Indicação 2: Urticária — tratamento sintomático conforme idade

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações

Situação: Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.100 — Emedastina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto

Via: Nasal ou oftálmica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima

Situação: Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL

Indicação 2: Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto

Via: Nasal ou oftálmica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima

Situação: Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.101 — Epinastina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto

Via: Nasal ou oftálmica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima

Situação: Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL

Indicação 2: Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto

Via: Nasal ou oftálmica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima

Situação: Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.102 — Erdosteína

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Secreção respiratória espessa — uso mucolítico apenas quando individualmente indicado

Via: VO ou inalatória conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Pode aumentar volume de secreções/broncoespasmo; contraindicações e idade mínima variam por produto

Situação: Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; resposta depende da idade e apresentação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.103 — Eritromicina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.104 — Escopolamina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dor abdominal espasmódica — uso sintomático selecionado após excluir causa cirúrgica

Via: VO, IM ou EV conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Efeitos anticolinérgicos; evitar em glaucoma, retenção urinária, íleo e suspeita de obstrução

Situação: Dose e idade mínima variam por sal/apresentação; não intercambiar sais

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.105 — Esmolol

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Emergência hipertensiva com indicação de beta-bloqueio

Via: EV em BIC

Apresentação: 10 mg/mL

Dose: bolus 100–500 mcg/kg; depois 100–500 mcg/kg/min

Máximo: 1.000 mcg/kg/min

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: Bomba e monitorização contínua

Monitorização: PA e ECG

Cautelas: Escolha depende da etiologia; evitar em asma/IC descompensada

Situação: Off-label pediátrico

Indicação 2: Taquiarritmia supraventricular/controle de frequência

Via: EV em BIC

Apresentação: 10 mg/mL

Dose: bolus 100–500 mcg/kg; depois 100–500 mcg/kg/min

Máximo: 1.000 mcg/kg/min

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: Diluição padronizada; bomba

Monitorização: ECG, PA contínua, perfusão

Cautelas: Evitar em choque, BAV, IC descompensada e broncoespasmo grave

Situação: Off-label pediátrico

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.106 — Espiramicina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.107 — Espironolactona

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg

Situação: Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.108 — Etofamida

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Uso anti-infeccioso intestinal/tópico histórico — confirmar papel atual

Via: VO ou tópica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar registro, formulação e alternativa com melhor evidência

Situação: Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por baixa padronização atual

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.109 — Etomidato

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Indução para intubação

Via: EV

Apresentação: 2 mg/mL

Dose: 0,2–0,3 mg/kg

Máximo: dose única

Intervalo: bolus

Preparo/administração: Puro ou diluição mínima conforme protocolo

Monitorização: PA, mioclonias, ventilação

Cautelas: Evitar em sepse/choque séptico pediátrico quando houver alternativa

Situação: Uso anestésico; pediatria depende da bula

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.110 — Fenitoína

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Estado de mal epiléptico — carga

Via: EV

Apresentação: 50 mg/mL

Dose: 20 mg/kg

Máximo: 1,5 g

Intervalo: dose de carga

Preparo/administração: Somente SF 0,9%; infundir em 20 min; filtro conforme protocolo

Monitorização: ECG e PA contínuos

Cautelas: Não diluir em glicose; máx. 1 mg/kg/min e 50 mg/min

Situação: Diretriz pediátrica

Indicação 2: Manutenção após carga

Via: EV/VO

Apresentação: Solução injetável/oral de referência 50 mg/mL

Dose: 5–8 mg/kg/dia divididos

Máximo: 300–400 mg/dia usual adulto

Intervalo: a cada 8–12 h

Preparo/administração: Volume diário calculado a 50 mg/mL. Dividir em 2–3 tomadas conforme intervalo e via; para EV, usar somente diluente/linha compatíveis e monitorização.

Monitorização: Nível sérico, albumina, ECG se EV

Cautelas: Interações múltiplas; ajustar hepático e níveis

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.111 — Fenobarbital

Linhas cadastradas: 3. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Convulsão neonatal — carga

Via: EV

Apresentação: 100 mg/mL

Dose: 20 mg/kg; adicionais 10 mg/kg

Máximo: 40 mg/kg total em muitos protocolos

Intervalo: conforme resposta

Preparo/administração: Aplicar protocolo neonatal; infusão lenta

Monitorização: EEG se disponível, FR, PA

Cautelas: Intervalo e manutenção dependem de IG/idade pós-natal

Situação: Uso neonatal estabelecido

Indicação 2: Estado de mal epiléptico — segunda linha

Via: EV

Apresentação: 200 mg/2 mL = 100 mg/mL

Dose: 20 mg/kg

Máximo: 1 g

Intervalo: dose de carga

Preparo/administração: Diluir/infundir conforme bula; máx. 1 mg/kg/min

Monitorização: FR, SpO₂, PA, sedação

Cautelas: Ventilação disponível; somar sedação de benzodiazepínicos

Situação: Diretriz pediátrica

Indicação 3: Manutenção anticonvulsivante

Via: EV/VO

Apresentação: Ampola 100 mg/mL; diluição operacional 10 mg/mL

Dose: 3–5 mg/kg/dia

Máximo: individualizar por nível

Intervalo: 1–2 vezes/dia

Preparo/administração: Diluição operacional 1:10: 1 mL (100 mg) + 9 mL de diluente compatível = 10 mg/mL. Preparar/usar segundo farmácia, bula e protocolo de estabilidade.

Monitorização: Nível sérico, sedação, função hepática

Cautelas: Ajustar por níveis e função hepática/renal

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.112 — Fenoterol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Broncoespasmo agudo — alternativa beta-2 agonista conforme protocolo

Via: Inalatória ou EV conforme cenário

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Monitorar FC, K, glicemia e lactato em doses repetidas/infusão; preferir protocolo de asma

Situação: Selecionar formulação, via e faixa etária antes do cálculo

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.113 — Fentanila

Linhas cadastradas: 4. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Analgesia aguda EV

Via: EV

Apresentação: 50 mcg/mL

Dose: 0,5–2 mcg/kg/dose

Máximo: 100 mcg/dose de referência; titular

Intervalo: a cada 30–60 min conforme resposta

Preparo/administração: EV lento em 3–5 min

Monitorização: FR, SpO₂, PA, sedação

Cautelas: Bolus rápido/dose alta pode causar rigidez torácica

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 2: Analgesia intranasal sem acesso venoso (≥12 meses)

Via: Intranasal

Apresentação: Ideal 300 mcg/mL; ampola 50 mcg/mL limita volume

Dose: 1,5 mcg/kg inicial; 0,75–1,5 mcg/kg de resgate

Máximo: 100 mcg; usual 75 mcg se solução diluída

Intervalo: reavaliar em 5–10 min

Preparo/administração: Atomizador; dividir entre narinas

Monitorização: FR, SpO₂, sedação e dor

Cautelas: Evitar <12 meses, alteração de consciência ou obstrução/epistaxe bilateral

Situação: Off-label: via intranasal

Indicação 3: Analgesia/sedação contínua pós-IOT

Via: EV em BIC

Apresentação: 50 mcg/mL; concentração padronizada

Dose: 0,5–4 mcg/kg/h; titular

Máximo: até 10 mcg/kg/h em protocolos especializados

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: Ex.: 500 mcg em 50 mL = 10 mcg/mL; mL/h = dose×peso/10

Monitorização: Sedação, dor, FR, PA; abstinência em uso prolongado

Cautelas: Dupla checagem de mcg e bomba

Situação: Off-label pediátrico conforme produto

Indicação 4: Sequência rápida de intubação/atenuação de resposta

Via: EV

Apresentação: 50 mcg/mL

Dose: 1–2 mcg/kg

Máximo: individualizar

Intervalo: dose única, lenta

Preparo/administração: Administrar lentamente antes da laringoscopia se hemodinamicamente adequado

Monitorização: PA, FC, FR, rigidez torácica

Cautelas: Não é agente de indução isolado; risco de hipotensão/bradicardia

Situação: Off-label por contexto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.114 — Fexofenadina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações

Situação: Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto

Indicação 2: Urticária — tratamento sintomático conforme idade

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações

Situação: Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.115 — Fitomenadiona (Vitamina K)

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Profilaxia da deficiência de vitamina K no recém-nascido

Via: IM, VO ou EV conforme indicação/protocolo

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Via EV exige administração lenta e monitorização; confirmar produto e concentração

Situação: Dose depende de profilaxia versus sangramento e faixa de peso; não automatizada nesta linha

Indicação 2: Tratamento da deficiência de vitamina K no recém-nascido

Via: IM, VO ou EV conforme indicação/protocolo

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Via EV exige administração lenta e monitorização; confirmar produto e concentração

Situação: Dose depende de profilaxia versus sangramento e faixa de peso; não automatizada nesta linha

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.116 — Fluconazol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Candidíase invasiva — tratamento

Via: VO ou EV

Apresentação: Solução oral 10 mg/mL ou solução EV 2 mg/mL

Dose: 6-12 mg/kg/dose conforme foco e gravidade

Máximo: máximo 800 mg/dia no arquivo-base; confirmar protocolo

Intervalo: 24/24 h

Preparo/administração: A saída calcula para solução oral 10 mg/mL; para EV 2 mg/mL multiplicar o volume por 5

Monitorização: Função hepática, QT/interações, culturas e resposta

Cautelas: Ajustar na disfunção renal; confirmar espécie/sensibilidade

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.117 — Flumazenil

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Reversão selecionada de sedação por benzodiazepínico

Via: EV

Apresentação: 0,1 mg/mL

Dose: 0,01 mg/kg

Máximo: máximo inicial 0,2 mg; redosagem e máximo cumulativo conforme protocolo

Intervalo: reavaliar após 1 min; efeito pode ser mais curto que o benzodiazepínico

Preparo/administração: Administrar lentamente; manter suporte ventilatório

Monitorização: Ventilação, consciência, ECG e recorrência de sedação

Cautelas: Evitar em uso crônico de benzodiazepínico, epilepsia tratada ou intoxicação mista pró-convulsivante

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.118 — Fluticasona

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via: Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão

Situação: Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate

Indicação 2: Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via: Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão

Situação: Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.119 — Formoterol

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via: Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão

Situação: Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate

Indicação 2: Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via: Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão

Situação: Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.120 — Furazolidona

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Uso anti-infeccioso histórico — avaliar alternativa contemporânea

Via: Conforme produto histórico

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não utilizar com base apenas em manual antigo; confirmar registro, disponibilidade e protocolo especializado

Situação: Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por obsolescência ou ausência de papel atual rotineiro

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.121 — Furosemida

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infusão contínua em refratariedade

Via: EV em BIC

Apresentação: Padrão de infusão 2 mg/mL

Dose: 0,05–0,4 mg/kg/h; iniciar 0,05 mg/kg/h e titular

Máximo: confirmar protocolo de UTI

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: Padrão 2 mg/mL: 10 mL de furosemida 10 mg/mL e completar para 50 mL com diluente compatível. Proteger compatibilidades e usar bomba.

Monitorização: Diurese horária, eletrólitos, PA

Cautelas: Avaliar resistência diurética e perfusão renal

Situação: Off-label pediátrico

Indicação 2: Sobrecarga volêmica/edema

Via: EV

Apresentação: 10 mg/mL

Dose: 1 mg/kg/dose; pode chegar a 2 mg/kg em refratariedade

Máximo: 40 mg/dose inicial de referência; individualizar

Intervalo: a cada 12–24 h conforme resposta

Preparo/administração: EV em ≥ 5 min; pode diluir

Monitorização: Diurese, PA, Na, K, Mg, creatinina

Cautelas: Corrigir hipovolemia; risco de ototoxicidade com administração rápida

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.122 — Gentamicina

Linhas cadastradas: 9. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Bacteremia ou sepse por bactéria sensível — opção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)

Dose: 2–2,5 mg/kg/dose

Máximo: individualizar por idade, função renal e níveis séricos

Intervalo: 8/8 h

Preparo/administração: Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular

Cautelas: Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.

Situação: Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional

Indicação 2: Infecção de pele, osso ou tecidos moles por bactéria sensível — opção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)

Dose: 2–2,5 mg/kg/dose

Máximo: individualizar por idade, função renal e níveis séricos

Intervalo: 8/8 h

Preparo/administração: Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular

Cautelas: Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.

Situação: Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional

Indicação 3: Infecção do sistema nervoso central por bactéria sensível — em associação apropriada — opção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)

Dose: 2–2,5 mg/kg/dose

Máximo: individualizar por idade, função renal e níveis séricos

Intervalo: 8/8 h

Preparo/administração: Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular

Cautelas: Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.

Situação: Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional

Indicação 4: Infecção gastrointestinal por bactéria sensível — opção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)

Dose: 2–2,5 mg/kg/dose

Máximo: individualizar por idade, função renal e níveis séricos

Intervalo: 8/8 h

Preparo/administração: Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular

Cautelas: Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.

Situação: Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional

Indicação 5: Infecção grave por Gram-negativo — dose estendida

Via: EV

Apresentação: 40 mg/mL

Dose: 5–7,5 mg/kg/dose

Máximo: máximo e intervalo dependem de idade, função renal e protocolo de níveis

Intervalo: geralmente 24/24 h fora do período neonatal; individualizar

Preparo/administração: Aspirar volume calculado e diluir conforme protocolo; infundir em 30–60 min

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis quando indicados, ototoxicidade

Cautelas: Ajustar intervalo na disfunção renal; neonatos exigem esquema específico

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Indicação 6: Infecção intra-abdominal ou peritonite por bactéria sensível — opção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)

Dose: 2–2,5 mg/kg/dose

Máximo: individualizar por idade, função renal e níveis séricos

Intervalo: 8/8 h

Preparo/administração: Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular

Cautelas: Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.

Situação: Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional

Indicação 7: Infecção renal ou geniturinária por bactéria sensível — opção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)

Dose: 2–2,5 mg/kg/dose

Máximo: individualizar por idade, função renal e níveis séricos

Intervalo: 8/8 h

Preparo/administração: Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular

Cautelas: Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.

Situação: Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional

Indicação 8: Infecção respiratória por bactéria sensível — opção IM

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)

Dose: 2–2,5 mg/kg/dose

Máximo: individualizar por idade, função renal e níveis séricos

Intervalo: 8/8 h

Preparo/administração: Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular

Cautelas: Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.

Situação: Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional

Indicação 9: Seps neonatal por bactéria sensível — opção IM no recém-nascido com até 1 semana

Via: IM profunda

Apresentação: Ampola pediátrica brasileira 20 mg/mL ou 40 mg/mL; cálculo exibido para 20 mg/mL

Dose: 2,5–3 mg/kg/dose

Máximo: ajustar por idade gestacional, função renal e níveis séricos

Intervalo: 12/12 h

Preparo/administração: Aspirar a dose da solução 20 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.

Monitorização: Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular

Cautelas: Em seps/choque, a via EV costuma ser preferida. Confirmar apresentação 20 mg/mL antes de usar o volume calculado.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema para prematuro/RN com até 1 semana

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.123 — Glucametacina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dor/inflamação ou indicação especializada — uso condicionado à idade e ao diagnóstico

Via: VO, retal ou tópica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Evitar em desidratação, doença renal, sangramento GI e dengue; AAS não usar em virose salvo indicação específica

Situação: Resposta condicionada às restrições etárias e à indicação específica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.124 — Gluconato de cálcio

Linhas cadastradas: 3. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Hipercalemia com alteração no ECG

Via: EV

Apresentação: 10% = 100 mg/mL

Dose: 50-100 mg/kg

Máximo: 10-20 mL conforme protocolo; repetir se ECG persistir

Intervalo: em 5-10 min se instável

Preparo/administração: Pode usar 10% não diluído em situação ameaçadora à vida

Monitorização: ECG contínuo, acesso e extravasamento

Cautelas: Não reduz K; estabiliza membrana. Não misturar com bicarbonato/fosfato

Situação: Diretriz pediátrica

Indicação 2: Hipocalcemia sintomática

Via: EV

Apresentação: 10% = 100 mg/mL

Dose: 50-200 mg/kg

Máximo: conforme protocolo e cálcio iônico

Intervalo: em 10-20 min

Preparo/administração: Diluir para 50 mg/mL quando estável

Monitorização: ECG, Ca iônico, sítio

Cautelas: Extravasamento causa necrose; acesso central preferível em alta concentração

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 3: Intoxicação por bloqueador de canal de cálcio/hipermagnesemia

Via: EV

Apresentação: 10%

Dose: 0,6-1 mL/kg

Máximo: repetição depende de ECG/hemodinâmica e toxicologia

Intervalo: conforme resposta

Preparo/administração: Consultar CIATox; bomba se infusão

Monitorização: ECG, Ca iônico, PA

Cautelas: Necessita protocolo toxicológico específico

Situação: Off-label por indicação toxicológica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.125 — Gramicidina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Indicação 2: Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.126 — Granisetrona

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Náuseas/vômitos — uso selecionado após tratar a causa e avaliar risco de QT

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar QT, distonia/efeitos extrapiramidais, interações e distúrbios eletrolíticos

Situação: Não usar rotineiramente; dose/idade dependem do produto e da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.127 — Griseofulvina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via: Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância

Situação: Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.128 — Haloperidol

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Agitação psicomotora grave

Via: IM/VO

Apresentação: 5 mg/mL

Dose: 0,05–0,1 mg/kg/dose

Máximo: 5 mg/dose

Intervalo: reavaliar; não repetir antes do intervalo do protocolo

Preparo/administração: Desescalada é primeira linha; IM profunda; evitar EV

Monitorização: ECG/QT, PA, distonia, sedação

Cautelas: Evitar em QT longo e toxíndromes anticolinérgica/simpaticomimética; considerar agente preferido do protocolo local

Situação: Off-label pediátrico

Indicação 2: Delirium hiperativo em UTI

Via: EV/IM/VO conforme protocolo

Apresentação: 5 mg/mL; preferir diluição para dose pequena

Dose: 0,01–0,05 mg/kg/dose

Máximo: 2 mg inicialmente; limite institucional

Intervalo: a cada 6–8 h se necessário

Preparo/administração: Usar concentração que permita medir; protocolo de delirium

Monitorização: ECG/QT, eletrólitos, sintomas extrapiramidais

Cautelas: Tratar causa do delirium; não usar rotineiramente sem avaliação especializada

Situação: Off-label pediátrico; evidência limitada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.129 — Hidralazina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Emergência hipertensiva

Via: EV

Apresentação: 20 mg/mL

Dose: 0,1–0,2 mg/kg/dose

Máximo: 0,6 mg/kg/dose

Intervalo: a cada 4–6 h conforme protocolo/resposta

Preparo/administração: Administrar em 3–5 min ou infusão intermitente conforme protocolo

Monitorização: PA frequente, FC, sintomas neurológicos

Cautelas: Resposta imprevisível; evitar queda excessiva; preferir agente titulável quando possível

Situação: Off-label pediátrico

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.130 — Hidrato de cloral

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Indicação neurológica/sedativa especializada

Via: VO ou via hospitalar conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar depressão do SNC, QT, efeitos extrapiramidais e necessidade de monitorização cardiorrespiratória

Situação: Uso restrito/off-label conforme cenário; selecionar protocolo especializado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.131 — Hidroclorotiazida

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg

Situação: Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.132 — Hidrocortisona

Linhas cadastradas: 3. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Asma grave sem tolerância VO

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola 100 mg; diluição de trabalho 10 mg/mL

Dose: 4 mg/kg/dose

Máximo: 100 mg/dose

Intervalo: a cada 6 h

Preparo/administração: Reconstituir 100 mg conforme sistema/bula (solução 50 mg/mL). Para 10 mg/mL: 1 mL = 50 mg + 4 mL de SF 0,9%/SG 5%. Confirmar produto e estabilidade.

Monitorização: Glicemia, PA, resposta

Cautelas: Migrar para VO quando possível

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 2: Choque refratário com suspeita de insuficiência adrenal

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola 100 mg; diluição de trabalho 10 mg/mL

Dose: 1-2 mg/kg/dose inicial

Máximo: seguir protocolo de UTI

Intervalo: conforme protocolo

Preparo/administração: Reconstituir 100 mg conforme sistema/bula (solução 50 mg/mL). Para 10 mg/mL: 1 mL = 50 mg + 4 mL de SF 0,9%/SG 5%. Confirmar produto e estabilidade.

Monitorização: PA, glicemia, eletrólitos

Cautelas: Usar se suspeita/documentação de insuficiência adrenal ou protocolo de choque refratário

Situação: Uso selecionado em diretriz

Indicação 3: Crise adrenal

Via: EV/IM

Apresentação: Frasco-ampola 100 mg; diluição de trabalho 10 mg/mL

Dose: 2 mg/kg IV/IM (máx. 100 mg) OU dose por faixa etária do protocolo

Máximo: 100 mg inicial

Intervalo: seguido de reposição dividida/contínua

Preparo/administração: Reconstituir 100 mg conforme sistema/bula (solução 50 mg/mL). Para 10 mg/mL: 1 mL = 50 mg + 4 mL de SF 0,9%/SG 5%. Confirmar produto e estabilidade.

Monitorização: PA, glicemia, Na, K

Cautelas: Superfície corporal exige altura; não estimar sem altura

Situação: Diretriz pediátrica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.133 — Hidroxicloroquina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Doença reumatológica pediátrica — tratamento modificador

Via: VO

Apresentação: Comprimidos; manipulação pode ser necessária conforme peso

Dose: Não automatizada sem protocolo reumatológico e apresentação definida

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Monitorar retina, QT/interações e função renal/hepática conforme risco

Situação: Uso especializado; dose e máximo dependem do peso real e diagnóstico

Indicação 2: Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via: VO ou tópica conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais

Situação: Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.134 — Hidroxiquinolina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Uso anti-infeccioso intestinal/tópico histórico — confirmar papel atual

Via: VO ou tópica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar registro, formulação e alternativa com melhor evidência

Situação: Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por baixa padronização atual

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.135 — Hidroxizina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações

Situação: Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto

Indicação 2: Urticária — tratamento sintomático conforme idade

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações

Situação: Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.136 — Hidróxido de alumínio + magnésio

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dispepsia/refluxo — uso eventual

Via: VO

Apresentação: Suspensão oral — concentração varia por marca

Dose: NÃO padronizar em mL/kg sem produto e idade

Máximo: ≥12 anos: seguir bula do produto; <12 anos: avaliação médica

Intervalo: uso curto

Preparo/administração: Não há uma concentração universal segura para conversão automática. Registrar a concentração do produto antes de prescrever.

Monitorização: Sintomas, Mg/Al se uso repetido

Cautelas: Evitar em insuficiência renal; não usar 1–2 mL/kg como regra geral

Situação: Dados pediátricos e formulações variáveis

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.137 — Hioscina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dor abdominal espasmódica — uso sintomático selecionado após excluir causa cirúrgica

Via: VO, IM ou EV conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Efeitos anticolinérgicos; evitar em glaucoma, retenção urinária, íleo e suspeita de obstrução

Situação: Dose e idade mínima variam por sal/apresentação; não intercambiar sais

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.138 — Ibuprofeno

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dor aguda — criança hidratada

Via: VO

Apresentação: Gotas 100 mg/mL

Dose: 5–10 mg/kg/dose

Máximo: máximo 40 mg/kg/dia; máximo absoluto conforme idade/bula

Intervalo: 6/6–8/8 h se necessário

Preparo/administração: Confirmar que o frasco é 100 mg/mL; medir em mL com seringa

Monitorização: Dor/febre, hidratação, tolerância GI, diurese

Cautelas: Evitar em desidratação, disfunção renal, sangramento GI, suspeita de dengue e alergia a AINE

Situação: Uso pediátrico; respeitar idade/peso mínimos da bula

Indicação 2: Febre com desconforto — criança hidratada

Via: VO

Apresentação: Gotas 100 mg/mL

Dose: 5–10 mg/kg/dose

Máximo: máximo 40 mg/kg/dia; máximo absoluto conforme idade/bula

Intervalo: 6/6–8/8 h se necessário

Preparo/administração: Confirmar que o frasco é 100 mg/mL; medir em mL com seringa

Monitorização: Dor/febre, hidratação, tolerância GI, diurese

Cautelas: Evitar em desidratação, disfunção renal, sangramento GI, suspeita de dengue e alergia a AINE

Situação: Uso pediátrico; respeitar idade/peso mínimos da bula

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.139 — Idoxuridina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Uso anti-infeccioso histórico — avaliar alternativa contemporânea

Via: Conforme produto histórico

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não utilizar com base apenas em manual antigo; confirmar registro, disponibilidade e protocolo especializado

Situação: Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por obsolescência ou ausência de papel atual rotineiro

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.140 — Imipenem / cilastatina sódica

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.141 — Indometacina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Persistência do canal arterial em prematuros — fechamento farmacológico

Via: EV

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Avaliar função renal, plaquetas, perfusão intestinal/cerebral e contraindicações

Situação: Dose depende de idade pós-natal e protocolo neonatal específico

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.142 — Ipratrópio brometo

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Crise asmática moderada/grave — primeiras doses

Via: Nebulização

Apresentação: 0,25 mg/mL

Dose: <20 kg: 0,25 mg; ≥20 kg: 0,5 mg

Máximo: 0,5 mg/dose

Intervalo: a cada 20 min por 3 doses; protocolos graves até 2 h

Preparo/administração: Associar a salbutamol; completar volume conforme nebulizador

Monitorização: FC, esforço, SpO₂

Cautelas: Sem benefício como monoterapia de manutenção

Situação: Diretriz pediátrica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.143 — Isoniazida

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.144 — Ivermectina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via: VO ou tópica conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais

Situação: Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.145 — Ketodex (cetamina + dexmedetomidina)

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Sedoanalgesia procedural dolorosa — estratégia 1:1 protocolar

Via: EV lenta em bomba

Apresentação: Cetamina 50 mg/mL + dexmedetomidina 100 mcg/mL

Dose: cetamina 1 mg/kg + dexmedetomidina 1 mcg/kg em 10 min

Máximo: sem máximo universal; NÃO repetir automaticamente a combinação

Intervalo: dose inicial; reavaliar em 10–15 min

Preparo/administração: Se premix institucional for validado: cetamina 100 mg (2 mL) + dexmedetomidina 100 mcg (1 mL) + SF 0,9% 17 mL = 20 mL; finais 5 mg/mL + 5 mcg/mL. Administrar 0,2 mL/kg em 10 min. Caso contrário, preparar separadamente

Monitorização: Sedação formal: ECG, PA a cada 5 min, SpO₂ e capnografia contínuas; O₂, aspiração e material de via aérea disponíveis

Cautelas: Não existe formulação comercial/premix universal. Bradicardia/hipotensão, secreções, vômitos e laringoespasmo; não presumir ausência de depressão respiratória

Situação: Off-label; estratégia sem padronização universal

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.146 — Labetalol

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Emergência hipertensiva — bolus

Via: EV

Apresentação: 5 mg/mL

Dose: 0,2–1 mg/kg/dose

Máximo: 40 mg/dose

Intervalo: a cada 10 min conforme resposta

Preparo/administração: EV lento

Monitorização: PA contínua/frequente, FC, perfusão

Cautelas: Evitar em asma, bradicardia, BAV e IC descompensada

Situação: Off-label pediátrico

Indicação 2: Emergência hipertensiva — infusão

Via: EV em BIC

Apresentação: Solução 5 mg/mL; concentração usual de infusão 5 mg/mL

Dose: 0,25–1 mg/kg/h; titular

Máximo: 3 mg/kg/h

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: Usar 5 mg/mL sem diluição adicional quando compatível com protocolo/equipamento; bomba e monitorização contínua.

Monitorização: PA e ECG contínuos

Cautelas: Mesmas contraindicações do bolus

Situação: Off-label pediátrico

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.147 — Lactulose

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Constipação funcional — desimpactação

Via: VO ou retal conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias

Situação: Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação

Indicação 2: Constipação funcional — manutenção

Via: VO ou retal conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias

Situação: Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.148 — Lamotrigina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica

Situação: Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.149 — Lanatosídeo C

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg

Situação: Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.150 — Levocabastina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto

Via: Nasal ou oftálmica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima

Situação: Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL

Indicação 2: Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto

Via: Nasal ou oftálmica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima

Situação: Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.151 — Levodropropizina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Tosse seca intensa — uso excepcional após excluir causa tratável

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não usar em lactentes; revisar sedação, interação serotoninérgica e contraindicações específicas

Situação: Antitussígeno não rotineiro; resposta depende das restrições etárias e do benefício esperado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.152 — Levofloxacinina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.153 — Levotiroxina sódica

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Terapia endócrina de reposição — acompanhamento especializado

Via: VO ou SC conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não calcular superfície corporal sem altura; monitorar crescimento e exames específicos

Situação: Dose individualizada por idade, diagnóstico, alvo laboratorial e, às vezes, superfície corporal

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.154 — Lidocaína

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: FV/TV sem pulso refratária — alternativa antiarrítmica

Via: EV/IO

Apresentação: 20 mg/mL (2%) sem vasoconstritor

Dose: 1 mg/kg

Máximo: máximo 100 mg no bolus inicial; manutenção conforme PALS/protocolo

Intervalo: bolus

Preparo/administração: Confirmar concentração e ausência de vasoconstritor; administrar conforme algoritmo

Monitorização: ECG, pressão, perfusão e sinais de toxicidade neurológica

Cautelas: Alta vigilância; dose cumulativa e hepatopatia alteram risco de toxicidade

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.155 — Lincomicina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.156 — Linezolida

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.157 — Lodoxamida

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto

Via: Nasal ou oftálmica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima

Situação: Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL

Indicação 2: Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto

Via: Nasal ou oftálmica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima

Situação: Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.158 — Loratadina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações

Situação: Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto

Indicação 2: Urticária — tratamento sintomático conforme idade

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações

Situação: Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.159 — Manitol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Hipertensão intracraniana/edema cerebral — terapia hiperosmolar selecionada

Via: EV

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Monitorar osmolaridade, Na, função renal, volemia e risco de hipotensão/rebote

Situação: Dose e concentração dependem do cenário e de protocolo neurocrítico

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.160 — Mebendazol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via: VO ou tópica conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais

Situação: Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.161 — Meropenem

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção grave por Gram-negativo/ESBL sem meningite

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola 500 mg; solução de trabalho 50 mg/mL

Dose: 20 mg/kg/dose

Máximo: máximo 1 g/dose nesta indicação; confirmar protocolo

Intervalo: 8/8 h; infusão usual 15-30 min ou prolongada conforme protocolo

Preparo/administração: Reconstituir e diluir conforme bula/farmácia; concentração exibida 50 mg/mL

Monitorização: Função renal, resposta clínica, culturas, neurotoxicidade

Cautelas: Ajustar função renal; reservar conforme epidemiologia/antibiograma

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Indicação 2: Meningite bacteriana ou infecção do SNC por agente sensível

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola 500 mg; solução de trabalho 50 mg/mL

Dose: 40 mg/kg/dose

Máximo: máximo 2 g/dose; confirmar faixa etária/protocolo

Intervalo: 8/8 h

Preparo/administração: Reconstituir e diluir conforme bula/farmácia; concentração exibida 50 mg/mL

Monitorização: Função renal, culturas, avaliação neurológica e resposta clínica

Cautelas: Ajustar função renal; risco de convulsões, sobretudo em predisposição

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.162 — Metoclopramida

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Migrânea com náusea

Via: EV

Apresentação: 5 mg/mL

Dose: 0,1–0,15 mg/kg

Máximo: 10 mg

Intervalo: dose única; reavaliar

Preparo/administração: Diluir e infundir lentamente

Monitorização: Acatisia/distonia

Cautelas: Considerar tratamento de reação extrapiramidal; ≥ 1 ano

Situação: Off-label pediátrico

Indicação 2: Náusea/vômito — segunda linha em ≥ 1 ano

Via: EV/IM/VO

Apresentação: 5 mg/mL

Dose: 0,1–0,15 mg/kg/dose

Máximo: 10 mg/dose; 0,5 mg/kg/dia

Intervalo: até 3 vezes/dia

Preparo/administração: EV lento ≥ 3 min

Monitorização: Distonia/acatisia, sedação

Cautelas: Contraindicada < 1 ano; uso curto; evitar em obstrução, Parkinsonismo e epilepsia descompensada

Situação: Uso pediátrico restrito

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.163 — Metronidazol

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção anaeróbia intra-abdominal grave

Via: EV

Apresentação: Bolsa 5 mg/mL

Dose: 30 mg/kg/dia divididos 8/8 h = 10 mg/kg/dose

Máximo: máximo 4 g/dia no arquivo-base; confirmar foco

Intervalo: 8/8 h

Preparo/administração: Solução pronta 5 mg/mL; infundir conforme bula/protocolo

Monitorização: Resposta clínica, função hepática em curso prolongado, neurotoxicidade

Cautelas: Ajustar em hepatopatia grave; revisar interações

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Indicação 2: Infecção odontogênica com componente anaeróbio — adjuvante quando indicado

Via: EV

Apresentação: Bolsa 5 mg/mL

Dose: 30 mg/kg/dia divididos 8/8 h = 10 mg/kg/dose

Máximo: máximo 4 g/dia no arquivo-base; confirmar foco

Intervalo: 8/8 h

Preparo/administração: Solução pronta 5 mg/mL; infundir conforme bula/protocolo

Monitorização: Resposta clínica, função hepática em curso prolongado, neurotoxicidade

Cautelas: Ajustar em hepatopatia grave; revisar interações

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.164 — Midazolam

Linhas cadastradas: 5. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Estado de mal com acesso EV/IO

Via: EV/IO

Apresentação: 5 mg/mL

Dose: 0,15 mg/kg

Máximo: 10 mg/dose

Intervalo: pode repetir uma vez; máximo 2 doses de benzodiazepínico

Preparo/administração: EV lento; ventilação disponível

Monitorização: FR, SpO₂, PA, nível de consciência

Cautelas: Somar doses pré-hospitalares

Situação: Diretriz pediátrica

Indicação 2: Estado de mal sem acesso — bucal/intranasal

Via: Bucal/IN

Apresentação: 5 mg/mL

Dose: bucal 0,3 mg/kg; IN 0,2–0,3 mg/kg

Máximo: 10 mg

Intervalo: dose de resgate; respeitar máximo de benzodiazepínicos

Preparo/administração: Atomizador na IN; dividir narinas

Monitorização: FR, SpO₂, PA

Cautelas: Volume nasal pode limitar; preferir formulação concentrada

Situação: Off-label: via com solução injetável; diretriz aceita

Indicação 3: Estado de mal sem acesso — IM

Via: IM

Apresentação: 5 mg/mL

Dose: 0,2 mg/kg

Máximo: 10 mg

Intervalo: dose de resgate

Preparo/administração: IM profunda

Monitorização: FR, SpO₂, PA

Cautelas: Não atrasar segunda linha após 2 benzodiazepínicos

Situação: Diretriz pediátrica

Indicação 4: Sedação contínua pós-IOT

Via: EV em BIC

Apresentação: 5 mg/mL; diluição padronizada

Dose: 0,025–0,12 mg/kg/h; faixa ampliada até 0,5 mg/kg/h em UTI

Máximo: titular por escala de sedação

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: Ex.: 50 mg em 50 mL = 1 mg/mL; mL/h = dose×peso

Monitorização: Sedação, PA, FR; delirium/abstinência

Cautelas: Acúmulo em insuficiência hepática/renal; dupla checagem

Situação: Off-label pediátrico conforme duração/contexto

Indicação 5: Sedação de procedimento

Via: EV

Apresentação: 5 mg/mL; preferir diluição 1 mg/mL

Dose: 0,025–0,1 mg/kg inicial conforme idade; titular

Máximo: 6 mg (6m–5a) ou 10 mg (6–12a) em referência CHEO

Intervalo: incrementos após ≥ 2 –3 min

Preparo/administração: Diluir para 1 mg/mL para titulação

Monitorização: FR, SpO₂, PA; capnografia se sedação moderada/profunda

Cautelas: Não fornece analgesia; combinar aumenta depressão respiratória

Situação: Uso pediátrico em bula; faixa etária específica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.165 — Mometasona

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via: Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão

Situação: Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate

Indicação 2: Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via: Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão

Situação: Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.166 — Monossulfiram

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via: VO ou tópica conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais

Situação: Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.167 — Montelukaste sódico

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via: Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão

Situação: Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate

Indicação 2: Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via: Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão

Situação: Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.168 — Morfina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Analgesia contínua pós-operatória/CTI

Via: EV em BIC

Apresentação: 10 mg/mL; concentração padronizada

Dose: 0,01–0,04 mg/kg/h

Máximo: titular por dor/sedação

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: Ex.: 50 mg em 50 mL = 1 mg/mL

Monitorização: FR, PA, sedação, íleo, abstinência

Cautelas: Não usar como terapia rotineira do edema agudo de pulmão pediátrico

Situação: Off-label pediátrico conforme contexto

Indicação 2: Dor intensa — bolus

Via: EV/IM/SC

Apresentação: 10 mg/mL; diluir para 1 mg/mL

Dose: 0,05–0,1 mg/kg/dose

Máximo: 5 mg/dose inicial de referência

Intervalo: a cada 2–4 h; titular

Preparo/administração: 1 mL (10 mg) + 9 mL SF = 1 mg/mL

Monitorização: FR, SpO₂, PA, sedação, dor

Cautelas: Reduzir em hipovolemia; ajustar em disfunção renal

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.169 — Moxifloxacina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.170 — Mupirocina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Indicação 2: Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.171 — N-acetil aspartilglutamato de sódio

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto

Via: Nasal ou oftálmica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima

Situação: Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL

Indicação 2: Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto

Via: Nasal ou oftálmica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima

Situação: Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.172 — Naloxona

Linhas cadastradas: 3. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Depressão respiratória iatrogênica por opioide — reversão titulada

Via: EV/IM

Apresentação: 0,4 mg/mL

Dose: 1–5 mcg/kg; escalar para 10 mcg/kg

Máximo: 100–400 mcg conforme resposta

Intervalo: a cada 2–3 min

Preparo/administração: Diluir 0,4 mg para 10 mL = 0,04 mg/mL para titulação

Monitorização: Ventilação, consciência, dor, abstinência

Cautelas: Objetivo é ventilação, não despertar completo em usuário crônico

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 2: Overdose aguda com apneia/coma

Via: EV/IM/IN conforme produto/protocolo

Apresentação: 0,4 mg/mL

Dose: 0,1 mg/kg

Máximo: 2 mg/dose

Intervalo: repetir a cada 2–3 min

Preparo/administração: Priorizar ventilação; solução pode ser usada pura

Monitorização: FR, SpO₂, consciência

Cautelas: Observar recorrência; meia-vida menor que muitos opioides

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 3: Recorrência de toxicidade — infusão

Via: EV em BIC

Apresentação: Infusão de referência 100 mcg/mL

Dose: usual 24–40 mcg/kg/h; alternativamente $\approx 2/3$ do bolus efetivo de despertar por hora

Máximo: titular à ventilação

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: 100 mcg/mL: 2 mg (5 mL de 0,4 mg/mL) + 15 mL de diluente = 20 mL. Titular à ventilação e ao menor grau de reversão necessário.

Monitorização: FR, consciência, abstinência

Cautelas: Consultar toxicologia; bolus de resgate pode ser necessário

Situação: Off-label: infusão contínua

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.173 — Naproxeno

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Artrite em crianças ≥ 2 anos — uso selecionado

Via: VO

Apresentação: Suspensão 25 mg/mL

Dose: 5–7 mg/kg/dose

Máximo: máximo 500 mg/dose no arquivo-base; confirmar indicação

Intervalo: 12/12 h

Preparo/administração: Confirmar apresentação 25 mg/mL; agitar e medir com seringa

Monitorização: Dor/inflamação, tolerância GI, função renal e hidratação

Cautelas: Evitar em desidratação, doença renal, sangramento GI, dengue e alergia a AINE

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Indicação 2: Dor inflamatória em crianças ≥ 2 anos — uso selecionado

Via: VO

Apresentação: Suspensão 25 mg/mL

Dose: 5–7 mg/kg/dose

Máximo: máximo 500 mg/dose no arquivo-base; confirmar indicação

Intervalo: 12/12 h

Preparo/administração: Confirmar apresentação 25 mg/mL; agitar e medir com seringa

Monitorização: Dor/inflamação, tolerância GI, função renal e hidratação

Cautelas: Evitar em desidratação, doença renal, sangramento GI, dengue e alergia a AINE

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.174 — Nedocromil sódico

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto

Via: Nasal ou oftálmica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima

Situação: Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL

Indicação 2: Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto

Via: Nasal ou oftálmica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima

Situação: Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.175 — Neomicina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Indicação 2: Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.176 — Nifedipina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg

Situação: Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.177 — Nimesulida

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dor/inflamação ou indicação especializada — uso condicionado à idade e ao diagnóstico

Via: VO, retal ou tópica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Evitar em desidratação, doença renal, sangramento GI e dengue; AAS não usar em virose salvo indicação específica

Situação: Resposta condicionada às restrições etárias e à indicação específica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.178 — Nimorazol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via: VO ou tópica conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais

Situação: Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.179 — Nistatina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via: Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância

Situação: Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.180 — Nitrofurantoína

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.181 — Nitroglicerina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Edema pulmonar cardiogênico/insuficiência cardíaca com hipertensão

Via: EV em BIC

Apresentação: Padrão de infusão 200 mcg/mL

Dose: 0,25–0,5 mcg/kg/min inicial; titular até 5 mcg/kg/min

Máximo: 20 mcg/kg/min

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: Preparar em concentração final de 200 mcg/mL conforme produto/protocolo; usar frasco/equipos compatíveis e bomba.

Monitorização: PA contínua, perfusão, metemoglobina em altas doses

Cautelas: Contraíndicada com inibidor PDE5 recente e hipotensão

Situação: Off-label pediátrico

Indicação 2: Isquemia miocárdica no adolescente com hipertensão

Via: EV em BIC

Apresentação: Padrão de infusão 200 mcg/mL

Dose: 0,25–0,5 mcg/kg/min; titular

Máximo: 20 mcg/kg/min; protocolo cardiologia

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: Preparar em concentração final de 200 mcg/mL conforme produto/protocolo; usar frasco/equipos compatíveis e bomba.

Monitorização: PA, ECG, dor

Cautelas: Excluir uso de PDE5 e infarto de VD

Situação: Off-label pediátrico

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraíndicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.182 — Nitroprussiato de sódio

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Emergência hipertensiva

Via: EV em BIC

Apresentação: Padrão de infusão 200 mcg/mL

Dose: 0,3–0,5 mcg/kg/min inicial; titular 0,5–8 mcg/kg/min

Máximo: 10 mcg/kg/min apenas por curto período em protocolos

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: 200 mcg/mL: 10 mg (0,4 mL de 25 mg/mL) + 49,6 mL de SG 5% = 50 mL. Proteger da luz; linha dedicada.

Monitorização: PA invasiva se possível, lactato/acidose; tiocianato em uso prolongado

Cautelas: Risco de cianeto/tiocianato, maior em IR/IH e altas doses

Situação: Uso pediátrico especializado

Indicação 2: Insuficiência cardíaca com pós-carga elevada

Via: EV em BIC

Apresentação: Padrão de infusão 200 mcg/mL

Dose: 0,3–5 mcg/kg/min

Máximo: titular à hemodinâmica

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: 200 mcg/mL: 10 mg + diluente SG 5% até 50 mL. Proteger da luz; linha dedicada e monitorização invasiva quando indicada.

Monitorização: PA, perfusão, lactato

Cautelas: UTI/cardiologia; monitorar toxicidade

Situação: Off-label por contexto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.183 — Noradrenalina (norepinefrina)

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Anafilaxia refratária com vasoplegia apesar de adrenalina

Via: EV em BIC

Apresentação: Padrão de infusão 16 mcg/mL

Dose: 0,05 mcg/kg/min; titular

Máximo: protocolo de UTI

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: 16 mcg/mL: 4 mg em volume final de 250 mL. Bomba; central preferível, acesso periférico apenas com vigilância do sítio.

Monitorização: PA contínua, ECG, perfusão

Cautelas: Especialista/UTI; tratar causas reversíveis

Situação: Off-label; resgate especializado

Indicação 2: Choque vasoplégico/distributivo

Via: EV/IO em BIC

Apresentação: Padrão de infusão 16 mcg/mL

Dose: iniciar 0,05 mcg/kg/min; faixa 0,01–0,4 mcg/kg/min

Máximo: 1 mcg/kg/min de referência; maior só protocolo especializado

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: 16 mcg/mL: 4 mg em volume final de 250 mL. Bomba/biblioteca; dupla checagem de mcg versus mg.

Monitorização: PA, perfusão, lactato, diurese, sítio

Cautelas: Dupla checagem de mcg/min e extravasamento

Situação: Diretriz pediátrica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.184 — Olopatadina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto

Via: Nasal ou oftálmica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima

Situação: Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL

Indicação 2: Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto

Via: Nasal ou oftálmica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima

Situação: Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.185 — Omeprazol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Úlcera péptica/erosiva sem hemorragia maciça

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola 40 mg; 4 mg/mL reconstituído; 0,4 mg/mL final

Dose: 0,5 mg/kg/dose

Máximo: 2 mg/kg/dia; limite institucional

Intervalo: a cada 12–24 h

Preparo/administração: Reconstituir 40 mg com 10 mL de SF 0,9% = 4 mg/mL. Aspirar a dose e diluir para 0,4 mg/mL; infundir em 30 min.

Monitorização: Sintomas, Mg se prolongado

Cautelas: Migrar para VO assim que possível; experiência EV pediátrica limitada

Situação: Off-label EV em pediatria conforme produto/local

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.186 — Ondansetrona

Linhas cadastradas: 3. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Gastroenterite com vômitos — facilitar SRO

Via: VO

Apresentação: Solução 2 mg/mL; VO 4/8 mg

Dose: 0,15 mg/kg, dose única; alternativa: 8–15 kg 2 mg, 15–30 kg 4 mg, >30 kg 8 mg

Máximo: 8 mg

Intervalo: dose única

Preparo/administração: Preferir comprimido/solução oral

Monitorização: Hidratação; QT se fatores de risco

Cautelas: Aplicável tipicamente 6 meses–12 anos; não prescrever rotineiramente múltiplas doses para casa

Situação: Off-label para gastroenterite

Indicação 2: Náusea por quimioterapia

Via: EV/VO

Apresentação: 2 mg/mL

Dose: 0,15–0,2 mg/kg/dose

Máximo: protocolo oncológico prevalece

Intervalo: primeira dose antes da quimioterapia; até 3 doses/24 h

Preparo/administração: Infundir conforme bula

Monitorização: QT, função hepática

Cautelas: Seguir protocolo oncológico específico

Situação: Uso pediátrico em bula/protocolo oncológico

Indicação 3: Náusea/vômito pós-operatório

Via: EV

Apresentação: 2 mg/mL

Dose: 0,1 mg/kg

Máximo: 4 mg

Intervalo: dose; repetir conforme protocolo

Preparo/administração: EV lento

Monitorização: QT, eletrólitos em risco

Cautelas: Cautela em QT longo e hepatopatia grave

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.187 — Oxacilina

Linhas cadastradas: 6. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção grave por MSSA sem SNC

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola 1 g; padrão operacional 100 mg/mL

Dose: 50 mg/kg/dose

Máximo: 2 g/dose; 12 g/dia

Intervalo: a cada 6 h

Preparo/administração: Reconstituir para 100 mg/mL; aspirar a dose e realizar diluição 1:5 para concentração final de 20 mg/mL, conforme protocolo/compatibilidade.

Monitorização: Culturas, função hepática/renal, neutropenia

Cautelas: Ajustar se disfunção hepática e renal concomitante

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 2: Infecção leve a moderada de vias aéreas superiores por estafilococo sensível — opção IM, <40 kg

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 500 mg; adicionar 2,7 mL de água para injetáveis → cerca de 500 mg/3 mL = 166,7 mg/mL

Dose: 12,5 mg/kg/dose = 50 mg/kg/dia

Máximo: máximo 500 mg (3 mL) por dose nesta linha

Intervalo: 6/6 h

Preparo/administração: Adicionar 2,7 mL de água para injetáveis, agitar até solução límpida e aplicar profundamente em grande massa muscular.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função hepática/renal e hemograma em curso prolongado

Cautelas: Não misturar com aminoglicosídeos. Infecção grave, disseminada, SNC, endocardite ou osteomielite exige avaliação para esquema EV.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; linha IM restrita a infecção leve/moderada selecionada

Indicação 3: Infecção leve a moderada de vias aéreas superiores por estafilococo sensível — opção IM, ≥40 kg

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 500 mg; adicionar 2,7 mL de água para injetáveis → cerca de 500 mg/3 mL = 166,7 mg/mL

Dose: 250–500 mg/dose

Máximo: máximo 500 mg (3 mL) por dose nesta linha

Intervalo: 4/4–6/6 h conforme gravidade

Preparo/administração: Adicionar 2,7 mL de água para injetáveis, agitar até solução límpida e aspirar 1,5–3 mL.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função hepática/renal e hemograma em curso prolongado

Cautelas: Não misturar com aminoglicosídeos. Infecção grave, disseminada, SNC, endocardite ou osteomielite exige avaliação para esquema EV.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; linha IM restrita a infecção leve/moderada selecionada

Indicação 4: Infecção localizada de pele ou tecidos moles por estafilococo sensível — opção IM, <40 kg

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 500 mg; adicionar 2,7 mL de água para injetáveis → cerca de 500 mg/3 mL = 166,7 mg/mL

Dose: 12,5 mg/kg/dose = 50 mg/kg/dia

Máximo: máximo 500 mg (3 mL) por dose nesta linha

Intervalo: 6/6 h

Preparo/administração: Adicionar 2,7 mL de água para injetáveis, agitar até solução límpida e aplicar profundamente em grande massa muscular.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função hepática/renal e hemograma em curso prolongado

Cautelas: Não misturar com aminoglicosídeos. Infecção grave, disseminada, SNC, endocardite ou osteomielite exige avaliação para esquema EV.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; linha IM restrita a infecção leve/moderada selecionada

Indicação 5: Infecção localizada de pele ou tecidos moles por estafilococo sensível — opção IM, ≥40 kg

Via: IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 500 mg; adicionar 2,7 mL de água para injetáveis → cerca de 500 mg/3 mL = 166,7 mg/mL

Dose: 250–500 mg/dose

Máximo: máximo 500 mg (3 mL) por dose nesta linha

Intervalo: 4/4–6/6 h conforme gravidade

Preparo/administração: Adicionar 2,7 mL de água para injetáveis, agitar até solução límpida e aspirar 1,5–3 mL.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, função hepática/renal e hemograma em curso prolongado

Cautelas: Não misturar com aminoglicosídeos. Infecção grave, disseminada, SNC, endocardite ou osteomielite exige avaliação para esquema EV.

Situação: Apresentação brasileira IM/EV; linha IM restrita a infecção leve/moderada selecionada

Indicação 6: Meningite por MSSA

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola 1 g; padrão operacional 100 mg/mL

Dose: 50 mg/kg/dose

Máximo: 2 g/dose; 12 g/dia

Intervalo: a cada 4 h

Preparo/administração: Reconstituir para 100 mg/mL; aspirar a dose e realizar diluição 1:5 para concentração final de 20 mg/mL, conforme protocolo/compatibilidade.

Monitorização: LCR/culturas, função hepática

Cautelas: Infectologia; ajustar conforme sensibilidade

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.188 — Oxcarbazepina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica

Situação: Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.189 — Oxiconazol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via: Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância

Situação: Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.190 — Oxitetraciclina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Indicação 2: Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.191 — Pantoprazol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Hemorragia digestiva alta — terapia acidossupressora inicial

Via: EV

Apresentação: Frasco-ampola 40 mg; 4 mg/mL reconstituído; 0,8 mg/mL final

Dose: 1 mg/kg, dose inicial

Máximo: 80 mg/dose

Intervalo: dose única inicial; sequência por gastro/protocolo

Preparo/administração: Reconstituir 40 mg com 10 mL de SF 0,9% = 4 mg/mL. Para doses pediátricas/infusão, diluir a 0,8 mg/mL.

Monitorização: Hemodinâmica, Hb, endoscopia

Cautelas: Estabilização e controle da fonte são prioritários; acionar gastro/cirurgia

Situação: Off-label pediátrico

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.192 — Paracetamol (acetaminofeno)

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dor aguda

Via: VO

Apresentação: Solução 100 mg/mL

Dose: 10-15 mg/kg/dose

Máximo: 75 mg/kg/dia após termo; usar 60 mg/kg/dia como limite conservador institucional

Intervalo: a cada 4-6 h

Preparo/administração: Sem diluição; seringa oral

Monitorização: Dose total de todas as associações

Cautelas: Reduzir em hepatopatia/desnutrição; não exceder máximo do produto

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 2: Febre com desconforto

Via: VO

Apresentação: Solução 100 mg/mL

Dose: 10-15 mg/kg/dose

Máximo: 75 mg/kg/dia após termo; usar 60 mg/kg/dia como limite conservador institucional

Intervalo: a cada 4-6 h

Preparo/administração: Sem diluição; seringa oral

Monitorização: Dose total de todas as associações

Cautelas: Reduzir em hepatopatia/desnutrição; não exceder máximo do produto

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.193 — Penicilamina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Doença inflamatória/metabólica específica — uso especializado

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Janela terapêutica/interações relevantes; monitorar hemograma, função renal/hepática conforme fármaco

Situação: Dose e titulação dependem da doença e idade; não automatizada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.194 — Penicilina (benzatina, G, V)

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar sal/formulação conforme síndrome

Via: VO, IM ou EV conforme sal

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, sal, concentração e via; penicilina benzatina nunca EV

Situação: Não intercambiar benzatina, procaína, cristalina ou penicilina V; linhas específicas originais foram preservadas

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.195 — Penicilina G benzatina

Linhas cadastradas: 3. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Faringoamigdalite estreptocócica

Via: IM profunda

Apresentação: Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI/4 mL ou 1.200.000 UI/4 mL

Dose: <27 kg: 600.000 UI; ≥27 kg: 1.200.000 UI

Máximo: 1.200.000 UI

Intervalo: dose única

Preparo/administração: IM profunda exclusivamente. Usar o frasco correspondente ao peso: <27 kg, 600.000 UI/4 mL; ≥27 kg, 1.200.000 UI/4 mL. A reconstituição varia por fabricante.

Monitorização: Anafilaxia, dor local

Cautelas: Não intercambiar com procaína ou cristalina

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 2: Sífilis adquirida — esquema selecionado

Via: IM profunda

Apresentação: Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI/4 mL = 300.000 UI/mL

Dose: 50.000 UI/kg/dose

Máximo: 2.400.000 UI/dose

Intervalo: dose única ou semanal ×3 conforme estágio

Preparo/administração: Usar apresentação final 1.200.000 UI/4 mL; IM profunda, nunca EV. Para 2.400.000 UI, dividir 8 mL em dois sítios conforme protocolo.

Monitorização: Sorologia e seguimento

Cautelas: Não usar combinações benzatina/procaína; excluir neurosífilis

Situação: Uso pediátrico estabelecido; esquema depende do estágio

Indicação 3: Sífilis congênita — esquema selecionado

Via: IM profunda

Apresentação: Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI/4 mL = 300.000 UI/mL

Dose: 50.000 UI/kg/dose

Máximo: 2.400.000 UI/dose

Intervalo: dose única ou semanal ×3 conforme estágio

Preparo/administração: Usar apresentação final 1.200.000 UI/4 mL; IM profunda, nunca EV. Para 2.400.000 UI, dividir 8 mL em dois sítios conforme protocolo.

Monitorização: Sorologia e seguimento

Cautelas: Não usar combinações benzatina/procaína; excluir neurosífilis

Situação: Uso pediátrico estabelecido; esquema depende do estágio

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.196 — Penicilina G cristalina

Linhas cadastradas: 4. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Endocardite por agente sensível

Via: EV

Apresentação: Frasco 5.000.000 UI; 1.000.000 UI/mL reconstituído

Dose: 400.000 UI/kg/dia divididas a cada 4 h

Máximo: 4 milhões UI/dose

Intervalo: a cada 4 h

Preparo/administração: Reconstituir para 1.000.000 UI/mL conforme bula/protocolo; depois diluir 1:10 para solução de trabalho 100.000 UI/mL.

Monitorização: Culturas, LCR, eletrólitos, função renal

Cautelas: Ajustar em IR; infectologia

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 2: Infecção grave sem meningite

Via: EV

Apresentação: Frasco 5.000.000 UI; 1.000.000 UI/mL reconstituído

Dose: 200.000 UI/kg/dia divididas a cada 4 h

Máximo: 4 milhões UI/dose

Intervalo: a cada 4 h

Preparo/administração: Reconstituir 5.000.000 UI com 3,2 mL do diluente indicado para volume final aproximado de 5 mL = 1.000.000 UI/mL; depois diluir 1:10 para 100.000 UI/mL.

Monitorização: Culturas, função renal, Na/K conforme sal

Cautelas: Ajustar em insuficiência renal

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 3: Meningite por agente sensível

Via: EV

Apresentação: Frasco 5.000.000 UI; 1.000.000 UI/mL reconstituído

Dose: 400.000 UI/kg/dia divididas a cada 4 h

Máximo: 4 milhões UI/dose

Intervalo: a cada 4 h

Preparo/administração: Reconstituir para 1.000.000 UI/mL conforme bula/protocolo; depois diluir 1:10 para solução de trabalho 100.000 UI/mL.

Monitorização: Culturas, LCR, eletrólitos, função renal

Cautelas: Ajustar em IR; infectologia

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 4: Sífilis congênita

Via: EV

Apresentação: Frasco 5.000.000 UI; 1.000.000 UI/mL reconstituído

Dose: 50.000 UI/kg/dose

Máximo: —

Intervalo: RN: a cada 12 h nos 7 primeiros dias e 8 h depois; total 10 dias

Preparo/administração: Reconstituir para 1.000.000 UI/mL conforme bula/protocolo; diluição de trabalho 1:10 = 100.000 UI/mL.

Monitorização: Clínica, LCR, sorologia

Cautelas: Intervalo neonatal é idade-dependente

Situação: Diretriz pediátrica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.197 — Penicilina G procaína

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Sífilis congênita — alternativa específica

Via: IM

Apresentação: Penicilina G procaína 600.000 UI/mL, suspensão IM

Dose: 50.000 UI/kg/dose

Máximo: 2.400.000 UI/dose

Intervalo: a cada 24 h por 10 dias

Preparo/administração: Usar somente a apresentação específica 600.000 UI/mL, IM profunda; nunca EV. Não intercambiar com benzatina ou cristalina.

Monitorização: Sorologia, clínica

Cautelas: Não intercambiar com benzatina/cristalina; confirmar disponibilidade local

Situação: Diretriz pediátrica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.198 — Permetrina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via: VO ou tópica conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais

Situação: Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.199 — Petidina (Meperidina)

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dor moderada/intensa — opção opioide selecionada por protocolo e idade

Via: VO, EV, IM ou transmucosa conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Monitorar ventilação/sedação; codeína e tramadol têm restrições importantes em menores de 12 anos e após adenoamigdalectomia

Situação: Uso restrito; resposta condicionada às contraindicações etárias e à variabilidade metabólica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.200 — Picossulfato sódico

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Constipação funcional — desimpactação

Via: VO ou retal conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias

Situação: Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação

Indicação 2: Constipação funcional — manutenção

Via: VO ou retal conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias

Situação: Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.201 — Pimetixeno

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações

Situação: Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto

Indicação 2: Urticária — tratamento sintomático conforme idade

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações

Situação: Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.202 — Pipazetato

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Tosse seca intensa — uso excepcional após excluir causa tratável

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não usar em lactentes; revisar sedação, interação serotoninérgica e contraindicações específicas

Situação: Antitussígeno não rotineiro; resposta depende das restrições etárias e do benefício esperado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.203 — Pirantel (Pamoato)

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via: VO ou tópica conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais

Situação: Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.204 — Pirimetamina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via: VO ou tópica conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais

Situação: Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.205 — Pirvínio (Pamoato)

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via: VO ou tópica conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais

Situação: Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.206 — Polimixina B

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Indicação 2: Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.207 — Prednisolona

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Exacerbação de asma moderada/grave

Via: VO

Apresentação: Solução oral 3 mg/mL

Dose: 1-2 mg/kg/dia

Máximo: máximo 40-50 mg/dia conforme diretriz/protocolo

Intervalo: 1 vez/dia por curso curto conforme gravidade

Preparo/administração: Medir com seringa oral; confirmar concentração 3 mg/mL

Monitorização: Resposta respiratória, glicemia/PA quando pertinente

Cautelas: Não usar rotineiramente em bronquiolite ou IVAS viral sem indicação

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.208 — Prednisona

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Exacerbação de asma moderada/grave — alternativa à prednisolona

Via: VO

Apresentação: Comprimidos 5 ou 20 mg; cálculo exibido em mg, não mL

Dose: 1–2 mg/kg/dia

Máximo: máximo 40–50 mg/dia conforme protocolo

Intervalo: 1 vez/dia por curso curto

Preparo/administração: Selecionar combinação de comprimidos compatível; não converter em mL sem suspensão definida

Monitorização: Resposta respiratória e eventos adversos

Cautelas: Linha calcula mg totais; confirmar formulação e capacidade de deglutição

Situação: Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.209 — Prometazina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Náusea/vômito — uso excepcional em ≥ 2 anos

Via: IM/VO

Apresentação: 25 mg/mL

Dose: 0,25–0,5 mg/kg/dose

Máximo: 25 mg/dose

Intervalo: a cada 6–8 h

Preparo/administração: Evitar EV pelo risco de lesão tecidual grave

Monitorização: Sedação e FR

Cautelas: Preferir antieméticos com melhor perfil; contraindicada <2 anos

Situação: Uso pediátrico restrito

Indicação 2: Reação alérgica/prurido — alternativa em ≥ 2 anos

Via: IM/VO

Apresentação: 25 mg/mL

Dose: 0,25 mg/kg/dose

Máximo: 25 mg/dose

Intervalo: a cada 4–6 h se necessário

Preparo/administração: Preferir VO; se injetável, seguir bula e protocolo de segurança

Monitorização: Sedação, FR, efeitos anticolinérgicos

Cautelas: Contraindicada <2 anos; risco de depressão respiratória; não substitui adrenalina na anafilaxia

Situação: Uso pediátrico restrito

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.210 — Propranolol

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Sintomas adrenérgicos em tireotoxicose

Via: VO

Apresentação: Solução oral 20 mg/5 mL = 4 mg/mL

Dose: 2 mg/kg/dia divididos

Máximo: individualizar com especialista

Intervalo: a cada 6–12 h

Preparo/administração: Usar solução oral comercial 4 mg/mL; medir com seringa oral. Não substituir por Hemangeol sem recalculer a concentração.

Monitorização: FC, PA, glicemia

Cautelas: Evitar em asma/IC; tratar causa

Situação: Off-label pediátrico

Indicação 2: Taquiarritmia supraventricular — manutenção

Via: VO

Apresentação: Solução oral 20 mg/5 mL = 4 mg/mL

Dose: 1–5 mg/kg/dia divididos

Máximo: 5 mg/kg/dia

Intervalo: a cada 6–8 h

Preparo/administração: Usar solução oral comercial 4 mg/mL; medir com seringa oral e titular com FC/PA/glicemia.

Monitorização: FC, PA, glicemia em lactentes

Cautelas: Evitar em asma, choque, BAV; não é tratamento inicial da TSV instável

Situação: Off-label pediátrico conforme indicação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.211 — Ranitidina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Doença ácido-péptica — uso selecionado

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar interações e função renal; não usar ranitidina disponível de origem não autorizada

Situação: Ranitidina permanece suspensa/retirada por risco de NDMA; não gerar dose

Indicação 2: Refluxo gastroesofágico — uso selecionado

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar interações e função renal; não usar ranitidina disponível de origem não autorizada

Situação: Ranitidina permanece suspensa/retirada por risco de NDMA; não gerar dose

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.212 — Rifampicina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.213 — Roxitromicina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.214 — *Saccharomyces boulardii*

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Diarreia aguda — adjuvante cepa-específico, quando indicado

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Evitar em imunossupressão grave, paciente crítico ou com cateter venoso central pelo risco de fungemia

Situação: Benefício depende de cepa/dose; não substitui reidratação oral

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.215 — Salbutamol — inalador

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Crise asmática leve/moderada

Via: Inalatória com espaçador

Apresentação: Inalador dosimetrado 100 mcg/jato

Dose: 4–10 jatos por dose conforme gravidade/idade

Máximo: 10 jatos por ciclo inicial em muitos protocolos

Intervalo: a cada 20 min na primeira hora; reavaliar

Preparo/administração: Usar espaçador; a unidade operacional é jato, não mL.

Monitorização: FC, tremor, SpO₂, resposta

Cautelas: SABA não deve ser único tratamento crônico; associar corticoide conforme crise

Situação: Diretriz pediátrica

Indicação 2: Resgate de broncoespasmo

Via: Inalatória

Apresentação: Inalador dosimetrado 100 mcg/jato

Dose: 1–2 jatos

Máximo: avaliar controle se uso frequente

Intervalo: a cada 4 h se necessário por curto período

Preparo/administração: Usar espaçador; a unidade operacional é jato, não mL.

Monitorização: Sintomas e uso de resgate

Cautelas: Uso repetido indica controle inadequado

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.216 — Salbutamol — nebulização

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Crise asmática moderada/grave

Via: Nebulização

Apresentação: 5 mg/mL (0,5%)

Dose: 0,15 mg/kg/dose; mínimo 2,5 mg

Máximo: 5 mg/dose

Intervalo: a cada 20 min por 3 doses

Preparo/administração: Completar com SF 0,9% até volume do nebulizador

Monitorização: FC, tremor, K, lactato em doses repetidas

Cautelas: Associar ipratrópio nas crises graves iniciais

Situação: Diretriz pediátrica

Indicação 2: Estado de mal asmático — nebulização contínua

Via: Nebulização contínua

Apresentação: 5 mg/mL

Dose: 0,3–0,5 mg/kg/h

Máximo: 10–20 mg/h conforme peso/protocolo

Intervalo: contínuo, reavaliar frequentemente

Preparo/administração: Preparar no sistema de nebulização contínua conforme protocolo

Monitorização: ECG, K, lactato, glicemia, resposta

Cautelas: UTI/sala vermelha; risco de taquiarritmia e hipocalemia

Situação: Off-label por regime contínuo

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.217 — Salmeterol

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via: Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão

Situação: Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate

Indicação 2: Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via: Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão

Situação: Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.218 — Secnidazol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via: VO ou tópica conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais

Situação: Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.219 — Sertaconazol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via: Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância

Situação: Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.220 — Simeticona

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Distensão/gases — alívio sintomático quando indicado

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Benefício variável; não mascara sinais de abdome agudo

Situação: Dose fixa por faixa etária e concentração do produto; não converter sem selecionar apresentação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.221 — Sinvastatina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg

Situação: Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.222 — Sobrerol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Secreção respiratória espessa — uso mucolítico apenas quando individualmente indicado

Via: VO ou inalatória conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Pode aumentar volume de secreções/broncoespasmo; contraindicações e idade mínima variam por produto

Situação: Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; resposta depende da idade e apresentação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.223 — Solução de reidratação oral (SRO)

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Alguma desidratação — Plano B

Via: VO/SNG

Apresentação: SRO baixa osmolaridade pronta ou sachê corretamente diluído

Dose: 75 mL/kg em 4 h

Máximo: guiar por resposta e perdas

Intervalo: fracionado continuamente

Preparo/administração: Pequenos volumes frequentes; manter aleitamento

Monitorização: Perfusão, diurese, vômitos, peso

Cautelas: Desnutrição grave e choque exigem protocolo específico

Situação: Diretriz OMS

Indicação 2: Reposição de perdas contínuas

Via: VO

Apresentação: SRO baixa osmolaridade

Dose: <2 anos: 50–100 mL; 2–10 anos: 100–200 mL após cada evacuação; alternativa 10 mL/kg

Máximo: conforme sede/perdas

Intervalo: após cada evacuação/vômito

Preparo/administração: Oferecer com copo/colher/seringa

Monitorização: Hidratação e aceitação

Cautelas: Não diluir incorretamente o sachê

Situação: Diretriz pediátrica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.224 — Somatropina (Hormônio do crescimento)

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Terapia endócrina de reposição — acompanhamento especializado

Via: VO ou SC conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não calcular superfície corporal sem altura; monitorar crescimento e exames específicos

Situação: Dose individualizada por idade, diagnóstico, alvo laboratorial e, às vezes, superfície corporal

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.225 — Soro glicosado 10%

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Hipoglicemia sintomática

Via: EV/IO

Apresentação: 100 mg/mL

Dose: <6 meses: 2,5-5 mL/kg; ≥6 meses: 5 mL/kg

Máximo: 25 g de glicose/dose

Intervalo: bolus em 2-5 min; reavaliar glicemia em 5-10 min

Preparo/administração: Solução pronta; acesso seguro

Monitorização: Glicemia seriada, extravasamento

Cautelas: Tratar causa e iniciar GIR de manutenção se necessário

Situação: Diretriz pediátrica

Indicação 2: Infusão para aporte de glicose

Via: EV em BIC

Apresentação: SG 10% = 100 mg/mL de glicose

Dose: GIR inicial de referência 4-8 mg/kg/min; individualizar por idade, glicemia e contexto

Máximo: titular à glicemia

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: Usar SG 10% pronta ou preparo validado. Fórmula: mL/h = GIR (mg/kg/min) × peso × 60 ÷ 100 mg/mL.

Monitorização: Glicemia, Na, balanço

Cautelas: RN/lactentes requerem protocolo específico; não confundir com manutenção isotônica

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.226 — Soro glicosado 5%

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Componente/diluyente de solução de manutenção

Via: EV

Apresentação: Solução isotônica de manutenção com dextrose/K quando indicados; SG 5% isolado não é padrão

Dose: Integrar a solução isotônica; ver aba Soroterapia 100%

Máximo: individualizar

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: A coluna H calcula a manutenção horária pela regra 4-2-1. O valor é da solução final prescrita, não de SG 5% isolado. Ajustar para doença renal/cardíaca, SIADH, neonatos e perdas.

Monitorização: Na, glicemia, balanço

Cautelas: Não usar isolado para manutenção em 28 d-18 a sem indicação específica

Situação: Diretriz: não usar isoladamente como manutenção rotineira

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.227 — Soro glicosado 50%

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Preparo de soluções menos concentradas

Via: EV somente após diluição pediátrica

Apresentação: SG 50% = 500 mg/mL; usar somente para preparo/diluição validada

Dose: Não administrar em bolus direto rotineiro em criança

Máximo: —

Intervalo: conforme preparo

Preparo/administração: Para 100 mL de SG 10%: retirar 20 mL de SG 50% e completar com 80 mL de diluente compatível. Homogeneizar e rotular; não administrar SG 50% em bolus pediátrico.

Monitorização: Conferir glicose final e osmolaridade

Cautelas: Risco elevado de flebite/necrose; farmácia/protocolo

Situação: Uso como concentrado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.228 — Soro polieletrólítico balanceado

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Choque/hipoperfusão — bolus

Via: EV/IO

Apresentação: Ringer lactato/Plasma-Lyte ou equivalente

Dose: 10–20 mL/kg

Máximo: reavaliar antes de repetir

Intervalo: em 5–20 min

Preparo/administração: Solução pronta; aquecer se grande volume

Monitorização: Perfusão, PA, sinais de sobrecarga

Cautelas: Ringer contém cálcio: não coadministrar ceftriaxona em RN; não é contraindicação automática na hipercalemia

Situação: Diretriz pediátrica

Indicação 2: Reposição de desidratação/deficit

Via: EV

Apresentação: Cristaloide balanceado; volume depende da avaliação clínica

Dose: déficit estimado 50–100 mL/kg para desidratação de 5–10%; somar manutenção e perdas separadamente

Máximo: evitar automatizar sem clínica/laboratório

Intervalo: contínuo

Preparo/administração: Estimativa: déficit (mL) = peso (kg) × % de desidratação × 10. A faixa H usa 5–10%; reavaliar e não infundir automaticamente como bolus único.

Monitorização: Na, K, glicemia, balanço

Cautelas: DKA, desnutrição grave, queimado e RN têm protocolos próprios

Situação: Diretriz pediátrica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.229 — Sucralfato

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Doença ácido-péptica — uso selecionado

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar interações e função renal; não usar ranitidina disponível de origem não autorizada

Situação: Ranitidina permanece suspensa/retirada por risco de NDMA; não gerar dose

Indicação 2: Refluxo gastroesofágico — uso selecionado

Via: VO ou EV conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar interações e função renal; não usar ranitidina disponível de origem não autorizada

Situação: Ranitidina permanece suspensa/retirada por risco de NDMA; não gerar dose

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.230 — Sulfadiazina de prata

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Indicação 2: Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.231 — Sulfametoxazol + Trimetoprima

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.232 — Sulfato de magnésio

Linhas cadastradas: 3. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Asma grave refratária ao tratamento inicial

Via: EV

Apresentação: 10% = 100 mg/mL

Dose: 25-50 mg/kg

Máximo: 2 g

Intervalo: dose única em 20-30 min

Preparo/administração: Diluir em 50-100 mL conforme restrição hídrica

Monitorização: PA, FR, reflexos, diurese

Cautelas: Cautela em IR e bloqueio neuromuscular

Situação: Diretriz pediátrica

Indicação 2: Eclâmpsia — adolescente/adulta

Via: EV em BIC

Apresentação: Sulfato de magnésio 10% ou 50%; ataque obstétrico 4-6 g

Dose: Seguir protocolo obstétrico

Máximo: 4-6 g de ataque; 1-2 g/h

Intervalo: contínuo após ataque

Preparo/administração: Aspirar 40-60 mL da solução 10% OU 8-12 mL da solução 50%; diluir e administrar conforme protocolo obstétrico. Linha destinada a adolescente/adulta.

Monitorização: FR, reflexos, diurese, Mg

Cautelas: Gluconato de cálcio disponível como antídoto

Situação: Diretriz obstétrica; não é dose pediátrica por peso

Indicação 3: Torsades de pointes/hipomagnesemia com arritmia

Via: EV/IO

Apresentação: 100 mg/mL

Dose: 25-50 mg/kg

Máximo: 2 g

Intervalo: em 10-20 min; mais rápido se PCR

Preparo/administração: Diluir conforme urgência e protocolo

Monitorização: ECG, PA, reflexos

Cautelas: Ajustar em IR

Situação: Diretriz pediátrica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.233 — Surfactante pulmonar (porcino/bovino)

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Síndrome do desconforto respiratório neonatal — resgate

Via: Intratraqueal

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Administrar por equipe neonatal treinada; ajustar ventilação e monitorar bradicardia/dessaturação

Situação: Dose depende do produto (poractanto/beractanto); selecionar marca e concentração

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.234 — Suxametônio (succinilcolina)

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Sequência rápida de intubação — bloqueio neuromuscular

Via: EV

Apresentação: 20 mg/mL após reconstituição/preparo validado

Dose: <2 anos: 2 mg/kg; ≥2 anos: 1–1,5 mg/kg

Máximo: máximo conforme protocolo e peso

Intervalo: dose única; início rápido e curta duração

Preparo/administração: A linha exibe a faixa 1–2 mg/kg; selecionar a dose pela idade antes de programar

Monitorização: ECG, SpO₂, ETCO₂, ventilação e temperatura

Cautelas: Evitar em hipercalemia/risco, miopatia, queimadura/denervação tardia, hipertermia maligna e após imobilização prolongada

Situação: Uso pediátrico restrito; avaliar contraindicações antes da administração

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.235 — Teicoplanina

Linhas cadastradas: 61. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Diarreia ou colite por *Clostridioides difficile* associada a antibiótico — adolescente >16 a 18 anos

Via: VO após reconstituição

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 200 mg/dose

Máximo: não extrapolar esta linha para ≤ 16 anos

Intervalo: 12/12 h por 7–14 dias

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente e administrar 1,6 mL da solução de 125 mg/mL por via oral.

Monitorização: Resposta clínica, frequência das evacuações e recorrência

Cautelas: Uso oral específico desta indicação; não usar esta linha para infecção sistêmica.

Situação: Indicação e esquema de adulto na bula profissional brasileira; confirmar infectologia e alternativa de primeira linha

Indicação 2: Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, ataque EV

Via: EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg/dose

Máximo: em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização de níveis

Intervalo: 12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg

Indicação 3: Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, manutenção EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg/dose

Máximo: endocardite por *S. aureus* ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização

Intervalo: 24/24 h, após a dose de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar por EV ou IM profunda.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg

Indicação 4: Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤ 85 kg, ataque EV

Via: EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 400 mg/dose

Máximo: se >85 kg, usar 6 mg/kg; em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização

Intervalo: 12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos

Indicação 5: Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, manutenção EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 400 mg/dose

Máximo: se >85 kg, usar 6 mg/kg; endocardite por *S. aureus* ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização

Intervalo: 24/24 h, após a dose de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV ou IM profunda.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos

Indicação 6: Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, ataque EV

Via: EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose

Máximo: usar o número de frascos necessário; confirmar protocolo e níveis séricos em infecção grave

Intervalo: 12/12 h nas 3 primeiras doses

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; criança acima de 2 meses até 16 anos

Indicação 7: Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção grave/neutropenia EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose

Máximo: monitorar níveis séricos e ajustar manutenção por função renal após o 4º dia

Intervalo: 24/24 h, após as 3 doses de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; manutenção de infecção grave por Gram-positivo ou criança neutropênica, acima de 2 meses até 16 anos

Indicação 8: Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção não grave EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg/dose

Máximo: ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados

Intervalo: 24/24 h, após as 3 doses de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; manutenção de infecção por Gram-positivo em geral, acima de 2 meses até 16 anos

Indicação 9: Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, ataque EV

Via: EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 16 mg/kg, dose única de ataque no primeiro dia

Máximo: confirmar idade gestacional, função renal, indicação e protocolo neonatal

Intervalo: dose inicial única no primeiro dia

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses

Indicação 10: Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, manutenção EV

Via: EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 8 mg/kg/dose

Máximo: ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados

Intervalo: 24/24 h, após a dose de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses

Indicação 11: Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, ataque EV

Via: EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg/dose

Máximo: em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização de níveis

Intervalo: 12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg

Indicação 12: Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, manutenção EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg/dose

Máximo: endocardite por *S. aureus* ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização

Intervalo: 24/24 h, após a dose de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar por EV ou IM profunda.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg

Indicação 13: Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, ataque EV

Via: EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 400 mg/dose

Máximo: se >85 kg, usar 6 mg/kg; em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização

Intervalo: 12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos

Indicação 14: Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, manutenção EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 400 mg/dose

Máximo: se >85 kg, usar 6 mg/kg; endocardite por *S. aureus* ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização

Intervalo: 24/24 h, após a dose de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV ou IM profunda.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos

Indicação 15: Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, ataque EV

Via: EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose

Máximo: usar o número de frascos necessário; confirmar protocolo e níveis séricos em infecção grave

Intervalo: 12/12 h nas 3 primeiras doses

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; criança acima de 2 meses até 16 anos

Indicação 16: Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção grave/neutropenia EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose

Máximo: monitorar níveis séricos e ajustar manutenção por função renal após o 4º dia

Intervalo: 24/24 h, após as 3 doses de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; manutenção de infecção grave por Gram-positivo ou criança neutropênica, acima de 2 meses até 16 anos

Indicação 17: Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção não grave EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg/dose

Máximo: ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados

Intervalo: 24/24 h, após as 3 doses de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; manutenção de infecção por Gram-positivo em geral, acima de 2 meses até 16 anos

Indicação 18: Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, ataque EV

Via: EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 16 mg/kg, dose única de ataque no primeiro dia

Máximo: confirmar idade gestacional, função renal, indicação e protocolo neonatal

Intervalo: dose inicial única no primeiro dia

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses

Indicação 19: Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, manutenção EV

Via: EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 8 mg/kg/dose

Máximo: ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados

Intervalo: 24/24 h, após a dose de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses

Indicação 20: Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, ataque EV

Via: EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg/dose

Máximo: em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização de níveis

Intervalo: 12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg

Indicação 21: Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, manutenção EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg/dose

Máximo: endocardite por *S. aureus* ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização

Intervalo: 24/24 h, após a dose de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar por EV ou IM profunda.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg

Indicação 22: Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, ataque EV

Via: EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 400 mg/dose

Máximo: se >85 kg, usar 6 mg/kg; em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização

Intervalo: 12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos

Indicação 23: Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, manutenção EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 400 mg/dose

Máximo: se >85 kg, usar 6 mg/kg; endocardite por *S. aureus* ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização

Intervalo: 24/24 h, após a dose de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV ou IM profunda.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos

Indicação 24: Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, ataque EV

Via: EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose

Máximo: usar o número de frascos necessário; confirmar protocolo e níveis séricos em infecção grave

Intervalo: 12/12 h nas 3 primeiras doses

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; criança acima de 2 meses até 16 anos

Indicação 25: Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção grave/neutropenia EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose

Máximo: monitorar níveis séricos e ajustar manutenção por função renal após o 4º dia

Intervalo: 24/24 h, após as 3 doses de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; manutenção de infecção grave por Gram-positivo ou criança neutropênica, acima de 2 meses até 16 anos

Indicação 26: Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção não

grave EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg/dose

Máximo: ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados

Intervalo: 24/24 h, após as 3 doses de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3-5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; manutenção de infecção por Gram-positivo em geral, acima de 2 meses até 16 anos

Indicação 27: Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, ataque EV

Via: EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 16 mg/kg, dose única de ataque no primeiro dia

Máximo: confirmar idade gestacional, função renal, indicação e protocolo neonatal

Intervalo: dose inicial única no primeiro dia

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses

Indicação 28: Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, manutenção EV

Via: EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 8 mg/kg/dose

Máximo: ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados

Intervalo: 24/24 h, após a dose de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses

Indicação 29: Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, ataque EV

Via: EV — injeção em 3-5 min ou infusão em 30 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg/dose

Máximo: em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização de níveis

Intervalo: 12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3-5 min ou diluir para infusão de 30 min.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg

Indicação 30: Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, manutenção EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg/dose

Máximo: endocardite por *S. aureus* ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização

Intervalo: 24/24 h, após a dose de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar por EV ou IM profunda.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg

Indicação 31: Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, ataque EV

Via: EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 400 mg/dose

Máximo: se >85 kg, usar 6 mg/kg; em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização

Intervalo: 12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos

Indicação 32: Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, manutenção EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 400 mg/dose

Máximo: se >85 kg, usar 6 mg/kg; endocardite por *S. aureus* ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização

Intervalo: 24/24 h, após a dose de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV ou IM profunda.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos

Indicação 33: Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, ataque EV

Via: EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose

Máximo: usar o número de frascos necessário; confirmar protocolo e níveis séricos em infecção grave

Intervalo: 12/12 h nas 3 primeiras doses

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; criança acima de 2 meses até 16 anos

Indicação 34: Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção grave/neutropenia EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose

Máximo: monitorar níveis séricos e ajustar manutenção por função renal após o 4º dia

Intervalo: 24/24 h, após as 3 doses de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; manutenção de infecção grave por Gram-positivo ou criança neutropênica, acima de 2 meses até 16 anos

Indicação 35: Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção não grave EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg/dose

Máximo: ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados

Intervalo: 24/24 h, após as 3 doses de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; manutenção de infecção por Gram-positivo em geral, acima de 2 meses até 16 anos

Indicação 36: Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, ataque EV

Via: EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 16 mg/kg, dose única de ataque no primeiro dia

Máximo: confirmar idade gestacional, função renal, indicação e protocolo neonatal

Intervalo: dose inicial única no primeiro dia

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses

Indicação 37: Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, manutenção EV

Via: EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 8 mg/kg/dose

Máximo: ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados

Intervalo: 24/24 h, após a dose de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses

Indicação 38: Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, ataque EV

Via: EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg/dose

Máximo: em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização de níveis

Intervalo: 12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg

Indicação 39: Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, manutenção EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg/dose

Máximo: endocardite por *S. aureus* ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização

Intervalo: 24/24 h, após a dose de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar por EV ou IM profunda.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg

Indicação 40: Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, ataque EV

Via: EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 400 mg/dose

Máximo: se >85 kg, usar 6 mg/kg; em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização

Intervalo: 12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos

Indicação 41: Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, manutenção EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 400 mg/dose

Máximo: se >85 kg, usar 6 mg/kg; endocardite por *S. aureus* ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização

Intervalo: 24/24 h, após a dose de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV ou IM profunda.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos

Indicação 42: Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, ataque EV

Via: EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose

Máximo: usar o número de frascos necessário; confirmar protocolo e níveis séricos em infecção grave

Intervalo: 12/12 h nas 3 primeiras doses

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; criança acima de 2 meses até 16 anos

Indicação 43: Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção grave/neutropenia EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose

Máximo: monitorar níveis séricos e ajustar manutenção por função renal após o 4º dia

Intervalo: 24/24 h, após as 3 doses de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; manutenção de infecção grave por Gram-positivo ou criança neutropênica, acima de 2 meses até 16 anos

Indicação 44: Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção não grave EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg/dose

Máximo: ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados

Intervalo: 24/24 h, após as 3 doses de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; manutenção de infecção por Gram-positivo em geral, acima de 2 meses até 16 anos

Indicação 45: Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, ataque EV

Via: EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 16 mg/kg, dose única de ataque no primeiro dia

Máximo: confirmar idade gestacional, função renal, indicação e protocolo neonatal

Intervalo: dose inicial única no primeiro dia

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses

Indicação 46: Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, manutenção EV

Via: EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 8 mg/kg/dose

Máximo: ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados

Intervalo: 24/24 h, após a dose de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses

Indicação 47: Peritonite associada à diálise peritoneal ambulatorial contínua — adolescente >16 a 18 anos

Via: Ataque EV seguido de administração intraperitoneal na bolsa de diálise

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: Ataque de 400 mg EV; depois 20 mg/L por bolsa na 1ª semana, 20 mg/L em bolsas alternadas na 2ª e 20 mg/L na bolsa noturna na 3ª

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: conforme cada bolsa e a semana do tratamento

Preparo/administração: Preparação intraperitoneal exclusivamente pela equipe de diálise/farmácia, com técnica asséptica e protocolo institucional.

Monitorização: Efluente, culturas, resposta peritoneal, função renal residual e níveis quando indicados

Cautelas: Não converter automaticamente para mL sem conhecer o volume exato de cada bolsa e o protocolo nefrológico.

Situação: Bula profissional brasileira; regime por volume da bolsa, não pelo peso corporal

Indicação 48: Peritonite associada à diálise peritoneal ambulatorial contínua — criança/adolescente até 16 anos

Via: Via intraperitoneal sob protocolo de diálise

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: Definir concentração por litro e esquema com nefrologia pediátrica, infectologia e farmácia clínica

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: conforme cada bolsa e protocolo pediátrico institucional

Preparo/administração: Preparação intraperitoneal exclusivamente pela equipe de diálise/farmácia, com técnica asséptica.

Monitorização: Efluente, culturas, resposta peritoneal, função renal residual e níveis quando indicados

Cautelas: Não aplicar automaticamente o regime fixo de adulto a crianças.

Situação: A bula brasileira descreve o regime intraperitoneal sem estratificação pediátrica; cálculo não automatizado nesta faixa

Indicação 49: Profilaxia de endocardite por Gram-positivo em cirurgia dental — adolescente >16 a 18 anos e >85 kg

Via: EV na indução anestésica

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg, dose única

Máximo: dose única; confirmar protocolo perioperatório

Intervalo: dose única no momento da indução anestésica

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e administrar por EV.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Indicação e esquema de adulto na bula profissional brasileira; confirmar cardiologia/infectologia

Indicação 50: Profilaxia de endocardite por Gram-positivo em cirurgia dental — adolescente >16 a 18 anos e ≤85 kg

Via: EV na indução anestésica

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 400 mg, dose única

Máximo: se >85 kg, usar 6 mg/kg

Intervalo: dose única no momento da indução anestésica

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Indicação e esquema de adulto na bula profissional brasileira; confirmar cardiologia/infectologia

Indicação 51: Profilaxia de infecção por Gram-positivo em cirurgia ortopédica ou vascular — adolescente >16 a 18 anos e >85 kg

Via: EV na indução anestésica

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg, dose única

Máximo: dose única; confirmar protocolo perioperatório

Intervalo: dose única no momento da indução anestésica

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e administrar por EV.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Indicação e esquema de adulto na bula profissional brasileira; confirmar protocolo cirúrgico

Indicação 52: Profilaxia de infecção por Gram-positivo em cirurgia ortopédica ou vascular — adolescente >16 a 18 anos e ≤85 kg

Via: EV na indução anestésica

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 400 mg, dose única

Máximo: se >85 kg, usar 6 mg/kg

Intervalo: dose única no momento da indução anestésica

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Indicação e esquema de adulto na bula profissional brasileira; confirmar protocolo cirúrgico

Indicação 53: Sepses por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, ataque EV

Via: EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg/dose

Máximo: em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização de níveis

Intervalo: 12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg

Indicação 54: Sepses por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, manutenção EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg/dose

Máximo: endocardite por *S. aureus* ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização

Intervalo: 24/24 h, após a dose de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar por EV ou IM profunda.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg

Indicação 55: Sepses por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, ataque EV

Via: EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 400 mg/dose

Máximo: se >85 kg, usar 6 mg/kg; em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização

Intervalo: 12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos

Indicação 56: Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, manutenção EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 400 mg/dose

Máximo: se >85 kg, usar 6 mg/kg; endocardite por *S. aureus* ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização

Intervalo: 24/24 h, após a dose de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV ou IM profunda.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos

Indicação 57: Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, ataque EV

Via: EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose

Máximo: usar o número de frascos necessário; confirmar protocolo e níveis séricos em infecção grave

Intervalo: 12/12 h nas 3 primeiras doses

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; criança acima de 2 meses até 16 anos

Indicação 58: Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção grave/neutropenia EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 10 mg/kg/dose

Máximo: monitorar níveis séricos e ajustar manutenção por função renal após o 4º dia

Intervalo: 24/24 h, após as 3 doses de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; manutenção de infecção grave por Gram-positivo ou criança neutropênica, acima de 2 meses até 16 anos

Indicação 59: Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção não grave EV/IM

Via: EV ou IM profunda

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 6 mg/kg/dose

Máximo: ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados

Intervalo: 24/24 h, após as 3 doses de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; manutenção de infecção por Gram-positivo em geral, acima de 2 meses até 16 anos

Indicação 60: Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, ataque EV

Via: EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 16 mg/kg, dose única de ataque no primeiro dia

Máximo: confirmar idade gestacional, função renal, indicação e protocolo neonatal

Intervalo: dose inicial única no primeiro dia

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses

Indicação 61: Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, manutenção EV

Via: EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido

Apresentação: Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL

Dose: 8 mg/kg/dose

Máximo: ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados

Intervalo: 24/24 h, após a dose de ataque

Preparo/administração: Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.

Monitorização: Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados

Cautelas: Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.

Situação: Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.236 — Teofilina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Broncoespasmo — terapia adjuvante selecionada, não de primeira linha

Via: VO ou EV conforme fármaco/produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Janela terapêutica estreita para xantinas; revisar interações, arritmia, convulsão e níveis quando aplicável

Situação: Referência documental; benefício-risco e papel atual devem ser confirmados

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.237 — Terbinafina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via: Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância

Situação: Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.238 — Terbutalina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Broncoespasmo agudo — alternativa beta-2 agonista conforme protocolo

Via: Inalatória ou EV conforme cenário

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Monitorar FC, K, glicemia e lactato em doses repetidas/infusão; preferir protocolo de asma

Situação: Selecionar formulação, via e faixa etária antes do cálculo

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.239 — Tetraciclina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.240 — Tioconazol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via: Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância

Situação: Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.241 — Tirotricina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Indicação 2: Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.242 — Tobramicina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Indicação 2: Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.243 — Tolnaftato

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via: Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância

Situação: Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.244 — Topiramato

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica

Situação: Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.245 — Tramadol

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dor moderada/intensa — opção opioide selecionada por protocolo e idade

Via: VO, EV, IM ou transmucosa conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Monitorar ventilação/sedação; codeína e tramadol têm restrições importantes em menores de 12 anos e após adenoamigdalectomia

Situação: Uso restrito; resposta condicionada às contraindicações etárias e à variabilidade metabólica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.246 — Triancinolona

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Doença inflamatória/alérgica específica — corticoide sistêmico ou tópico

Via: VO, IM, tópica ou intra-articular conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; avaliar duração, desmame e imunossupressão

Situação: Potência e equivalência variam; selecionar indicação e formulação antes de calcular

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.247 — Trimetoprima + Sulfadiazina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via: Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship

Situação: Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.248 — Urapidil

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Emergência hipertensiva

Via: EV

Apresentação: Ampola 50 mg/10 mL = 5 mg/mL, porém sem dose pediátrica validada

Dose: Sem dose pediátrica de consulta rápida validada para esta planilha

Máximo: usar somente protocolo especializado

Intervalo: bolus/infusão conforme centro

Preparo/administração: Não gerar volume a partir de dose adulta. Selecionar agente pediátrico/protocolo institucional.

Monitorização: PA contínua

Cautelas: Preferir labetalol/nicardipina/nitroprussiato conforme etiologia e protocolo

Situação: Off-label; dados pediátricos limitados

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.249 — Ureia

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Desbridamento enzimático de lesão selecionada

Via: Tópica

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Proteger pele íntegra; confirmar indicação e curativo/protocolo de feridas

Situação: Aplicação depende da concentração, área e tipo de lesão; não calcular por peso

Indicação 2: Hidratação cutânea de lesão selecionada

Via: Tópica

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Proteger pele íntegra; confirmar indicação e curativo/protocolo de feridas

Situação: Aplicação depende da concentração, área e tipo de lesão; não calcular por peso

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.250 — Valproato sódico (Ácido valproico)

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica

Situação: Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.251 — Vancomicina

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção grave por MRSA/Gram-positivo resistente

Via: EV

Apresentação: Frasco 500 mg ou 1 g; 50 mg/mL reconstituído; 5 mg/mL final

Dose: 15 mg/kg/dose

Máximo: 750–1000 mg/dose conforme serviço

Intervalo: a cada 6 h inicialmente; individualizar por AUC

Preparo/administração: Reconstituir 500 mg com 10 mL ou 1 g com 20 mL = 50 mg/mL. Diluir adicionalmente para 5 mg/mL; infundir por ≥ 60 min e mais lento conforme dose/reação.

Monitorização: AUC/MIC alvo 400–600, creatinina, reação infusional

Cautelas: Ajustar por função renal e TDM; não usar dose fixa sem monitorização

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Indicação 2: Meningite ou infecção do SNC por Gram-positivo resistente

Via: EV

Apresentação: Frasco 500 mg ou 1 g; 50 mg/mL reconstituído; 5 mg/mL final

Dose: 15 mg/kg/dose

Máximo: monitorar AUC; 60 mg/kg/dia inicial frequente

Intervalo: a cada 6 h

Preparo/administração: Reconstituir 500 mg com 10 mL ou 1 g com 20 mL = 50 mg/mL. Diluir adicionalmente para 5 mg/mL; infundir por ≥ 60 min e mais lento conforme dose/reação.

Monitorização: AUC, culturas/LCR, função renal

Cautelas: Infectologia/farmácia clínica; ajustar à MIC e foco

Situação: Uso pediátrico estabelecido

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.252 — Vigabatrina

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica

Situação: Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.253 — Vitamina A

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica

Via: VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI

Situação: Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.254 — Vitamina B1 (Tiamina)

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica

Via: VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI

Situação: Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.255 — Vitamina B12

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica

Via: VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI

Situação: Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.256 — Vitamina B5 (Dexpantenol)

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica

Via: VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI

Situação: Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.257 — Vitamina B6 (Piridoxina)

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica

Via: VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI

Situação: Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.258 — Vitamina C

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica

Via: VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI

Situação: Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.259 — Vitamina E

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica

Via: VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI

Situação: Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.260 — Zafirlucaste

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via: Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão

Situação: Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate

Indicação 2: Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via: Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão

Situação: Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.261 — Ácido acetilsalicílico (Aspirina)

Linhas cadastradas: 3. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Antiagregação após fase aguda da doença de Kawasaki

Via: VO

Apresentação: Apresentação brasileira variável; confirmar produto e concentração com registro vigente na Anvisa

Dose: Dose antiagregante depende do protocolo; não automatizada nesta linha

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Risco de sangramento e síndrome de Reye; suspender/ajustar conforme infecção viral e orientação especializada

Situação: Uso pediátrico específico sob protocolo/cardiopediatria

Indicação 2: Doença de Kawasaki — antiagregação plaquetária

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Risco de sangramento e síndrome de Reye; dose varia entre fase inflamatória e antiagregante

Situação: Uso pediátrico específico; não usar como antitérmico em virose

Indicação 3: Doença de Kawasaki — fase inflamatória aguda

Via: VO

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Risco de sangramento e síndrome de Reye; dose varia entre fase inflamatória e antiagregante

Situação: Uso pediátrico específico; não usar como antitérmico em virose

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.262 — Ácido fusídico

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Indicação 2: Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via: Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Situação: Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.263 — Ácido mefenâmico

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Dor/inflamação ou indicação especializada — uso condicionado à idade e ao diagnóstico

Via: VO, retal ou tópica conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Evitar em desidratação, doença renal, sangramento GI e dengue; AAS não usar em virose salvo indicação específica

Situação: Resposta condicionada às restrições etárias e à indicação específica

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.264 — Ácido nalidíxico

Linhas cadastradas: 1. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Uso anti-infeccioso histórico — avaliar alternativa contemporânea

Via: Conforme produto histórico

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Não utilizar com base apenas em manual antigo; confirmar registro, disponibilidade e protocolo especializado

Situação: Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por obsolescência ou ausência de papel atual rotineiro

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

15.265 — Óleo mineral

Linhas cadastradas: 2. Esta ficha não implica prescrição automática.

Indicação 1: Constipação funcional — desimpactação

Via: VO ou retal conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias

Situação: Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação

Indicação 2: Constipação funcional — manutenção

Via: VO ou retal conforme produto

Apresentação: Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente

Dose: Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas

Máximo: Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo: Conforme indicação/produto

Preparo/administração: Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização: Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco

Cautelas: Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias

Situação: Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação

Regra de habilitação: confirmar correspondência diagnóstica, faixa etária, peso, contraindicações, interações, função renal/hepática, apresentação realmente dispensada e fonte atual antes de incluir na prévia consolidada.

16. Auditoria do PDF Antitérmicos Pediátricos — doses corrigidas

— Material anexado de 3 páginas, revisão declarada em 26/07/2026, usado como fonte complementar de cálculo e segurança.

— Dipirona: 10–20 mg/kg/dose; apresentações documentadas 50, 100 e 500 mg/mL. Restrição registrada: não usar abaixo de 3 meses ou 5 kg.

— Paracetamol: 10–15 mg/kg/dose; apresentações documentadas 200, 100 e 32 mg/mL. Não aplicar regra de gotas sem conferir o gotejador.

— Ibuprofeno: 5–10 mg/kg/dose, em geral a partir de 6 meses; apresentações 20, 50 e 100 mg/mL; evitar em desidratação, doença renal, risco hemorrágico e varicela.

— Cetoprofeno: gotas 20 mg/mL, não antitérmico de primeira escolha; uso pediátrico condicionado e curta duração.

— Ondansetrona: solução oral 4 mg/5 mL, solução injetável 2 mg/mL e comprimidos/ODT 4 ou 8 mg; indicação selecionada, com avaliação de QT, eletrólitos e interações.

— O projeto automatiza apenas apresentações e contextos adequados à receita domiciliar. Formas injetáveis permanecem fora da prévia domiciliar e exigem ambiente assistencial.

17. Fontes e URLs de referência

— Prefeitura de Belo Horizonte - protocolo de otite média aguda:

<https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/protocolo-otite-media-aguda.pdf>

— Sociedade Brasileira de Pediatria - sinusite nas crianças:

<https://www.sbp.com.br/pediatria-para-familias/doencas/sinusite-nas-criancas/>

— Anvisa - segurança na prescrição: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesau/publicacoes/protocolo-de-seguranca-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos>

— Anvisa - Instrução Normativa 120/2022 e apresentações de dipirona: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br>

— Site do projeto: <https://prescricao-pediatrica-segura.iagovalmeida.chatgpt.site/>

Fim do manual integral. Toda expansão futura deve preservar bloqueios de segurança e registrar a diferença entre catálogo, opção condicionada e prescrição definitiva.